# Prompt do Sim

Marketing, inteligência artificial e CRM
para profissionais da saúde.




CliniLoop

Conhecimento que vira ação.

← Voltar

# Sumário

INÍCIO


Apresentação 9

O mundo comum 9

O chamado 9

A recusa do chamado 11

O encontro com o mentor 12

A bússola: uma hipótese, não uma promessa 13

A ferramenta do herói: o Oceano Azul 13

O código do herói: o limite ético da diferença 15

O preço da travessia 15

Como esta história está contada 16

As jornadas do paciente 17

Sete famílias de caminhos 17

As jornadas se cruzam 19

O que o guia e o app otimizam 19

O que fica de fora, e por quê 19

Cada jornada com o seu nome no CRM 20

Antes de começar 22

O terreno é diferente 22

Para quem é 23

Para quem não é 23

Como ler 23

Como escrever um bom prompt 24

As quatro regras de uso da IA 26

Como começar 27

1. Uma conta em uma ferramenta de IA 27

2. As contas nas redes e no Google 28

3. Os módulos do CliniLoop 29

4. Um rascunho do seu diferencial 30

SEU ROTEIRO

Seu roteiro em seis etapas 31

As seis etapas 31

Não sabe por onde começar? 33

Plano de 30 dias 33

Marcos de referência 37

ETAPA 1 · ENTENDA O JOGO E AS REGRAS

01 A jornada das sete decisões 39

As sete decisões 40

Duas portas de entrada 41

O papel de cada canal 42

O caminho entre os canais não é uma linha reta 43

02 Ética primeiro: conselhos e LGPD 47

Regras que valem para todas as profissões 48

O que muda por profissão 49

Diferenciar dentro das regras 52

LGPD: dado de saúde é dado sensível 53

Políticas das plataformas 53

A revisão em duas etapas 54

ETAPA 2 · POSICIONE-SE

03 Os canais, um a um: manual de configuração 56

Primeiro a proposta de valor 57

Perfil da Empresa no Google 59

Instagram 61

YouTube 64

LinkedIn 66

TikTok 70

← Voltar

Onde tudo converge: WhatsApp Business e CRM 71

ETAPA 3 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

04 Conteúdo que gera autoridade e alcance 75

Conteúdo que só você poderia publicar 76
O que o Instagram premia 77
A escada de crescimento 77
Três temas de conteúdo por profissão 79
O que você sabe e o que você atende 80
Pautas pela jornada do paciente 81
Formatos recorrentes: séries que o público reconhece 82
Roteiro de Reel para saúde 83
YouTube, carrossel e Stories 84
Gravação e confiança na câmera 84
Frequência sustentável 85
Medir sem confundir grandeza com resultado 85
Ser citado, não só publicar 88
Estruturas que vale adaptar 89

05 Reaproveitamento: uma aula, quatro entregas 94

Por que reaproveitar diferencia 95
Fontes boas e fontes proibidas 95
Do episódio ao conjunto de peças 96
As quatro entregas 97
Comentário que leva ao guia 97
Bastidores como fonte de conteúdo 97
A página da bio como próximo passo 98
Comece com um piloto pequeno 98

06 Vídeo: como produzir com o que você tem 102

Por que vídeo 103
O kit por nível 103
Celular ou câmera 104
Luz 105

Som 106
Fundo e cenário 106
Enquadramento e postura: como se posicionar diante da câmera 107
Teleprompter: falar o texto sem decorar 107
A sessão de gravação 109
Perder o medo da câmera 109

07 Edição de vídeo: das ferramentas nativas às externas 112

O que a edição precisa resolver 113
Três níveis de ferramenta 114
Comparativo 114
Como escolher 116
Legendas automáticas: revise sempre 117
Avatares e voz por IA: o que pode e o que não pode 117
Imagens com IA para capas, carrosséis e apoio 118
Exportar sem perder qualidade 118

08 A decisão dos colegas: a rede de indicação 121

Por que o colega indica você 122
Quem indica quem 122
Os cinco movimentos da indicação 123
Collabs entre colegas 124

09 Anúncios: Meta Ads e Google Ads 128

Anúncio amplifica o que já é seu 129
Se você trabalha com agência ou gestor de tráfego 130
Qual plataforma para qual intenção 131
Meta Ads passo a passo 132
Google Ads passo a passo 133
Que tipo de mensagem funciona (e é ética) 134
Impulsionamento na Meta: manual passo a passo 137

ETAPA 4 · CONVERTA CONTATOS EM CONSULTAS

10 Do clique à consulta: a decisão de agendar 143

Padrões de atendimento 144

← Voltar

Duas conversas diferentes 144
Roteiro de agendamento em cinco mensagens 145
Quando o paciente pergunta o preço primeiro 145
Quem não agendou na hora 146

11 A decisão de comparecer 149

Sequência de confirmação 150
Boas práticas 151
Comparecimento por origem 151

ETAPA 5 · FECHE E ACOMPANHE O TRATAMENTO

12 A decisão de tratar: fechamento com ética 153

Por que é preciso um processo de fechamento 154
Onde a diferença é cumprida 154
O fechamento em cinco momentos 155
Fisioterapia: da avaliação à alta 155
Clínicas multiprofissionais e odontológicas 156
Objeções comuns e respostas honestas 157

ETAPA 6 · MEÇA E ESCALE COM CRM

13 O CRM: a gestão do relacionamento com o paciente 161

O funil do paciente em sete etapas 162
O funil dos colegas 163
O que registrar (e o que ignorar) 163
Métricas que importam 164
A conta da hipótese 165
O ritual semanal de 30 minutos 166
Automações que valem a pena 166

14 O app CliniLoop: guia das ferramentas 170

O que o app faz por você 171
O caminho em nove passos 172
Tutorial: o primeiro uso, passo a passo 175

Do guia à ferramenta 184
Status do Rastreador de pacientes 186
O que fica registrado 187
Privacidade e dados 187
Clínicas com vários usuários 188

15 Gerador de campanhas e biblioteca de prompts 190

A ficha da campanha 191
Quatro modelos de campanha 194
Biblioteca de prompts deste guia 195

16 Ferramentas para materializar as campanhas 199

Mapa de ferramentas por necessidade 200
Delegar sem perder a diferença 202

ANEXOS

Manual prático: criar, editar, publicar e anunciar 204

1. Antes de criar: posicione-se 204
2. Edição nativa: dentro das próprias redes 207
3. CapCut, passo a passo 209
4. Canva, passo a passo 210
5. HeyGen, passo a passo 212
6. Imagens com IA, ferramenta por ferramenta 212
7. Anúncio no Instagram, passo a passo 215
8. Anúncio no TikTok, passo a passo 217
9. Checklist final de publicação 219

Glossário 220

Dados de mercado e comparação 226

Dados que conseguimos verificar 226
Comparação com o que existe hoje 227

Os caminhos intermediados: convênios, plataformas, hospitais e a porta da rua 230

Por que eles importam 230

Convênios e planos de saúde 231
Plataformas de agendamento 231
Hospitais, plantões e pronto atendimento 232
A porta da rua 232
De conveniência a confiança 233
Fontes e agradecimentos 235
Agradecimentos 235
Bibliografia 236
Antes de publicar 238

APRESENTAÇÃO

# Apresentação

*Toda boa história começa com alguém competente diante de um mundo que mudou. Esta é a sua. O herói é você; este guia e o app que o acompanha são o mentor que aparece no caminho.*

## O mundo comum

Você estudou anos para fazer bem uma coisa: cuidar de pessoas. Fez residência, especialização, cursos, congressos. Atende com cuidado, explica com paciência, acompanha cada caso. Os pacientes que chegam até você costumam ficar, e muitos voltam com a família.

E mesmo assim há semanas com buracos na agenda. Há colegas com metade da sua formação e o dobro de seguidores. Há o paciente que chamou no WhatsApp, perguntou o preço e sumiu. Ninguém na faculdade ensinou o que fazer com isso, porque durante muito tempo não foi preciso: o bom profissional era encontrado pela indicação, e a indicação bastava.

Esse é o mundo comum de quase todo profissional de saúde que chega a este guia. Não há nada de errado com ele, a não ser que ele mudou, e você talvez ainda não tenha mudado junto.

## O chamado

O paciente de hoje pesquisa antes de escolher. Ele vê um vídeo no ônibus, procura o seu nome no Google à noite, pergunta a uma inteligência artificial qual especialista procurar e confere as avaliações antes de mandar a primeira mensagem. A indicação continua valendo, mas agora ela também é conferida na tela.

Diante dessa mudança, o mercado oferece ao profissional dois caminhos. Eles usam as mesmas ferramentas, como Instagram, Google, anúncios e WhatsApp, mas apostam em coisas opostas.

**A fábrica de leads** aposta no volume. Uma agência ou um gestor de tráfego compra anúncios, cobra uma mensalidade e entrega contatos. Para escalar, o criativo costuma ser genérico: a mesma foto de banco de imagens, a mesma frase sobre "sorriso dos sonhos" ou "qualidade de vida", servindo a qualquer profissional da cidade. O paciente que chega por esse anúncio não sabe quem você é. Ele compara o que consegue comparar, e quase sempre isso é o preço, justamente o terreno em que os conselhos proíbem a disputa.

**A qualificação por diferenciação** aposta no contrário. O conteúdo nasce da sua experiência clínica, das dúvidas que você ouve e da forma como você explica. O paciente chega já sabendo quem você é e por que procurou você. E os colegas que indicam entram como um canal de verdade, cuidado com método.

| | Fábrica de leads | Qualificação por diferenciação |
|---|---|---|
| **O que se compra** | Volume: verba de anúncio e mensalidade da agência | Método e tempo seu: 25 a 30 minutos por dia, mais anúncio quando fizer sentido |
| **De onde vem o criativo** | Modelos genéricos, iguais para muitos clientes | Da sua experiência clínica, com a sua voz |
| **Como o paciente chega** | Sem saber quem você é, comparando preço | Sabendo quem você é e por que procurou você |
| **Papel dos colegas** | Quase nenhum | Canal de indicação, com carta, retorno e registro |
| **Onde o conselho pesa** | Na tentação de competir por preço e promessa | No cuidado de diferenciar sem superlativo nem promessa |
| **O que fica com você** | Os contatos do mês, enquanto a verba durar | A reputação, o conteúdo e o registro de cada relação |

O chamado deste guia é para o segundo caminho.

## A recusa do chamado

Em toda boa história, o herói hesita antes de partir. Na saúde, a hesitação costuma ter três vozes, e todas merecem resposta honesta.

**"Marketing não combina com a minha profissão."** Combina menos do que deveria, porque muito do que se vê por aí é sensacionalista, promete resultado e expõe pacientes. Mas o problema é o mau marketing, não a comunicação. Este guia trata a ética como estratégia: as regras dos conselhos fecham as portas do preço e da promessa, e por isso empurram você para o único jogo que vale a pena jogar, o da diferença demonstrada. A Parte 2 mostra como.

**"Não tenho tempo."** É a objeção mais séria, e ela é verdadeira. O caminho da diferenciação custa tempo, e ninguém faz por você o conteúdo que nasce da sua experiência. A boa notícia é que o tempo cabe numa rotina: de 25 a 30 minutos por dia útil no primeiro mês e um ritual de 30 minutos por semana depois. Se nem isso couber agora, é melhor saber antes de começar.

**"Vou contratar alguém e esquecer o assunto."** Você pode e talvez deva contratar ajuda, mas não pode terceirizar a sua diferença. Uma agência sabe comprar mídia; não sabe como você explica um exame a um paciente com medo. O guia não é contra anúncios nem contra agências. Ele apenas muda a ordem das coisas.

A IDEIA CENTRAL

**Anúncio amplifica o que já é seu.**
A Parte 9 ensina Meta Ads e Google Ads passo a passo. Primeiro você constrói a diferença; depois paga para que mais gente a veja. Se você já trabalha com uma agência, este guia ajuda a entregar a ela o que só você tem, como a proposta de valor, as dúvidas reais e os vídeos, para que o anúncio deixe de ser genérico.

# O encontro com o mentor

Nas histórias, o mentor não faz a jornada pelo herói. Ele aparece quando o herói hesita, entrega um mapa, algumas ferramentas e um conselho, e depois sai de cena para que o herói atravesse sozinho.

Este é o papel do **CliniLoop**, que tem três partes:

- **O guia, *O Prompt do Sim*,** é o mapa. São dezesseis partes, em seis etapas, e um manual prático no Anexo A. Cada parte explica o porquê, mostra o caminho e termina numa ação de até 30 minutos.
- **O módulo Redes e posicionamento** é a mochila de ferramentas. Nele você define a sua diferença com o Oceano Azul, e o app gera os prompts de inteligência artificial já preenchidos com o perfil do seu consultório, o seu diferencial e as regras do seu conselho: perfis, pautas, roteiros de vídeo, cartas aos colegas e campanhas. Funciona no computador e no celular.
- **O módulo CRM do consultório** é o caderno de bordo. Um quadro mostra em que etapa está cada contato, do primeiro "oi" ao tratamento, com a origem e o próximo passo. Ali também ficam as respostas do WhatsApp, o procedimento da recepção e o ritual da semana. Foi pensado para o computador do consultório.

CRM é a sigla, em inglês, de gestão do relacionamento com o cliente. No consultório, é o caderno de bordo da jornada: quem entrou em contato, de onde veio, em que etapa está e qual é o próximo passo.

Um mentor precisa ter passado por algum caminho parecido. O CliniLoop nasceu da soma de três experiências: décadas de trabalho executivo em marketing de bens de consumo, indústria farmacêutica e negócios entre empresas, na Europa e na América Latina; a incorporação de tecnologia e inteligência artificial à forma como um serviço chega a quem precisa dele; e a vivência de empreender na saúde, com uma clínica odontológica de várias especialidades. Dessa soma veio uma constatação: corpo clínico qualificado, espaço bonito e equipamentos modernos não garantem agenda cheia nem paciente que adere ao tratamento. O que faz diferença é um processo contínuo, medido e ético.

## A bússola: uma hipótese, não uma promessa

Todo herói precisa saber se está no rumo. A bússola deste guia é uma hipótese simples.

O gargalo da maioria dos consultórios não está em ser visto. Está depois do primeiro contato: o paciente chama e não agenda, agenda e não comparece, comparece e não segue o tratamento. A Parte 1 chama essas etapas de decisões 4 a 7. **A hipótese é que o paciente que chega por confiança tende a agendar, comparecer e aderir mais do que o que chega pelo preço.** Quem já assistiu às suas explicações, ou foi indicado por um colega em quem confia, entra na conversa com metade das objeções resolvidas.

É uma hipótese, e não uma promessa. Não existe um número universal que diga quanto a diferenciação reduz o custo de cada paciente, e este guia não inventa um. O que ele faz é dar a você um jeito de conferir a bússola no seu próprio consultório.

> ATENÇÃO
>
> **Teste no seu consultório, com os seus números.**
> O CRM registra a origem de cada contato. Depois de 90 dias, compare as origens: de cada grupo, quantos agendaram, quantos compareceram e quantos seguiram o tratamento? A Parte 13 mostra como fazer essa conta. Se os seus números não confirmarem a hipótese, eles mostram onde ajustar.

## A ferramenta do herói: o Oceano Azul

Diferenciar-se é fácil de dizer e difícil de fazer. Existe um oceano de bons profissionais com a mesma formação, os mesmos títulos e a mesma dedicação. Para sair da comparação, o guia empresta uma ferramenta da estratégia de empresas.

*A Estratégia do Oceano Azul*, de W. Chan Kim e Renée Mauborgne, professores do INSEAD, foi publicada em 2005. O livro estuda quem deixou de disputar o mesmo mercado com os mesmos argumentos e criou um espaço próprio, como o Cirque du Soleil, que reinventou o circo.

**Oceano Vermelho** é o mercado em que todos disputam os mesmos clientes com os mesmos argumentos. Na saúde, são dezenas de perfis parecidos, os mesmos posts de data comemorativa, a promessa de ser "o melhor" e a tentação do desconto. **Oceano Azul** é o espaço que você cria quando oferece um valor que os outros não oferecem, e a comparação direta perde importância. A ferramenta central são as **quatro ações**:

| Ação | Pergunta | Exemplo na saúde |
|---|---|---|
| **Eliminar** | O que o setor faz e o paciente não valoriza? | Posts de data comemorativa sem nenhum conteúdo |
| **Reduzir** | O que está acima do necessário? | Jargão técnico nas explicações ao paciente |
| **Elevar** | O que deveria estar bem acima do padrão? | Clareza sobre como funcionam a avaliação e o tratamento |
| **Criar** | O que o setor ainda não oferece? | Um quadro recorrente que responde às dúvidas reais do consultório |

Uma palavra de realismo. O livro fala de criar mercados novos, e a melhor fonte deles são os **não clientes**: as pessoas que poderiam precisar de você e não procuram ninguém da sua área. Às vezes um consultório encontra um espaço assim, como um público que ninguém atende bem na cidade. Na maioria das vezes, o resultado é mais modesto e igualmente útil: uma diferença clara dentro do mercado que já existe, suficiente para sair da comparação por preço. O guia não promete o primeiro e trabalha para garantir o segundo.

As quatro ações acompanham você por toda a travessia. **Em cada parte, uma caixa mostra o que eliminar, reduzir, elevar e criar naquela etapa**, do perfil no Google ao lembrete de consulta.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

É esta caixa. Ela aparece em todas as partes e traz as quatro ações aplicadas ao assunto da parte. No CliniLoop, a ferramenta
**Estratégia Oceano Azul**
guarda as suas escolhas e as leva para os prompts das outras ferramentas.

## O código do herói: o limite ético da diferença

Todo herói tem um código que não quebra, mesmo quando o atalho está ali. O seu é o da sua profissão. Os conselhos restringem o que se pode dizer para se destacar: em geral, proíbem superlativos como "o melhor", promessa de resultado, preço como chamariz e, em várias profissões, imagens de antes e depois. A Parte 2 detalha as regras de cada conselho.

Por isso, a diferença que este guia ensina não mora nos adjetivos. Mora em fatos que o paciente consegue verificar:

- **Um público bem definido**, como corredores amadores, gestantes ou adultos com medo de dentista.
- **Um problema específico** que você resolve com frequência e explica com clareza.
- **Uma forma de atender**, como uma avaliação mais longa, um plano por escrito ou o acompanhamento entre as consultas.
- **Um conteúdo educativo** que só você produz, porque nasce da sua experiência clínica.

O guia chama isso de **diferencial ético**: uma diferença real, demonstrada pelo conteúdo e pelo atendimento, e dita dentro das regras do seu conselho.

## O preço da travessia

O CliniLoop não troca a mensalidade de uma agência por um preço menor. Ele troca o jogo, e o novo jogo cobra em outra moeda: **o seu tempo**.

- **De 25 a 30 minutos por dia útil** no primeiro mês, seguindo o plano de 30 dias do roteiro.
- **Um ritual semanal de 30 minutos** a partir daí, para publicar, responder, registrar e corrigir uma coisa por vez.
- **Verba de anúncio, se e quando você quiser amplificar** o que já funciona.

A inteligência artificial reduz muito esse tempo, porque escreve rascunhos, organiza ideias e revisa textos. Mas o ponto de partida é sempre o que você sabe, e **você revisa tudo antes de publicar**.

## Como esta história está contada

O guia segue a estrutura que o mitólogo Joseph Campbell encontrou nas histórias de todas as culturas e que o roteirista Christopher Vogler organizou em etapas: o herói sai do mundo comum, cruza um limiar, enfrenta provas, chega à provação e volta transformado, trazendo algo de valor para a sua comunidade. Donald Miller levou a mesma ideia para a comunicação de marcas: o cliente é o herói, e quem o ajuda é o guia. Aqui, o herói é você.

Cada parte abre dizendo em que ponto da jornada você está e termina com uma **passagem** para a próxima. Você não precisa ler tudo de uma vez: siga as seis etapas do roteiro e volte às partes quando elas se aplicarem ao seu momento. Os termos do mercado digital, como algoritmo, Reels, impulsionamento e funil, são explicados quando aparecem e reunidos no Glossário.

Os nomes das pessoas e das obras que inspiraram este trabalho estão em **Fontes e agradecimentos**, no final, com a nossa gratidão.

---

**Próxima passagem.** *Antes de partir, falta entender a outra jornada desta história: a do paciente. Ele também atravessa um caminho até chegar à sua cadeira, e nem todos os caminhos passam pelos mesmos lugares.*

AS JORNADAS

# As jornadas do paciente

*Nenhum paciente chega do nada. Cada um percorre um caminho até a sua cadeira, e esses caminhos cabem em sete famílias. O guia e o app escolhem otimizar algumas delas, e é bom saber quais antes de partir.*

## Sete famílias de caminhos

Pense nos seus últimos dez pacientes novos. Um veio indicado por um colega. Outra viu um vídeo seu e chamou no Direct. Um terceiro achou você no Google Maps, uma quarta veio pelo convênio, e assim por diante. Cada um entrou por uma porta, e as portas não são iguais.

| Família | Exemplos | Porta mais comum | O que o CliniLoop faz |
|---|---|---|---|
| **Indicação** | Colega de outra área, encaminhamento interno da clínica, paciente atual ou antigo, família e amigos | Confiança | Otimiza: rede de colegas, contrarreferência, avaliações e indicação espontânea (Partes 8 e 12) |
| **Conteúdo próprio** | Reels, carrosséis, vídeos no YouTube, posts no LinkedIn, um guia útil enviado por mensagem | Confiança | Otimiza: posicionamento, conteúdo, vídeo e reaproveitamento (Partes 3 a 7) |
| **Busca ativa** | Perfil da Empresa no Google, busca por sintoma ou especialidade, site, assistentes de IA | Mista | Otimiza: perfis completos, coerentes e citados em vários lugares (Partes 3 e 4) |

| Família | Exemplos | Porta mais comum | O que o CliniLoop faz |
|---|---|---|---|
| **Mídia paga** | Impulsionamento, Meta Ads, Google Ads, anúncios no YouTube e no TikTok | Depende do criativo | Otimiza para que o anúncio amplifique o seu conteúdo, e não o substitua (Parte 9) |
| **Presença fora do digital** | Entrevista na imprensa, palestra numa escola ou empresa, parceria com academia, evento com colegas | Confiança | Apoia: ser citado, LinkedIn e rede de colegas (Partes 3, 4 e 8) |
| **Caminhos intermediados** | Convênio ou plano de saúde, plataformas de agendamento, hospital e plantão, quem passa em frente ao consultório | Preço ou conveniência | Fora do foco principal; o Anexo D mostra como levar a diferença também para eles |
| **Retorno** | Paciente antigo que volta, revisão periódica, reativação de quem consentiu | Confiança | Otimiza: alta com vínculo, lembretes e reativação (Partes 12 e 13) |

A coluna da porta vem da Apresentação. Pela porta da confiança, a pessoa chega sabendo quem você é. Pela porta do preço, ou da conveniência, ela chega comparando valor, distância e horário. Nenhuma das duas é errada; elas apenas pedem conversas diferentes e, segundo a hipótese deste guia, terminam de jeitos diferentes.

## As jornadas se cruzam

Na vida real, quase ninguém percorre uma família só. A paciente indicada pela amiga confere o seu Instagram antes de chamar. O homem que achou você no Google assiste a dois vídeos seus antes de agendar. O paciente do convênio lê as avaliações e escolhe você entre os cinco credenciados do bairro.

Isso tem duas consequências. A primeira é que a diferença precisa estar em todos os lugares por onde o paciente passa, porque você não sabe por qual deles ele vai conferir. A segunda é que a origem que você registra é a porta principal, mas vale anotar também o que a pessoa citou: "vi o vídeo sobre joelho", "a Dra. Ana falou de você". É desse detalhe que sai o aprendizado.

## O que o guia e o app otimizam

O CliniLoop faz três escolhas.

1. **Fortalecer os caminhos da confiança.** Indicação, conteúdo próprio, presença fora do digital e retorno são as famílias em que a sua diferença age com mais força. É nelas que o guia investe a maior parte das páginas.
2. **Levar a busca e a mídia paga para a porta da confiança.** Um perfil que mostra a sua diferença transforma a busca em reconhecimento. Um anúncio feito a partir do seu conteúdo transforma o clique em interesse por você, e não pelo preço.
3. **Cuidar do trecho comum a todas as jornadas.** Seja qual for o caminho, todo paciente passa pelas mesmas decisões finais: chamar, agendar, comparecer e seguir o tratamento. As Partes 10 a 13 cuidam desse trecho, e é por isso que elas valem também para o paciente do convênio ou da plataforma.

## O que fica de fora, e por quê

Os caminhos intermediados dependem de contratos e regras que você controla pouco: a tabela da operadora, o algoritmo da plataforma, a escala do hospital, o ponto comercial. Para muitas especialidades eles são essenciais, mas não são o foco deste guia, que não

ensina a negociar com operadoras nem a escolher imóvel.

O que dá para fazer é levar a sua diferença também para eles: um perfil bem cuidado na plataforma, um atendimento que transforma o paciente do convênio em paciente que indica, uma fachada que diz o mesmo que o seu Instagram. O Anexo D trata disso.

## Cada jornada com o seu nome no CRM

Para saber quais caminhos trazem os pacientes que ficam, cada contato precisa entrar no CRM com a origem certa. O Rastreador do CliniLoop usa as mesmas famílias deste capítulo:

- **Conteúdo:** Instagram orgânico, YouTube, TikTok, LinkedIn, conteúdo citado (vídeo, post ou guia).
- **Busca:** Google orgânico (busca ou Perfil da Empresa), site, assistente de IA.
- **Indicação:** indicação de colega, encaminhamento interno, indicação de paciente.
- **Retorno:** paciente antigo.
- **Mídia paga:** Meta Ads, Google Ads e cada campanha ou impulsionamento que você registrar.
- **Intermediados:** convênio ou plano de saúde, Doctoralia ou outra plataforma, hospital ou plantão, passou em frente.
- **Fora do digital:** imprensa, palestra ou evento; parceria com empresa, escola ou academia.

Com esses nomes, a conta da Parte 13 fica simples: basta agrupar as origens pela porta e comparar.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Liste os seus dez últimos pacientes novos e escreva ao lado de cada um a família do caminho por onde chegou. Se não souber, escreva “não sei”. Quantos “não sei” apareceram? Esse é o tamanho do mapa que ainda falta desenhar.

**Próxima passagem.** *Com as duas jornadas à vista, a sua e a do paciente, é hora de arrumar a mochila: entender o terreno, os tipos de caixa do guia e a forma de conversar com a inteligência artificial.*

COMO USAR

# Antes de começar

*Antes de qualquer travessia, o herói arruma a mochila. Aqui ela leva três coisas: o mapa do terreno, as caixas que o guia usa em cada parte e o jeito certo de pedir ajuda à inteligência artificial.*

## O terreno é diferente

Na saúde, o que sustenta um consultório vem de sete decisões em sequência, e o terreno em que elas acontecem tem regras próprias. O que funciona para vender um tênis não funciona para escolher um médico. Na saúde, o mercado é regulado, a publicidade sensacionalista é proibida e o paciente decide por segurança, não por impulso. Por isso, a diferença precisa ser demonstrada, e não anunciada.

| Em outros mercados | Na saúde |
|---|---|
| Prospecção ativa e abordagem direta | Atração por conteúdo, indicação e anúncios, sem abordagem invasiva |
| Funil de vendas | Jornada do paciente: descoberta, agendamento, comparecimento, tratamento, retorno |
| Texto livre, com promessa e urgência | Comunicação regulada pelos conselhos (CFM, CFO, CFP, COFFITO, CFN) e pela LGPD |
| Destacar-se pelo preço ou pela oferta | Destacar-se pelo foco, pela forma de atender e pelo que você explica |
| Conteúdo novo para cada canal | Reaproveitamento: uma aula, podcast ou entrevista vira carrossel, guia, Reel e Stories |
| LinkedIn como vitrine de vendas | LinkedIn como rede de reputação: colegas que indicam, imprensa, empresas e pacientes que pesquisam o seu nome |

## Para quem é

Para médicos, dentistas, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, nutricionistas e demais profissionais liberais de saúde, além de gestores e secretárias de clínicas.

O guia foi escrito para várias gerações, de quem acabou de se formar a quem atende há décadas. Se você já domina um assunto, siga para o próximo. Se está começando, encontra aqui o passo a passo completo.

## Para quem não é

Toda jornada tem um preço, e convém dizê-lo antes da partida. Este guia não é para quem quer contatos amanhã sem dedicar tempo ao processo. A diferenciação leva semanas para aparecer e depende de constância: de 25 a 30 minutos por dia útil no primeiro mês e um ritual semanal depois. Quem precisa de volume imediato e não tem esse tempo pode preferir começar por anúncios e voltar a este guia quando quiser que esses anúncios deixem de ser genéricos.

## Como ler

Leia primeiro a Apresentação, As jornadas do paciente e as Partes 1 e 2. Elas explicam o jogo que o guia escolhe, os caminhos por onde o paciente chega, as sete decisões que ele toma e o que pode e o que não pode ser dito. Depois, siga as demais partes na ordem do roteiro e volte a elas como manual de consulta.

Cada parte abre com o ponto da jornada em que você está e termina com uma passagem para a próxima. No meio, você encontra quatro tipos de caixa:

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

**As quatro ações do Oceano Azul aplicadas àquela parte:**
o que eliminar, reduzir, elevar e criar para que o paciente perceba a sua diferença naquela etapa.

PROMPT PRONTO

**Um pedido pronto para a IA.**
Copie o texto, troque o que estiver entre colchetes e envie.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

**Um passo concreto**
de até 30 minutos, para fazer no mesmo dia em que você ler a parte.

NO CLINILOOP

**A ferramenta do CliniLoop**
que coloca aquela parte em prática no seu consultório.

# Como escrever um bom prompt

Prompt é o texto que você escreve para pedir algo a uma ferramenta de inteligência artificial, como o Claude, o ChatGPT ou o Gemini. A qualidade da resposta depende muito da qualidade do pedido. A IA responde melhor quando você a faz assumir um papel, explica o contexto e diz exatamente qual é a tarefa.

Os prompts deste guia seguem sempre a mesma ordem:

1. **Papel.** Diga quem a IA deve ser, por exemplo: “Atue como um profissional de marketing ético, especializado em saúde”. Com um papel definido, ela escolhe o vocabulário, o nível de detalhe e os cuidados daquela profissão.
2. **Contexto.** Conte quem você é, qual é o seu diferencial e para quem é o texto: profissão, especialidade, cidade, público, canal e as regras que valem, como as normas do seu conselho.
3. **Tarefa.** Peça uma coisa só, com um verbo claro: escrever, revisar, listar, resumir, comparar.
4. **Formato.** Diga como quer receber: tamanho, tom, tópicos, tabela ou número de opções.
5. **Limites.** Diga o que a IA não deve fazer: “não invente dados”, “não prometa resultado”, “marque com [CONFIRMAR] o que faltar”.

O segundo item é o que separa um texto genérico de um texto seu. Sem o seu diferencial no contexto, a IA escreve o que serviria a qualquer colega da cidade.

**Exemplo.**
Atue como um profissional de marketing ético, especializado em comunicação para a saúde. Sou dentista e atendo adultos que têm medo de ir ao dentista; a minha primeira consulta é só conversa e exame, sem nenhum procedimento. Escreva três legendas curtas para um post do Instagram explicando como é essa primeira consulta. Use tom acolhedor e até 60 palavras em cada uma. Siga as normas do CFO, não prometa resultado e não invente informações.

Para usar os prompts do guia, copie o texto da caixa, troque o que estiver entre colchetes, como [PROFISSÃO] ou [CIDADE], e envie. No app, o botão “Copiar prompt” faz a cópia e o link “Abrir no Claude” abre o pedido direto na ferramenta, já com os dados e o diferencial do seu consultório. Leia a resposta com atenção e peça ajustes na mesma conversa, como “mais curto” ou “mais simples”, até o texto ficar correto e soar como você.

# As quatro regras de uso da IA

ATENÇÃO

**1. Não invente.**
Peça que a IA use só os fatos que você forneceu e marque com [CONFIRMAR] o que faltar, sobretudo informação clínica.

**2. Revise sempre.** Nada vai para paciente, colega ou anúncio sem leitura do profissional responsável.

**3. Proteja os dados.** Nunca cole nome, prontuário, exame ou foto identificável de paciente em um assistente de IA.

**4. Mantenha a sua voz.** Ajuste o texto até soar como você fala no consultório. A sua voz é parte do seu diferencial.

As normas dos conselhos citadas neste guia foram conferidas em outubro de 2026, em fontes públicas, e devem ser checadas na versão vigente antes de qualquer publicação.

---

**Próxima passagem.** *A mochila está pronta. Falta abrir as contas que você vai usar no caminho e escrever, em uma linha, a primeira versão da sua diferença.*

COMO COMEÇAR

# Como começar

*O limiar está perto. Antes da Parte 1, separe uma hora para abrir as contas que o guia usa e para escrever, em uma linha, por que um paciente deveria procurar você. Essa linha vai mudar ao longo do caminho, e é bom que mude.*

## 1. Uma conta em uma ferramenta de IA

Se você ainda não usa inteligência artificial, abra uma conta em uma das ferramentas abaixo. Todas podem ser usadas sem assinatura, o que basta para começar e para usar os prompts deste guia. Para entrar, basta um e-mail ou uma conta Google, Apple ou Microsoft. Os aplicativos para celular têm o mesmo nome nas lojas da Apple e do Google.

| Ferramenta | Empresa | Onde abrir a conta |
|---|---|---|
| **Claude** | Anthropic | claude.ai |
| **ChatGPT** | OpenAI | chatgpt.com |
| **Gemini** | Google | gemini.google.com |
| **Copilot** | Microsoft | copilot.microsoft.com |
| **Grok** | xAI | grok.com |
| **DeepSeek** | DeepSeek | chat.deepseek.com |
| **Meta AI** | Meta | meta.ai, e também dentro do WhatsApp e do Instagram |

O app funciona com todas elas: em Configurações, escolha a sua preferida. Nunca cole dados de pacientes em nenhuma IA, e confira onde cada uma guarda o que você escreve. O DeepSeek, por exemplo, armazena os dados na China.

A IA é a mesma para você e para o seu concorrente. O que muda o resultado é o que você coloca nela: a sua experiência clínica, as dúvidas dos seus pacientes e o seu diferencial. Por isso, o guia insiste no contexto de cada prompt.

### Quando vale pagar

Sem assinatura, há limite no número de mensagens por dia e no acesso aos modelos mais recentes. Se você passar a usar a IA toda semana, uma assinatura paga costuma compensar. Há dois caminhos.

**Assinar uma ferramenta.** Claude, ChatGPT e Gemini têm planos individuais pagos, com mais uso, modelos mais avançados e recursos como a leitura de arquivos longos. Escolha uma e aprenda a usá-la bem antes de pensar em outra.

**Assinar um agregador.** Agregador de IA é uma plataforma que reúne modelos de várias empresas em uma única assinatura, com interface em português. Dois exemplos brasileiros são a Adapta, que reúne modelos da OpenAI, da Anthropic e do Google, entre outros, e inclui cursos sobre o uso de IA em áreas como marketing e gestão; e o MyHub.IA, que reúne ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini e Perplexity e também inclui cursos.

Os agregadores são uma boa opção para quem quer comparar ferramentas e aprender com aulas no mesmo lugar. Antes de assinar, confira no site de cada um quais modelos, limites de uso e cursos estão incluídos no plano, porque isso muda com frequência.

Qualquer que seja a escolha, valem as quatro regras: não invente, revise sempre, proteja os dados dos pacientes e mantenha a sua voz.

## 2. As contas nas redes e no Google

A Parte 3 ensina a configurar cada canal passo a passo. Por enquanto, garanta que você tem acesso a estas contas, de preferência com o e-mail profissional da clínica.

| Canal | Para que serve neste guia | Onde criar |
|---|---|---|
| Perfil da Empresa no Google | Aparecer no Google Maps e na busca da sua cidade, com endereço, horário e avaliações | google.com/business |
| Instagram | Canal principal de conteúdo e de relacionamento com pacientes | instagram.com ou o aplicativo |
| YouTube | Vídeos que respondem às dúvidas que os pacientes pesquisam | youtube.com, com a mesma conta Google |
| LinkedIn | Autoridade entre colegas, indicações e publicações mais técnicas | linkedin.com |
| TikTok | Vídeos curtos para alcançar pessoas que ainda não conhecem você | tiktok.com ou o aplicativo |

Anote em um lugar seguro qual e-mail e qual telefone estão ligados a cada conta e ative a verificação em duas etapas em todas. Se alguém da equipe ou de uma agência for ajudar, dê acesso pelas ferramentas de gestão de cada rede, sem compartilhar a sua senha. As contas e o conteúdo devem ficar no seu nome: eles são o patrimônio que este guia ajuda a construir.

## 3. Os módulos do CliniLoop

Abra o CliniLoop pelo link que você recebeu na compra, no navegador do computador ou do celular. Os seus registros ficam no seu aparelho, não num servidor. O menu tem cinco telas: Hoje, Redes, CRM, Guia e Ferramentas. Os módulos conduzem você por um caminho de nove passos, em ordem: os passos 1 a 6 ficam no módulo Redes e posicionamento, e

os passos 7 a 9, no módulo CRM. Cada passo reúne os campos, o prompt e o que guardar. Na primeira vez, o passo 1 pede o tipo de profissional, os dados do consultório e o objetivo. O tutorial com as telas, passo a passo, está na Parte 14.

NO CLINILOOP

**Passo 1 · Seu consultório e objetivo.**
Escolha o tipo de profissional: o app carrega as regras do conselho certo em todos os prompts. Preencha uma única vez: esses dados alimentam todos os passos seguintes.

## 4. Um rascunho do seu diferencial

Antes de seguir, escreva em uma linha por que um paciente deveria procurar você, e não outro colega da sua cidade. Não precisa estar bom. Use o formato abaixo e guarde a frase:

> *Eu ajudo [QUEM] a [RESOLVER QUAL PROBLEMA], com [O QUE EU FAÇO DE DIFERENTE NO ATENDIMENTO].*

Se a frase servir para qualquer colega da sua especialidade, ela ainda está no Oceano Vermelho. Isso é normal no primeiro rascunho. No dia 4 do plano de 30 dias, a ferramenta Nicho e diferencial e a Estratégia Oceano Azul ajudam a transformá-la em uma proposta de valor que o paciente reconhece, dentro das regras do seu conselho.

---

**Próxima passagem.** *Com as contas abertas e a frase no bolso, falta olhar o mapa inteiro: as seis etapas da travessia, o plano de 30 dias e os marcos que mostram se você está no rumo.*

ROTEIRO

# Seu roteiro em seis etapas

*Este é o mapa. Ele mostra as seis etapas da travessia, o ponto da jornada em que cada uma acontece e o que você leva de cada uma. Siga na ordem, registre cada passo no CRM e volte ao mapa sempre que o consultório ou o objetivo mudarem.*

## As seis etapas

| Etapa | O que você faz | Na jornada | Partes |
|---|---|---|---|
| 1 | **Entenda o jogo e as regras** | As leis do mundo novo | 01 A jornada das sete decisões · 02 Ética primeiro: conselhos e LGPD |
| 2 | **Posicione-se** | A travessia do primeiro limiar | 03 Os canais, um a um: manual de configuração |
| 3 | **Gere autoridade e demanda** | Provas, aliados e inimigos | 04 Conteúdo que gera autoridade e alcance · 05 Reaproveitamento: uma aula, quatro entregas · 06 Vídeo: como produzir com o que você tem · 07 Edição de vídeo: das ferramentas nativas às externas · 08 A decisão dos colegas: a rede de indicação · 09 Anúncios: Meta Ads e Google Ads |

| Etapa | O que você faz | Na jornada | Partes |
|---|---|---|---|
| **4** | **Converta contatos em consultas** | A aproximação da caverna | 10 Do clique à consulta: a decisão de agendar · 11 A decisão de comparecer |
| **5** | **Feche e acompanhe o tratamento** | A provação | 12 A decisão de tratar: fechamento com ética |
| **6** | **Meça e escale com CRM** | A recompensa e o retorno | 13 O CRM: a gestão do relacionamento com o paciente · 14 O app CliniLoop: guia das ferramentas · 15 Gerador de campanhas e biblioteca de prompts · 16 Ferramentas para materializar as campanhas |

A ordem conta uma história. Na etapa 1, você aprende as leis do mundo novo: as decisões do paciente e o código da sua profissão. Na etapa 2, cruza o limiar: diz em público quem você é e para quem você é a escolha certa. Na etapa 3, enfrenta as provas do conteúdo e da câmera, ganha aliados entre os colegas e aprende a usar uma arma poderosa e perigosa, o anúncio. Na etapa 4, chega à caverna onde a maioria dos pacientes se perde, a conversa no WhatsApp. Na etapa 5, passa pela provação: a consulta, onde a diferença prometida precisa ser entregue. E na etapa 6, volta com a recompensa: o conhecimento de quais caminhos trazem os pacientes que ficam.

Depois, a jornada recomeça, um pouco mais curta e mais segura a cada volta. É por isso que o sistema se chama Loop.

No fim do guia, o **Anexo A** é o manual prático para ter à mão, e o **Anexo D** trata dos caminhos que este guia não põe no centro: convênios, plataformas, hospitais e a porta da rua.

# Não sabe por onde começar?

Abra o app. Em **Hoje**, o CliniLoop mostra a próxima ação e leva você até o fim dela, antes de perguntar qual é a seguinte. Se preferir seguir o papel, use o plano de 30 dias abaixo: são 20 dias úteis, cada um com uma ação, uma ferramenta, um tempo estimado de 20 a 30 minutos e uma entrega.

Repare no dia 4. É nele que você escolhe a proposta de valor e a frase de diferencial que vão orientar todo o resto: as pautas, os roteiros, a bio, a carta aos colegas e os anúncios. Se a travessia tem um limiar, ele está ali.

# Plano de 30 dias

## Semana 1: Base e regras partes 1 a 3

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Defina o objetivo e o perfil.** Preencha o passo 1 do caminho: uma frase com o resultado que você quer (serviço, número, prazo), tipo de profissional, cidade, serviços e sua história profissional. | Comece aqui | Perfil do consultório salvo no app. | 25 min |
| 2 | **Conheça os limites do seu conselho.** Leia o quadro do seu conselho e cole a bio e os três últimos posts no Verificador ético. | Verificador ético | Lista do que corrigir antes de qualquer divulgação. | 25 min |
| 3 | **Escreva as dúvidas reais dos pacientes.** Liste 10 perguntas que você ouviu no consultório nesta semana, nas palavras dos pacientes, sem nomes. Gere o ICP e a persona. | Público, ICP e persona | 10 dúvidas e um paciente ideal descrito. | 30 min |

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Escolha uma proposta de valor.** Liste formações e métodos, gere a análise de nicho e escolha uma frase de diferencial que você consiga provar com o que já fez. | Nicho e diferencial | Uma frase de proposta de valor guardada. | 30 min |
| 5 | **Atualize bio, Google e LinkedIn.** Cole os perfis atuais, gere a auditoria, aplique a nova bio do Instagram, o Perfil da Empresa no Google e o título do LinkedIn. | Perfis e presença | Três perfis atualizados e com link para agendar. | 30 min |

## Semana 2: Conteúdo que atrai partes 4 e 5

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **Monte as pautas.** Gere palavras-chave e 30 pautas a partir das dúvidas do dia 3. Marque quatro para este mês. | Pautas e palavras-chave | Calendário com 4 pautas e a frequência que você aguenta manter. | 30 min |
| 7 | **Roteirize o primeiro Reel.** Gere o roteiro da pauta 1 com cinco ganchos. Escolha um e ajuste a fala para o seu jeito. | Roteiros e copy | Roteiro pronto para gravar. | 30 min |
| 8 | **Grave.** Grave a pauta 1 com o celular, luz natural, áudio limpo. Se tiver energia, grave a pauta 2 na sequência. | Roteiros e copy | Um ou dois vídeos gravados. | 30 min |

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **Verifique e publique.** Passe legenda e vídeo pelo Verificador ético, inclua nome, registro e especialidade, publique e registre no Diário de conteúdo. | Verificador ético | Primeiro conteúdo no ar e registrado. | 20 min |
| 10 | **Reaproveite.** Escolha uma aula, podcast ou entrevista em que você falou bem, cole a transcrição e gere carrossel, guia e Reel. | Reaproveitamento de conteúdo | Um conjunto de peças para as próximas semanas. | 30 min |

## Semana 3: Atendimento e colegas partes 8, 10, 11 e 13

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | **Prepare as respostas rápidas.** Gere as 12 respostas rápidas, ajuste ao seu tom e salve no WhatsApp Business. | Atendimento e agendamento | 12 mensagens salvas. | 30 min |
| 12 | **Defina como e quando responde.** Escreva a saudação e a mensagem de ausência, e decida o horário em que você responde novos contatos. | Atendimento e agendamento | Regra de resposta escrita e configurada. | 25 min |
| 13 | **Registre quem já entrou em contato.** Cadastre no Rastreador todos os contatos abertos dos últimos 30 dias, com origem, etapa e consentimento. Defina o próximo passo de cada um. | Rastreador de pacientes | Todos os contatos abertos com próximo passo e data. | 30 min |

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | **Comece a rede de colegas.** Cadastre 10 colegas que atendem o mesmo paciente antes ou depois de você. Gere a carta e envie para os 3 mais próximos. | Rede de colegas | 10 colegas mapeados e 3 cartas enviadas. | 30 min |
| 15 | **Confirmação e retomadas.** Gere o texto de confirmação com data e local, e as retomadas de 1, 3 e 7 dias. Use em todos os agendamentos a partir de hoje. | Atendimento e agendamento | Sequência de confirmação em uso. | 30 min |

## Semana 4: Medir e ajustar partes 13, 15 e 16

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 16 | **Segunda rodada de conteúdo.** Publique o 2º e o 3º conteúdos e registre no Diário. Responda cada comentário e mensagem no mesmo dia. | Painel e diagnóstico | 3 conteúdos registrados. | 20 min |
| 17 | **Faça o ritual da semana.** Importe as pendências no Assistente e gere a agenda em blocos para a semana. | Assistente da semana | Agenda da semana pronta. | 25 min |
| 18 | **Lance os números e ache o gargalo.** Preencha os números da semana e leia "As sete decisões": em qual delas o paciente está se perdendo? | Painel e diagnóstico | Um gargalo identificado. | 30 min |
| 19 | **Corrija uma coisa só.** Escolha um ajuste: o gancho, a bio, a resposta rápida ou o lembrete. Mude e anote a data para comparar. | Painel e diagnóstico | Um ajuste feito, com data. | 30 min |

| Dia | Ação | Ferramenta | Entrega | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 20 | **Revise o mês e planeje o próximo.** Gere o playbook. Compare com os marcos desta página e decida o foco dos próximos 30 dias. Só pense em anúncios se a base estiver pronta. | Playbook da clínica | Playbook e plano dos próximos 30 dias. | 30 min |

ATENÇÃO

**O que o plano não promete.**
Ele organiza o trabalho de quatro semanas, mas não promete número de pacientes, nem pacientes "melhores". Quem define o ritmo é o seu consultório: se uma semana ficar pesada, repita-a antes de avançar.

## Marcos de referência

Ao final de cada fase, confira se os marcos abaixo foram cumpridos. São metas de processo, não de faturamento: não existe, no Brasil, um padrão confiável de volume de pacientes por tipo de consultório. O padrão que importa é o seu, e ele começa a aparecer no CRM depois de algumas semanas de registro.

### Dia 30

- Bio, Google e LinkedIn revisados e aprovados no Verificador ético.
- 8 a 12 conteúdos publicados e registrados no Diário (2 a 3 por semana).
- 100% dos contatos novos registrados no Rastreador, com origem e consentimento.
- Tempo de resposta a novos contatos que você consegue manter (meça a mediana).
- Confirmação enviada em 100% dos agendamentos.
- 10 colegas mapeados e 3 cartas enviadas.

### Dia 60

- Taxa de agendamento (agendados ÷ contatos novos) medida há pelo menos 4 semanas: esse é o seu ponto de partida.
- Taxa de comparecimento (atendidos ÷ agendados) medida, com as faltas anotadas.
- Uma indicação recebida de colega, ou 3 colegas com conversa marcada.
- Um ajuste testado por vez, com data de início e de leitura.

### Dia 90

- Pelo menos um colega ativo (indicou nos últimos 90 dias).
- Resultado do objetivo que você escreveu no dia 1, comparado com a sua própria linha de base.
- Melhora na etapa que mais perdia pacientes (agendamento, comparecimento ou plano), em relação ao dia 30.
- Decisão sobre anúncios, só com a base de atendimento e registro funcionando.

---

**Próxima passagem.** *O mapa está aberto. A primeira etapa começa pelo que o paciente vive antes de chegar até você: sete decisões, uma de cada vez.*

NO ROTEIRO · ETAPA 1 DE 6 · ENTENDA O JOGO E AS REGRAS

*Na jornada · As leis do mundo novo*

01

# A jornada das sete decisões

*Um consultório cheio não depende de um post viral. Depende de sete decisões em sequência. A forma como o paciente entra na primeira define como ele atravessa as últimas.*

NESTA PARTE · PARTE 01

As sete decisões · Duas portas de entrada · O papel de cada canal · O caminho entre os canais

A primeira lição de todo mundo novo é que ele tem leis próprias. No mundo em que o paciente escolhe o profissional, a lei principal é esta: ninguém chega à sua cadeira de uma vez. Chega aos poucos, decisão por decisão, e pode desistir em qualquer uma delas.

Quem perde o paciente entre o "oi" no WhatsApp e a cadeira do consultório costuma achar que tem um problema de marketing. Quase sempre, tem um problema de diferenciação e de CRM.

## As sete decisões

Antes de sentar na sua cadeira, o paciente toma sete decisões, uma de cada vez. Cada uma delas é um "sim" que você precisa merecer.

1. **Atenção.** A pessoa para no seu conteúdo: um Reel, um Short, um anúncio, um resultado de busca no Google.
2. **Confiança.** Ela segue, assiste mais, lê a bio, confere o Google e o LinkedIn.
3. **Indicação.** Um médico, dentista ou fisioterapeuta indica você pelo nome.
4. **Contato.** A pessoa chama no WhatsApp, liga ou preenche um formulário.
5. **Agendamento.** A consulta ou avaliação entra na agenda.
6. **Comparecimento.** O paciente aparece no dia e na hora.
7. **Adesão.** Ele aceita o plano proposto, segue até o fim, retorna e indica outras pessoas.

As decisões 1 e 2 são de visibilidade e autoridade. A 3 é de relacionamento profissional. Da 4 à 7, o trabalho é de atendimento e CRM.

> **ATENÇÃO**
>
> A maior parte das clínicas investe na decisão 1 e perde dinheiro da 4 à 7.

# Duas portas de entrada

O paciente pode chegar à decisão 4 por duas portas diferentes, e cada uma muda o que acontece depois.

**A porta do preço.** A pessoa viu um anúncio genérico, igual ao de vários colegas, e chamou para perguntar. Ela ainda não sabe quem você é nem por que deveria escolher você. Na conversa, compara o que consegue comparar: preço, horário e distância. Muitas vezes, chama três consultórios ao mesmo tempo.

**A porta da confiança.** A pessoa assistiu a três vídeos seus, leu a sua bio, conferiu as avaliações no Google ou ouviu o seu nome de um colega. Quando chama, já atravessou as decisões 1, 2 e, às vezes, 3. A conversa começa em "quero marcar com você" e não em "quanto custa".

| | Porta do preço | Porta da confiança |
|---|---|---|
| **O que a pessoa sabe de você** | Quase nada | Como você explica, para quem você atende, quem indica |
| **A primeira pergunta** | "Quanto custa?" | "Quando tem horário?" |
| **O que ela compara** | Preço, horário, distância | Se o seu perfil serve para o caso dela |
| **O que o guia espera nas decisões 5 a 7** | Mais desistência e mais faltas | Mais agendamentos, presença e adesão |

A última linha é a hipótese central deste guia, e é por isso que ela está escrita como expectativa, não como certeza. O CRM vai mostrar se ela vale para o seu consultório: basta registrar a origem de cada contato desde o primeiro dia (Parte 13).

O capítulo As jornadas do paciente, no início do guia, mostra as sete famílias de caminhos que levam até essas portas, da indicação de um colega ao convênio. Aqui basta guardar a ideia central: o caminho importa menos que a porta pela qual a pessoa entra na conversa.

As duas portas não se excluem. Um anúncio pode levar à porta da confiança quando mostra o seu conteúdo, a sua voz e o seu diferencial, e não uma promessa genérica. É o que a Parte 9 chama de anúncio que amplifica o que já é seu.

## O papel de cada canal

| Canal | Função principal | O que publicar | Métrica que importa |
|---|---|---|---|
| **Instagram** | Captação de pacientes e relacionamento | Reels educativos, carrosséis, bastidores, Stories com caixinha de perguntas | Mensagens recebidas no Direct e no WhatsApp |
| **YouTube** | Autoridade e busca de longo prazo | Vídeos que respondem às dúvidas que o paciente pesquisa; Shorts como porta de entrada | Tempo de exibição e cliques para agendar |
| **Google (Perfil da Empresa e busca)** | Intenção imediata: quem já precisa | Fotos, horários, avaliações, posts; anúncios de pesquisa | Ligações, rotas e cliques no WhatsApp |
| **TikTok (opcional)** | Alcance amplo por interesse | Os mesmos roteiros dos Reels, sem marca d'água de outra rede | Compartilhamentos e visitas ao perfil |
| **LinkedIn** | Reputação profissional: colegas que indicam, imprensa, empresas e pacientes que pesquisam o seu nome | Perfil completo, sínteses de artigos, congressos, opiniões técnicas, casos discutidos sem identificação | Conexões com colegas, convites e indicações |

| Canal | Função principal | O que publicar | Métrica que importa |
|---|---|---|---|
| **WhatsApp** | Conversão e retenção | Atendimento, confirmações, orientações pós-consulta | Taxa de agendamento e de comparecimento |
| **Meta Ads e Google Ads** | Amplificar o que o orgânico já provou | Os conteúdos seus que mais geraram mensagens e agendamentos | Custo por paciente que compareceu, por origem |

Repare na última linha. O anúncio aparece depois dos outros canais porque amplifica o que eles já provaram. Ele não substitui a diferença que você constrói nos demais.

### O papel do LinkedIn

O LinkedIn é a rede da reputação profissional. É ali que colegas conferem a sua formação antes de indicar, que jornalistas e organizadores de eventos procuram especialistas e que muitos pacientes chegam quando pesquisam o seu nome. Ele trabalha sobretudo pelas decisões 2 e 3, confiança e indicação. Publique o conteúdo mais técnico e reflexivo: sínteses de artigos científicos, aprendizados de congressos, opiniões fundamentadas. A Parte 3 explica a natureza da rede e como configurar e publicar.

## O caminho entre os canais não é uma linha reta

As sete decisões acontecem em ordem, mas o caminho entre os canais, não. A mesma pessoa vê um Reel no ônibus, pesquisa o seu nome no Google à noite, pergunta a uma IA qual especialista procurar e só então chama no WhatsApp. Modelos recentes do mercado descrevem isso como um mapa de influência, e não como um funil: ao longo do dia, o paciente alterna cinco comportamentos.

| Comportamento | O que a pessoa está fazendo | Decisões que alimenta | O que oferecer | Sinal de que funciona |
|---|---|---|---|---|
| **Rolar o feed** | Passa por conteúdos rápidos, sem intenção de agendar | 1. Atenção | Reels e Shorts com uma pergunta clara nos primeiros segundos | Envios e visitas ao perfil |
| **Acompanhar** | Assiste por mais tempo e cria vínculo com quem fala | 2. Confiança | Vídeos longos no YouTube, lives, Stories, entrevistas | Tempo de exibição e quem volta |
| **Buscar** | Procura uma resposta ou um profissional, com objetivo claro | 2. Confiança e 4. Contato | Perfil da Empresa no Google, vídeos que respondem dúvidas, presença nos lugares de onde as IAs tiram respostas | Ligações, rotas e cliques no WhatsApp |
| **Conversar** | Tira dúvidas antes de decidir | 4. Contato e 5. Agendamento | WhatsApp e Direct com resposta rápida e roteiro (Parte 10) | Taxa de agendamento |
| **Recomendar** | Fala de você para outras pessoas | 3. Indicação e 7. Adesão | Experiência que merece ser contada, avaliações no Google pedidas a todos, rede de colegas (Parte 8) | Avaliações novas e indicações registradas no CRM |

No original, em inglês, os cinco comportamentos são *scrolling*, *streaming*, *searching*, *shopping* e *seeding*. Na saúde, a compra é uma conversa que termina em agendamento; por isso, aqui, "conversar".

Três consequências práticas:

- **Escolha o canal pela função, não pela fama.** A pergunta não é "em qual rede todo mundo está", e sim "qual canal influencia o meu paciente neste momento". A tabela "O papel de cada canal", acima, é o ponto de partida.
- **A busca saiu do Google, mas não foi só para as redes.** Instagram, TikTok e YouTube também funcionam como buscadores. E os assistentes de IA já respondem "qual fisioterapeuta procurar em Campinas" citando avaliações, entrevistas, artigos e perfis profissionais. Um perfil bem cuidado não basta se você não aparece em nenhum outro lugar (Parte 4, "Ser citado, não só publicar").
- **Em cada comportamento, a diferença precisa aparecer.** Quem rola o feed decide em segundos se você é igual aos outros. Quem busca compara perfis lado a lado. Quem conversa compara respostas. Se o seu diferencial só aparece na consulta, ele chega tarde demais.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** a ideia de que todo contato vale o mesmo. Um contato que chega pelo preço e um que chega por confiança pedem conversas diferentes.
- **Reduzir:** o esforço na decisão 1 quando as decisões 4 a 7 estão vazando.
- **Elevar:** o registro da origem de cada paciente, para saber qual porta traz quem fica.
- **Criar:** um caminho visível entre os canais, em que cada um leva ao próximo com a mesma mensagem sobre quem você atende e como.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Escreva as sete decisões numa folha e, ao lado de cada uma, anote quantos pacientes passaram por ela no último mês. Depois, para os pacientes que chegaram até a decisão 7, anote por qual porta entraram. Onde você não sabe o número, está o primeiro campo do seu CRM.

NO CLINILOOP

**Passo 1 · Seu consultório e objetivo.**
Escolha o tipo de profissional. O app carrega as regras do conselho certo em todos os prompts. No Rastreador, todo contato tem um campo de origem: preencha sempre.

---

**Próxima passagem.** *Agora você sabe por onde o paciente passa. Antes de dar o primeiro passo em direção a ele, falta conhecer o código que não se quebra: as regras da sua profissão.*

NO ROTEIRO · ETAPA 1 DE 6 · ENTENDA O JOGO E AS REGRAS

*Na jornada · O código do herói*

# 02

# Ética primeiro: conselhos e LGPD

*Na saúde, a ética é a própria estratégia. Ela fecha as portas do preço e da promessa, e por isso obriga a competir pela única coisa que sobra: a diferença real, demonstrada.*

---

NESTA PARTE · PARTE 02

Regras que valem para todas as profissões · O que muda por profissão · Diferenciar dentro das regras · LGPD · Políticas das plataformas

Todo herói tem um código. O do profissional de saúde está escrito nas resoluções dos conselhos e na LGPD, e ele não é um obstáculo no caminho: é o que separa a jornada do atalho.

Toda peça deste guia, orgânica ou paga, passa pelo filtro desta parte antes de ser publicada. O que é permitido em uma profissão pode ser proibido em outra, então nunca generalize.

Há uma razão estratégica, além da obrigação. As regras dos conselhos proíbem quase tudo o que a fábrica de leads usa para se destacar: preço, desconto, promessa de resultado, superlativo e urgência artificial. Quem tenta disputar por esses atalhos corre risco ético e ainda fica igual aos outros. Quem aceita as regras é empurrado para o jogo que este guia propõe: mostrar, com conteúdo e atendimento, uma diferença que o paciente consegue verificar.

## Regras que valem para todas as profissões

- **Identifique-se sempre:** nome, profissão, número do conselho (CRM, CRO, CRP, CREFITO, CRN) e, para médicos especialistas, o RQE. Em redes sociais, esses dados ficam na página principal do perfil.
- **Eduque antes de anunciar.** Uma promessa verdadeira e uma pergunta principal por peça. Nunca garanta resultado, nunca use superlativos (“o melhor”, “o único”, “100%”) e nunca diminua colegas.
- **Afirmação clínica precisa de fonte.** Sem fonte, ela fica marcada como pendente de validação ou sai do roteiro.
- **Padrão de menor exposição.** Explique com o próprio profissional, modelo anatômico ou ilustração autorizada, em vez de paciente real. Nunca use imagem gerada por IA como se fosse paciente real ou evidência clínica.
- **Não crie medo, vergonha nem urgência artificial** (“últimas vagas”, “você pode estar doente e não sabe”).
- **Responda dúvidas gerais em público,** mas nunca faça diagnóstico por comentário, foto ou vídeo, nunca prescreva em roteiro genérico e nunca peça histórico de saúde nos comentários. Encaminhe ao atendimento.
- **Não copie** casos, imagens ou roteiros de terceiros e não invente depoimentos.

- **Não pague nem receba comissão** por indicação de paciente. A indicação entre colegas é técnica, não comercial.

## O que muda por profissão

Resumo de fontes oficiais consultadas em outubro de 2026. Confira sempre o texto vigente.

| Profissão e norma | Pode | Não pode |
|---|---|---|
| **Médicos e psiquiatras.** Resolução CFM 2.336/2023, em vigor desde março de 2024 | Selfies sem sensacionalismo; imagens de pacientes só com finalidade educativa: antes e depois em conjunto, com resultados satisfatórios, insatisfatórios e complicações, texto educativo e paciente não identificado; informar valores de consulta, formas de pagamento e descontos em campanhas | Garantir ou insinuar resultado; sensacionalismo e autopromoção; "descobertas milagrosas"; editar ou melhorar imagens; anunciar especialidade sem RQE; serviço gratuito em consultório privado como concorrência desleal; transmitir consultas e procedimentos ao vivo; venda casada e premiação. Conteúdo de terceiros que o médico reposta passa a ser dele |
| **Dentistas.** Resolução CFO 196/2019 e FAQ do CFO, Código de Ética Odontológica e guia do CROSP | Selfies; antes e depois de tratamento concluído, só pelo dentista que executou, com nome e CRO na imagem e autorização escrita do paciente | Antes e depois no perfil da clínica (pessoa jurídica); "antes, durante e depois"; preços, descontos, promoções, concursos e sorteios; promessa de resultado; sensacionalismo; compra de seguidores; influenciador pago com tratamento; anunciar especialidade não registrada |

| Profissão e norma | Pode | Não pode |
|---|---|---|
| **Psicólogos.** Código de Ética (Resolução CFP 10/2005), Nota Técnica CFP 01/2022 e cartilha do CRP-MG, 2026 | Conteúdo informativo e educativo em qualquer canal; projetos sociais coletivos | Usar preço como propaganda (descontos, cupons, pacotes, sorteios, gratuidade); garantir resultado; sensacionalismo; "Dr." sem doutorado; associar práticas não reconhecidas; publicar imagens de testes. Depoimentos só com anonimato e consentimento, e a cartilha desaconselha |
| **Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.** Resolução COFFITO 532/2021 e Códigos de Ética | Imagens, textos e áudios autênticos de pacientes com TCLE prévio; conteúdo educativo, demonstração com o próprio profissional ou modelo | Publicar sem nome do profissional, número de inscrição e data; sensacionalismo; concorrência desleal; promessa de resultado infalível; divulgar casos clínicos de terceiros; expor dados que identifiquem o paciente, inclusive antes e depois, sem autorização formal. Divulgação irregular de imagem de paciente é infração de manifesta gravidade |

| Profissão e norma | Pode | Não pode |
|---|---|---|
| **Nutricionistas.** Código de Ética e de Conduta (Resolução CFN 599/2018) | Conteúdo focado em promoção da saúde e educação alimentar, com base científica e o aviso de que os resultados podem não ocorrer da mesma forma para todos; divulgar resultados de trabalho com autorização escrita; identificação com nome, profissão e número do CRN | Garantir resultado ou alegar exclusividade; sensacionalismo; divulgar imagem corporal, sua ou de terceiros, atribuindo resultado a produto, técnica ou protocolo, mesmo com autorização (exceto em eventos e publicações científicas); usar honorários, promoções e sorteios como publicidade; associar a própria imagem a marcas de alimentos ou fazer publicidade comercial de marcas |

## Saúde mental pede cuidado redobrado

Psiquiatria e psicologia lidam com pessoas vulneráveis. Evite conteúdo que estimule autodiagnóstico (“5 sinais de que você tem TDAH”) e prefira “quando vale procurar avaliação”. Nunca use casos reais, mesmo anonimizados, como chamariz. Em temas como suicídio, siga as recomendações de comunicação responsável e inclua o CVV (188).

## Conta do profissional ou da clínica

As regras mudam conforme o tipo de conta. Na odontologia, por exemplo, o perfil da clínica fica com conteúdo educativo, bastidores éticos e informação; resultado com paciente só aparece no perfil do profissional que executou, dentro das regras.

## Cuidado com guias estrangeiros e com modelos prontos

Muitos guias americanos recomendam promoções mensais, antes e depois como “ativo mais persuasivo” e prometem leads. Muitos pacotes de agência trazem modelos de anúncio pensados para vários clientes ao mesmo tempo. As duas coisas costumam conflitar com as regras brasileiras e, mesmo quando não conflitam, deixam você igual aos outros. Aproveite só as ideias de formato.

# Diferenciar dentro das regras

O conselho não proíbe a diferença. Proíbe dizê-la com adjetivos, promessas e preço. A saída é trocar a afirmação pela demonstração: em vez de dizer que você é diferente, mostre o que você faz de diferente e deixe o paciente concluir. O guia chama isso de **diferencial ético**.

| Em vez de dizer | Mostre |
|---|---|
| **"O melhor especialista da cidade"** | Para quem você atende com frequência e o que costuma ver nesses casos |
| **"Resultado garantido"** | Como você acompanha o tratamento e o que o paciente faz em cada etapa |
| **"Preço justo" ou "condições especiais"** | O que acontece na primeira consulta e quanto tempo ela dura |
| **"Atendimento humanizado"** | Uma situação concreta: como você explica um exame, como responde a uma dúvida |
| **"Tecnologia de ponta"** | O que muda para o paciente, em uma frase simples e sem superlativo |
| **"Único na região"** | O foco que você escolheu e por que escolheu |

Antes de publicar, faça a pergunta que separa os dois oceanos: **um colega da mesma especialidade poderia publicar este texto sem mudar nada?** Se sim, ele ainda não carrega o seu diferencial. Se não, confira se a diferença está demonstrada por fatos e não por adjetivos.

ATENÇÃO

**O limite muda por profissão.**
Em algumas profissões, até a forma de mostrar resultado é proibida ou restrita, como o antes e depois na odontologia em perfil de clínica ou a imagem corporal na nutrição. O diferencial ético nunca passa por cima da tabela acima. Na dúvida, passe o texto pelo Verificador ético e confira a norma vigente.

## LGPD: dado de saúde é dado sensível

A Lei 13.709/2018 exige base legal, finalidade clara e segurança para dados de saúde. Na prática:

- **Separe no CRM** o que é dado de relacionamento (nome, telefone, origem, etapa) do que é prontuário clínico. O prontuário fica no sistema de prontuário.
- **Peça consentimento específico** para mensagens de relacionamento e marketing, e ofereça saída fácil ("responda SAIR").
- **Nunca suba lista de pacientes** para públicos personalizados de anúncios sem base legal e consentimento.
- **Restrinja o acesso por função:** a secretária vê agenda, não vê evolução clínica.
- **Transcrições** de consultas, atendimentos e lives podem conter dados de pacientes. Não use como fonte de conteúdo sem autorização formal e anonimização.

O cuidado com dados também diferencia. Um paciente que percebe que as informações dele são tratadas com discrição confia mais, e confiança é a porta de entrada que este guia procura.

## Políticas das plataformas

Meta e Google têm regras próprias para saúde, além das dos conselhos. A Meta não permite anúncios que afirmem ou insinuem atributos pessoais do usuário, como condições de saúde ("Você sofre de ansiedade?"). Escreva sobre o tema, não sobre a

pessoa (“Ansiedade tem tratamento”).

## A revisão em duas etapas

Todo roteiro passa primeiro por **revisão editorial**: é específico, compreensível, entrega a promessa e carrega o seu diferencial? Depois, passa por **aprovação clínica e ética** do profissional responsável. A IA aponta problemas, mas não assume responsabilidade profissional nem garante conformidade. Nenhum conteúdo é declarado pronto enquanto houver pendência de fonte, autorização de imagem ou norma aplicável.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** superlativos, promessas, preço como chamariz e qualquer frase que precise da palavra “melhor”.
- **Reduzir:** a dependência de modelos prontos e de ideias de guias estrangeiros.
- **Elevar:** a demonstração por fatos: o que você faz, para quem e como acompanha.
- **Criar:** o seu teste de diferença, aplicado a cada peça: um colega poderia publicar isto sem mudar nada?

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Abra os seus três últimos posts e o seu último anúncio. Confira identificação profissional, ausência de superlativos e de promessa, e exposição de paciente. Depois aplique o teste da diferença: um colega poderia ter publicado aquilo? Corrija, reescreva ou arquive o que não passar.

NO CLINILOOP

**Verificador ético.**
Cole qualquer post, anúncio ou mensagem e receba os pontos que conflitam com o seu conselho, a LGPD e as políticas da Meta e do Google.

---

**Próxima passagem.** *Com as leis e o código na mochila, chegou a hora do primeiro gesto que não tem volta: dizer em público quem você é e para quem você é a escolha certa.*

NO ROTEIRO · ETAPA 2 DE 6 · POSICIONE-SE

*Na jornada · A travessia do primeiro limiar*

# 03

# Os canais, um a um: manual de configuração

*Antes de postar ou anunciar, o paciente precisa encontrar, em qualquer canal, a mesma resposta para três perguntas: quem é você, para quem você é a escolha certa e como marcar uma consulta.*

NESTA PARTE · PARTE 03

Primeiro a proposta de valor · Perfil da Empresa no Google · Instagram · YouTube · LinkedIn · TikTok · Onde tudo converge

Em toda jornada há um limiar, um ponto depois do qual não dá para voltar ao mundo comum. Aqui, o limiar é escrever a sua proposta de valor e colocá-la em todos os lugares em que o paciente procura por você. Depois disso, você deixa de ser "mais um bom profissional" e passa a ser alguém específico.

Posicionar-se é decidir em que você quer ser lembrado e repetir essa decisão em todos os lugares em que o paciente procura por você. Um perfil incompleto desperdiça as visitas que chegam até ele. Um perfil completo, mas genérico, desperdiça de outro jeito: a pessoa encontra você, não percebe nenhuma diferença e volta para a lista.

Esta parte começa pela proposta de valor e depois explica, canal por canal, o que é cada um, para que serve na saúde e como configurá-lo para que a mesma diferença apareça em todos. Comece pelo Perfil da Empresa no Google e pelo Instagram. YouTube e LinkedIn vêm em seguida, e o TikTok entra quando a sua rotina permitir.

## Primeiro a proposta de valor

Nenhum canal resolve a pergunta "por que você?". Ela precisa estar respondida antes de configurar o primeiro. A resposta é a proposta de valor: uma frase curta que diz quem você ajuda, com o quê e o que você faz de diferente no atendimento.

Para chegar a ela, aplique as ferramentas do Oceano Azul ao seu atendimento, e não à sua comunicação:

1. **Ouça antes de decidir.** Leia pelo menos dez avaliações de outros profissionais da sua área no Google e anote o que os pacientes elogiam e do que reclamam. Pergunte a cinco pacientes seus o que valorizaram e o que fez falta. Sem isso, a estratégia vira a sua opinião sobre você mesmo.
2. **Liste os fatores em que todos competem** na sua especialidade e cidade: localização, convênio, horário, preço, tempo de espera, equipamento, título.
3. **Olhe para quem não procura ninguém.** Quem começa a procurar e desiste? Quem decide não procurar? Quem nunca pensou que precisava? É nesses não clientes que costumam estar os espaços novos.
4. **Para cada fator, decida** se você vai eliminar, reduzir, elevar ou manter. Não dá para elevar tudo.

5. **Crie um ou dois fatores** que os colegas não oferecem e que o seu paciente valoriza, como um plano por escrito ao fim da avaliação, um retorno por mensagem na semana seguinte ou um foco em um público específico. Se for algo que qualquer colega poderia copiar amanhã, procure a versão que só você faz.
6. **Faça antes de mostrar.** Para cada coisa que você elevou ou criou, responda: isso já acontece no meu atendimento? Como o paciente poderia ver isso nas redes? Só vira conteúdo o que já existe.
7. **Escreva a frase** a partir do que você elevou e criou: "Ajudo [público] a [entender ou cuidar de algo], com [o que você faz de diferente]".

Na saúde, a promessa da frase é de informação e atendimento, nunca de resultado individual. Se ela servir para qualquer colega da sua especialidade, volte ao passo 5.

**Exemplo.**
Fisioterapeuta em Moema. Fatores em que todos competem: convênio, aparelhos, localização. Ela reduz a ênfase em aparelhos, eleva o tempo de avaliação para 60 minutos e cria um plano de exercícios por escrito, revisado por mensagem depois de uma semana. Frase: "Ajudo quem tem dor lombar a voltar a treinar, com avaliação de uma hora e plano de exercícios acompanhado".

Com a frase pronta, cada canal abaixo tem um lugar para ela: a descrição do Google, a bio do Instagram, a descrição do canal do YouTube, o título e o Sobre do LinkedIn. A mesma ideia, em palavras ajustadas a cada um.

| Canal | O que é | Para que serve na saúde | Prioridade |
|---|---|---|---|
| **Perfil da Empresa no Google** | A ficha da clínica na busca e no Google Maps | Ser encontrado por quem já precisa e está procurando agora | Primeiro |
| **Instagram** | Rede de fotos e vídeos curtos da Meta | Atrair pacientes, criar confiança e iniciar conversas | Primeiro |

| Canal | O que é | Para que serve na saúde | Prioridade |
|---|---|---|---|
| YouTube | Plataforma de vídeos do Google, usada como buscador | Responder dúvidas em profundidade e construir autoridade duradoura | Segundo |
| LinkedIn | Rede profissional e de reputação | Confiança de colegas que indicam, imprensa, empresas e pacientes que pesquisam o seu nome | Segundo, para autoridade e indicação |
| TikTok | Rede de vídeos curtos com forte recomendação por interesse | Alcance amplo para prevenção e dúvidas comuns | Opcional |

# Perfil da Empresa no Google

**O que é.** A ficha gratuita que aparece na busca e no Google Maps quando alguém procura o seu nome, a sua clínica ou "dentista perto de mim": endereço, horário, telefone, fotos, avaliações e botão de rota. Até 2021 se chamava Google Meu Negócio.

**Para que serve.** Captar quem já tem a necessidade e está procurando agora. Muitas vezes é o primeiro contato do paciente com a clínica, e as avaliações pesam na escolha.

## Como configurar

1. Entre em google.com/business com uma conta Google da clínica, não a pessoal. Procure primeiro se a clínica já aparece no Maps e, se aparecer, reivindique a ficha em vez de criar outra.
2. Use o nome exatamente como na fachada e nos documentos. Acrescentar palavras ao nome ("Clínica X Implantes Barato") viola as regras do Google e pode suspender o perfil.

3. Escolha a categoria principal mais precisa (“Dentista”, “Fisioterapeuta”, “Psicólogo”, “Nutricionista”, “Médico”) e acrescente categorias secundárias.
4. Preencha endereço, telefone, WhatsApp, site ou página de agendamento e horários, incluindo feriados.
5. Faça a verificação que o Google pedir (vídeo, ligação, SMS, e-mail ou carta). Sem verificação, a ficha não aparece completa.
6. Publique fotos reais: fachada, recepção, salas e equipe, além de logotipo e capa. Nunca fotos de pacientes.
7. Cadastre os serviços com descrição informativa e os atributos (acessibilidade, estacionamento). Na descrição da ficha, use a sua proposta de valor: quem você atende, como é o atendimento e onde.
8. Se você é o único profissional da clínica, mantenha uma ficha só. Em clínicas com vários profissionais, cada um pode ter a própria ficha, além da ficha da clínica.

**O que publicar.** Atualizações curtas (novidades, horários especiais, um conteúdo educativo), fotos novas a cada mês e respostas às perguntas do público.

**Avaliações.** Peça de forma neutra, após o atendimento, a todos os pacientes, nunca só aos satisfeitos e nunca em troca de benefício. Responda todas, inclusive as negativas, sem confirmar que a pessoa é paciente nem citar dados clínicos. Com o tempo, as avaliações passam a repetir o que você faz de diferente, com as palavras dos pacientes. É a prova mais forte do seu diferencial, e a única que você não escreve.

## Como postar uma atualização

1. Pesquise o nome da clínica no Google (logado na conta que administra o perfil) ou abra o app do Google Maps e toque em **Perfil da empresa**.
2. Toque em **Adicionar atualização** (ou **Criar publicação**).
3. Escreva um texto curto e útil: uma novidade, um horário especial, uma orientação geral. Sem promessa de resultado e sem preço quando o conselho não permitir.
4. Adicione uma foto real do ambiente ou da equipe, sem pacientes.
5. Escolha o botão: **Ligar**, **Agendar** ou **Saiba mais**, com o link do WhatsApp ou da página de agendamento.
6. Toque em **Publicar**. Repita a cada uma ou duas semanas; perfil atualizado transmite que a clínica está ativa.

**O que medir.** No painel de desempenho: ligações, pedidos de rota e cliques no site ou no WhatsApp.

**Plataformas de agendamento.** Se você também aparece em plataformas como a Doctoralia, use nelas a mesma foto, a mesma proposta de valor e a mesma descrição de atendimento. O paciente que chega por um caminho intermediado também confere quem você é (Anexo D).

**IA como apoio.** Um assistente de IA ajuda a escrever a descrição da ficha e dos serviços, a redigir atualizações curtas e a preparar respostas educadas às avaliações. Cole só o texto público da avaliação, nunca dados do paciente, e revise antes de publicar.

# Instagram

**O que é.** A rede de fotos e vídeos da Meta, dona também do Facebook e do WhatsApp. Os formatos principais são:

- **Reels:** vídeos curtos verticais, o principal meio de ser descoberto por quem ainda não segue você.
- **Carrossel:** post com várias imagens que se desliza, o formato mais salvo.
- **Stories:** publicações que somem em 24 horas, boas para relacionamento.
- **Destaques:** Stories fixados no perfil.
- **Direct:** mensagens privadas.

**Para que serve.** É o principal canal de captação e relacionamento. O paciente descobre você por um Reel, confere o perfil para decidir se confia e chama no Direct ou no WhatsApp.

## Antes de abrir o aplicativo: o diagnóstico

Um perfil que capta nasce de decisões tomadas antes do primeiro post. Responda por escrito:

- **Público:** quem deve se interessar e que problema enfrenta?
- **Objetivo:** gerar conversas para agendar, atrair seguidores qualificados ou encaminhar para um conteúdo completo?

- **Posicionamento:** que experiência ou perspectiva diferencia você de outros bons profissionais? Use as quatro ações do Oceano Azul, como no início desta parte.
- **Proposta de valor:** a frase que você escreveu acima. Ela orienta a bio, os destaques e os temas de conteúdo.
- **Voz:** como você fala com o paciente, que expressões usa e o que evita.
- **Fontes disponíveis:** aulas, palestras, podcasts, entrevistas e as perguntas que você mais ouve no consultório.
- **Restrição principal:** falta tempo, falta segurança para gravar, falta edição ou falta revisão?
- **Limites:** assuntos, promessas e formatos que você não vai usar, inclusive por regra do conselho.

A maioria dos especialistas não tem falta de conhecimento, e sim de reaproveitamento: o conteúdo de aulas e entrevistas já existe e não chega ao perfil (Parte 5). A IA ajuda a organizar e adaptar, mas o perfil precisa continuar soando como você.

**Pesquisa de referências.** Em uma janela anônima, analise de 10 a 20 perfis da sua área e de outras áreas. Anote o formato, a pergunta central, como cada peça começa e como termina. Anote também o que todos fazem igual: é o Oceano Vermelho da sua especialidade, e o que você vai evitar repetir. O objetivo é entender o que funciona e como fazer diferente, nunca copiar texto ou identidade.

**Identidade.** Escolha até cinco adjetivos que você quer que o paciente associe a você (por exemplo: claro, acolhedor, técnico, próximo, organizado). Defina uma cor principal, uma ou duas fontes legíveis e use-as sempre. Consistência importa mais que sofisticação.

**Temas de conteúdo.** Defina de dois a três temas fixos que nascem da sua proposta de valor e das dúvidas do paciente, como “tire dúvidas sobre tratamentos”, “bastidores e cuidado com o paciente” e “mitos e erros comuns”. Todo post precisa caber em um deles (Parte 4).

## Como configurar

1. **Conta profissional.** Nas configurações do aplicativo, mude para conta profissional e escolha a categoria correta. Ela libera as estatísticas, o botão de contato e os anúncios.
2. **Foto.** Rosto nítido e próximo, fundo simples, luz frontal. Para a conta da clínica, o logotipo legível.

3. **Nome de usuário (@).** Curto, fácil de soletrar por telefone e igual nos outros canais.
4. **Nome do perfil.** Nome mais especialidade, em palavras que o paciente pesquisa ("Dra. Ana Lima | Fisioterapia de Coluna"). Esse campo entra na busca do Instagram.
5. **Credenciais.** Médicos trazem nome, CRM, a palavra "MÉDICO" e o RQE; dentistas, nome e CRO; psicólogos, nome, "psicólogo(a)" e CRP; fisioterapeutas, nome e CREFITO; nutricionistas, nome, profissão e CRN com a região.
6. **Bio em quatro linhas:** quem você ajuda, com o quê e de que jeito, onde atende e o registro profissional. Exemplo: "Ajudo quem tem dor lombar a voltar a treinar · Avaliação de 1 hora e plano acompanhado · Moema, SP · CREFITO-3 000000-F". Sem slogan de resultado.
7. **Link.** Um destino só: WhatsApp com mensagem pronta ou uma página de agendamento, com a origem rastreada (Parte 13).
8. **Destaques:** Comece aqui, Como funciona a consulta, Convênios e valores (quando permitido), Localização, Dúvidas, Equipe.
9. **Posts fixados.** Fixe no topo até três conteúdos que apresentem você e respondam às dúvidas mais comuns.
10. **Integrações.** Vincule a conta à página do Facebook da clínica e ao WhatsApp Business. Isso é necessário para anunciar e para o botão de mensagem.

**Primeiro o conteúdo, depois a bio.** O conteúdo atrai e cria conexão, e a bio facilita o próximo passo. Uma página de links na bio pode incluir um assistente de orientação que, em uma ou duas perguntas, leva a pessoa ao destino certo (o guia, o vídeo completo, o agendamento). Na saúde, ele se apresenta como assistente de IA, usa só informações aprovadas, não inventa preços nem resultados e nunca faz triagem clínica.

## Como postar

**Reel, passo a passo:**

1. Toque em **+** e escolha **Reel**. Grave ou escolha o vídeo editado na galeria.
2. Edite no próprio aplicativo (Anexo A) e toque em **Avançar**.
3. **Capa:** toque em **Editar capa** e escolha um quadro ou envie a capa feita no Canva, com a pergunta do vídeo no centro.
4. **Legenda:** nas primeiras linhas, a dúvida respondida e a palavra-chave com a cidade; depois, o complemento, a chamada única e a identificação profissional. De 0 a 5 hashtags relevantes.

5. **Marcar pessoas e colaboradores:** só quem autorizou. Um colega convidado como colaborador divide a publicação com o perfil dele.
6. **Localização:** o bairro ou a clínica, para quem procura perto.
7. **Compartilhar no Facebook:** ative se a página da clínica também publica.
8. **Rótulo de IA:** se a peça tiver imagem ou vídeo realista gerado por IA, ative o rótulo nas configurações avançadas.
9. **Trial Reels** (contas elegíveis): ative para mostrar o vídeo primeiro a quem não segue e testar o gancho.
10. **Agendar:** em **Configurações avançadas**, ative **Agendar esta publicação** e escolha dia e hora. Senão, toque em **Compartilhar**.

**Carrossel: +** → **Publicação** → **Selecionar vários** → as imagens na ordem → **Avançar** → legenda, localização e marcações → **Compartilhar**.

**Stories: +** → **Story** → foto ou vídeo → texto e figurinhas (enquete, perguntas, link para o WhatsApp) → **Seu story**. Para fixar no perfil, abra o Story e toque em **Destacar**.

**Na primeira hora:** divulgue nos Stories, responda aos comentários com uma pergunta e, depois de uma a duas horas, veja alcance, envios e salvamentos (Parte 4).

**O que medir.** Nas estatísticas da conta: alcance entre quem não segue você, tempo de visualização dos Reels, envios, salvamentos, visitas ao perfil, cliques no link e, no CRM, as conversas que viraram consulta.

**IA como apoio.** A IA acelera o trabalho, mas não substitui a sua voz. Use um assistente para transformar as perguntas do consultório em pautas, rascunhar roteiros e textos de carrossel, sugerir legendas com palavra-chave e revisar o texto contra as regras do conselho (Partes 4, 5 e 15). Ferramentas como Canva e CapCut usam IA para sugerir layouts e gerar legendas automáticas; revise os termos técnicos. O roteiro final é seu, e a gravação também.

## YouTube

**O que é.** A plataforma de vídeos do Google. Funciona como um buscador: as pessoas digitam dúvidas (“dor no joelho ao subir escada”) e encontram vídeos que continuam aparecendo por anos. Tem vídeos longos, Shorts (vídeos curtos verticais) e transmissões

ao vivo.

**Para que serve.** Construir autoridade duradoura. O paciente que assistiu a dez minutos explicando a avaliação chega à consulta já conhecendo e confiando em você.

## Como configurar

1. Com a conta Google da clínica, crie um canal com o nome do profissional ou da clínica, igual ao do Instagram.
2. Foto, banner com especialidade e cidade, descrição com a sua proposta de valor, registro profissional e links para agendamento.
3. Verifique o canal com o número de telefone. Isso libera miniaturas personalizadas e vídeos mais longos.
4. Organize playlists por problema do paciente (“Dor no joelho”, “Ansiedade”, “Implantes”), não por formato.
5. Fixe um vídeo de apresentação: quem você é, quem atende, como é a primeira consulta.
6. Em cada vídeo: título com a dúvida que o paciente pesquisa, link de agendamento nas duas primeiras linhas da descrição e capítulos com minutagem.

## Como postar

**Vídeo longo, pelo computador:**

1. Entre em studio.youtube.com e clique em **Criar** → **Enviar vídeos**. Escolha o arquivo.
2. **Título** com a dúvida que o paciente pesquisa, em até 70 caracteres.
3. **Descrição:** o link de agendamento nas duas primeiras linhas, o resumo do vídeo, as fontes, a identificação profissional e os capítulos com minutagem (00:00 Abertura, 01:20 O que é…).
4. **Miniatura:** envie a imagem de 1280 × 720 feita no Canva.
5. **Playlist** do problema do paciente e **Público:** “Não, não é conteúdo para crianças”.
6. **Elementos do vídeo:** legendas (revise as automáticas), tela final com outro vídeo e o botão de inscrição.
7. **Visibilidade: Público**, ou **Programar** com data e hora. Clique em **Publicar**.

**Short, pelo celular:** no app do YouTube, **+** → **Criar um Short** → grave ou importe um vídeo vertical de até 3 minutos → edite → **Avançar** → título com a dúvida e palavra-chave → **Enviar Short**.

**O que medir.** No YouTube Studio: tempo de exibição, retenção, termos de busca que trouxeram as pessoas e cliques nos links.

**IA como apoio.** A partir da transcrição do vídeo (o YouTube Studio gera legendas automáticas), um assistente de IA sugere títulos com a dúvida que o paciente pesquisa, escreve a descrição, marca os capítulos e propõe trechos para Shorts. Confira a minutagem e corrija os termos clínicos nas legendas.

## LinkedIn

**O que é.** A rede profissional. É ali que colegas, jornalistas, empresas e departamentos de recursos humanos conferem quem você é antes de indicar, convidar ou contratar.

**A natureza da rede.** O LinkedIn é uma rede de reputação profissional. As pessoas não entram nele para se distrair, e sim para aprender, acompanhar a própria área, contratar, ser contratadas e decidir em quem confiar. A distribuição favorece conversas qualificadas e conteúdo de conhecimento: um comentário técnico bem escrito em uma publicação de colega alcança justamente quem importa. O perfil é público e costuma aparecer entre os primeiros resultados quando alguém pesquisa o seu nome no Google.

**No que ele contribui para um perfil da área da saúde:**

- **Indicação de colegas (decisão 3 da Parte 1).** É onde médicos, dentistas, fisioterapeutas e psicólogos conferem a sua formação e o seu raciocínio clínico antes de encaminhar um paciente. A rede de indicação da Parte 8 ganha força quando o colega já conhece o seu trabalho por ali.
- **Confiança de quem pesquisa o seu nome.** Pacientes, sobretudo os que chegam por indicação ou têm um perfil mais executivo, pesquisam o profissional antes da consulta. Um perfil completo, com formação, títulos e publicações, responde à pergunta “posso confiar?”.
- **Imprensa, eventos e ensino.** Jornalistas, organizadores de congressos, faculdades e programas de pós-graduação procuram especialistas no LinkedIn para entrevistas, aulas e palestras. Cada convite vira prova de autoridade para os outros canais.

- **Empresas e saúde corporativa.** Departamentos de recursos humanos, operadoras e empresas que contratam programas de saúde, palestras ou parcerias decidem por ali.
- **Carreira e equipe.** Para clínicas, é o canal para atrair bons profissionais e mostrar a cultura da equipe.

**O que publicar.** O conteúdo mais técnico e reflexivo: sínteses comentadas de artigos científicos, aprendizados de congressos, opiniões técnicas fundamentadas, bastidores da formação e da equipe, o raciocínio por trás de um tipo de avaliação, sem identificar pacientes. O tom é de colega para colega, mas sempre compreensível. O público principal são profissionais e instituições; o paciente lê como prova de seriedade.

## Encontrado e escolhido

O perfil precisa vencer duas provas. A primeira é **ser encontrado** quando um colega, jornalista ou organizador de evento pesquisa: as palavras do seu perfil precisam coincidir com as que essas pessoas digitam. A segunda é **ser escolhido** quando ele abre a sua página entre outras: em poucos segundos, quem lê precisa entender o que você faz, para quem e com que prova. Pense no perfil como uma apresentação, e não como um currículo publicado.

## Anatomia do perfil

| Elemento | O que ele precisa fazer | Erro comum |
|---|---|---|
| Foto | Rosto nítido, luz frontal, expressão acessível e roupa de trabalho | Foto recortada de evento ou de anos atrás |
| Banner | Reforçar a especialidade, a cidade ou uma frase de posicionamento | Deixar o fundo padrão |
| Título | Dizer o que você faz, para quem e com que prova, usando palavras buscáveis | Só a profissão |
| Sobre | Contar em poucos parágrafos o problema que você resolve e as provas | Lista de adjetivos sem evidência |

| Elemento | O que ele precisa fazer | Erro comum |
|---|---|---|
| Experiência | Mostrar onde atende, escopo e resultados de cada posição | Copiar a descrição do cargo |
| Em destaque | Exibir provas: artigo, palestra, aula, entrevista, prêmio | Ficar vazio |
| Licenças e certificados | Registro no conselho, títulos de especialista, certificações | Registro ausente |
| Recomendações | Trazer vozes de colegas, professores e parceiros | Nenhuma recente |

**O título: 220 caracteres que trabalham por você.** O título aparece nos resultados de busca, nos comentários e nos convites. Fórmula: [profissão e especialidade] | [área de atuação ou público] | [prova: título, formação ou experiência] | [onde atende]. Exemplo: "Ortopedista | Cirurgia do Joelho e Medicina Esportiva | RQE 00000 | Atendimento em Campinas". Para o colega que vai indicar, o foco escrito no título é o que diz quando encaminhar o paciente para você.

**O Sobre em quatro blocos.** O Sobre aceita até 2.600 caracteres, mas só as primeiras linhas aparecem antes do "ver mais". Escreva em primeira pessoa:

- **Abertura:** uma frase sobre o problema que você ajuda a resolver ou a sua convicção profissional.
- **O que você faz:** áreas de atuação, tipo de paciente, onde atende e como trabalha.
- **Provas:** formação, títulos, publicações, aulas e experiências concretas.
- **Chamada:** como colegas podem encaminhar pacientes e como falar com você.

**Palavras-chave.** Use os termos que colegas e jornalistas pesquisam: especialidade, procedimentos, áreas de interesse e cidade. Distribua pelo título, Sobre, experiências e competências, sem forçar repetições.

**Presença sem esforço excessivo.** Diariamente, 10 minutos: comente com profundidade duas ou três publicações de colegas. Semanalmente, uma publicação técnica curta. Mensalmente, peça uma recomendação e atualize o Em destaque. Sempre, convites com uma linha pessoal explicando por que você quer se conectar. Registre no CRM os colegas com quem interagiu (Parte 8).

## Auditoria do perfil

- Foto atual, nítida e profissional
- Banner com especialidade e cidade
- Título com especialidade, público, prova e local
- Sobre em quatro blocos, com chamada para colegas no final
- Experiências com locais de atendimento e escopo
- Registro no conselho e títulos em Licenças e certificados
- Pelo menos uma recomendação dos últimos 12 meses
- Em destaque com ao menos uma prova
- URL personalizada do perfil

Quando houver equipe, crie também a página da clínica no LinkedIn e vincule os profissionais a ela.

## Como postar

1. Na página inicial, clique em **Começar publicação**.
2. **Texto:** as duas primeiras linhas aparecem antes do “ver mais”; abra com a ideia central ou uma pergunta técnica. Parágrafos curtos, espaço entre eles.
3. **Mídia:** foto, vídeo (edite antes, com legenda no vídeo) ou **documento** em PDF, que aparece como carrossel de páginas. O carrossel feito no Canva pode ser baixado em PDF e publicado assim.
4. **Menções:** marque com @ colegas, instituições ou eventos citados, quando fizer sentido e sem expor ninguém.
5. **Hashtags:** de uma a três, da especialidade.
6. Clique em **Publicar**, ou no ícone de relógio para **agendar**.

7. **Na primeira hora,** responda a todos os comentários. Conversa nos comentários é o principal sinal de distribuição do LinkedIn.

**Artigo e newsletter:** em **Escrever artigo**, publique textos longos (uma revisão de tema, um guia para colegas). A newsletter transforma artigos periódicos em assinatura: quem assina recebe aviso a cada edição.

**IA como apoio.** Cole o seu currículo em um assistente de IA e peça cinco títulos de até 220 caracteres e um Sobre em quatro blocos, sem inventar títulos, números ou resultados. A IA também ajuda a resumir um artigo científico em uma publicação técnica; confira sempre a referência original antes de publicar, porque assistentes de IA podem errar citações.

# TikTok

**O que é.** Rede de vídeos curtos verticais em que a recomendação depende mais do interesse de quem assiste do que de quem segue: um perfil novo pode alcançar muitas pessoas sem ter seguidores.

**Para que serve.** Alcance amplo para temas de prevenção e dúvidas comuns. É menos direto para gerar agendamentos que o Instagram. Comece por ele só quando já tiver uma rotina de produção no Instagram.

## Como configurar

1. Crie a conta com o e-mail da clínica e mude para conta empresarial nas configurações.
2. Use o mesmo nome, foto, credenciais e proposta de valor do Instagram.
3. O link na bio pode depender do tipo de conta e do número de seguidores; quando disponível, use o mesmo destino único.

**O que publicar.** Os mesmos roteiros dos Reels, exportados sem a marca d'água de outra rede (o Instagram e o TikTok reduzem o alcance de vídeos com marca de outra plataforma). Tendências só quando couberem no tema e na ética.

**Cuidados.** Não responda dúvidas clínicas individuais nos comentários; convide para o canal oficial. Humor nunca ridiculariza quem sente dor ou insegurança. Anúncios de saúde no TikTok têm regras próprias: confira a política vigente antes de anunciar.

### Como postar

1. Toque em **+**, grave ou toque em **Carregar** para escolher o vídeo editado.
2. Edite (Anexo A) e toque em **Avançar**.
3. **Descrição:** a dúvida respondida, a palavra-chave e a identificação profissional. Poucas hashtags, relevantes.
4. **Capa:** toque em **Selecionar capa** e escolha o quadro com a pergunta na tela.
5. **Localização** e **Quem pode assistir:** Todos.
6. **Mais opções:** ative **Rotular conteúdo gerado por IA** se for o caso; use **Divulgação de conteúdo** quando houver parceria paga.
7. Toque em **Publicar**. Para agendar, envie pelo **TikTok Studio** no computador.

**O que medir.** Visualizações, tempo médio assistido, compartilhamentos e visitas ao perfil.

**IA como apoio.** Peça à IA para adaptar um roteiro de Reel ao tom do TikTok e sugerir ganchos alternativos. Use as legendas automáticas do próprio aplicativo ou do CapCut e revise antes de publicar.

## Onde tudo converge: WhatsApp Business e CRM

Todos os canais levam ao mesmo lugar: uma conversa no WhatsApp Business (Parte 10) registrada no CRM (Parte 13) com a origem marcada. Sem esse registro, você não sabe qual canal trouxe pacientes e qual só trouxe curtidas, nem qual porta de entrada traz os pacientes que ficam.

Faça um teste de coerência antes de seguir: abra os seus perfis lado a lado. Se uma pessoa visse só um deles, entenderia a mesma coisa sobre quem você atende e como? Se cada canal conta uma história diferente, o paciente não forma uma ideia clara de você, e a diferença se perde.

PROMPT PRONTO

**Auditoria de perfis e canais**

Você é consultor de marketing ético para profissionais de saúde no Brasil.

Analise meus perfis abaixo e devolva, para cada canal: (1) o que impede um paciente ou colega de confiar, (2) o que impede de agendar ou encaminhar, (3) se a minha proposta de valor aparece ou se o perfil poderia ser de qualquer colega, (4) a correção sugerida. Depois escreva uma bio de Instagram de até 150 caracteres, um título de LinkedIn de até 220 caracteres e a descrição do Perfil da Empresa no Google, todos a partir da minha proposta de valor. Respeite as normas do [CONSELHO], não use superlativos nem promessas de resultado e não invente títulos ou números.

Profissão: [PROFISSÃO] | Especialidade: [ESPECIALIDADE] | Cidade: [CIDADE]

Público ideal: [QUEM VOCÊ QUER ATENDER]

Proposta de valor: [SUA FRASE DE DIFERENCIAL]

Instagram: [COLE A BIO] | LinkedIn: [COLE TÍTULO E SOBRE]

Google: [COLE A DESCRIÇÃO] | YouTube ou TikTok: [COLE A DESCRIÇÃO]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Instagram atual: "Nutri 💪 Emagreça com saúde | Resultados reais | Agende já ⬇️". Sem cidade, sem registro, link para um grupo de WhatsApp.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

INSTAGRAM
1. O que impede de confiar: "Resultados reais" promete resultado sem mostrar nada, e o CFN restringe esse tipo de promessa. Faltam nome do conselho, número de registro e especialidade.
2. O que impede de agendar: não diz onde você atende nem para quem. O link leva a um grupo, não a uma conversa direta.
3. Correção: tirar a promessa, trocar "Nutri" por "Nutricionista esportiva", incluir CRN, bairro e um link direto para o WhatsApp.

Bio sugerida (108 caracteres):
Nutricionista esportiva (CRN-3 00000) | Corredores de 30 a 50 anos | Pinheiros, SP | Agende pelo WhatsApp ⬇️

LINKEDIN (título, 99 caracteres)
Nutricionista esportiva | Alimentação para corredores amadores | Pinheiros, São Paulo | CRN-3 00000

GOOGLE (Perfil da Empresa)
Consultório de nutrição esportiva em Pinheiros, São Paulo. Consultas presenciais e online para corredores amadores, com plano alimentar por escrito e reavaliações. Nutricionista responsável: Bia Nunes, CRN-3 00000.

PENDÊNCIAS: confirmar o número do CRN; conferir se o horário e o endereço do Google estão atualizados.

### ANTES DE USAR

- Troque o CRN fictício pelo seu.
- Confira cada frase com a norma vigente do seu conselho.
- Não use "referência", "melhor" ou "especialista" sem título que comprove.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** perfis abandonados em canais que você não alimenta e descrições copiadas de colegas.
- **Reduzir:** a lista de títulos e cursos na bio; uma prova bem escolhida vale mais que dez.
- **Elevar:** a clareza sobre para quem você é a escolha certa, repetida em todos os canais.
- **Criar:** uma frase de proposta de valor que só você poderia assinar, e um vídeo fixado que a explica.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Escreva a sua proposta de valor com as quatro ações. Depois pesquise seu nome e sua clínica no Google Maps: se a ficha não existir ou estiver incompleta, crie ou reivindique o Perfil da Empresa no Google com a nova descrição, e reescreva a bio do Instagram em quatro linhas.

NO CLINILOOP

**Passos 3 e 4 do caminho, e Nicho e diferencial.**
O passo 3, Estratégia Oceano Azul, percorre os sete passos acima, diz com honestidade se o resultado é um espaço novo ou uma diferença dentro do mercado existente e entrega um plano de 12 semanas para mostrar a diferença nas redes. O passo 4 tem um cartão para cada canal (Google, Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok): você cola o texto de hoje, gera o prompt daquele canal, que audita e reescreve bio, título e descrições a partir do seu perfil e do seu diferencial, e marca o checklist de configuração. Na Caixa de ferramentas, Nicho e diferencial ajuda a escolher o nicho e a frase.

---

**Próxima passagem.** *O limiar ficou para trás. Do outro lado começam as provas, e a primeira é a que mais pede de você: transformar o que você sabe em conteúdo que só você poderia publicar.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · As provas: o conteúdo*

# 04

# Conteúdo que gera autoridade e alcance

*O conteúdo é onde a sua diferença deixa de ser uma frase e vira prova. Ele cresce quando responde, em poucos segundos e com segurança, uma dúvida real, e quando só poderia ter sido feito por você.*

---

NESTA PARTE · PARTE 04

Conteúdo que só você poderia publicar · O que o Instagram premia · A escada de crescimento · Três temas por profissão · O que você sabe e o que você atende · Pautas · Formatos recorrentes · Roteiro de Reel · Indicadores da ressonância · Ser citado

Do outro lado do limiar, as provas começam. A primeira é a do conteúdo, e ela tem um adversário silencioso: o texto correto, educado e igual ao de todo mundo, que a inteligência artificial agora produz em segundos.

Esta parte combina um método de crescimento de perfis, uma síntese de formatos de vídeo adaptada a clínicas e a pesquisa sobre o algoritmo feita em outubro de 2026. Viralizar nunca é garantido e, para uma clínica, nem é o objetivo. O objetivo é que a pessoa certa reconheça você: entenda como você pensa, como explica e para que tipo de caso você é a escolha certa, antes de chamar.

## Conteúdo que só você poderia publicar

Hoje, qualquer pessoa gera em segundos um texto correto sobre "5 cuidados com a saúde bucal". Por isso, um texto correto já não diferencia ninguém. Ele ocupa o feed, mas não faz o paciente lembrar de você. O conteúdo que diferencia tem pelo menos uma de três origens que nenhum colega e nenhuma IA podem copiar:

- **As dúvidas do seu consultório,** nas palavras dos seus pacientes, agregadas e sem identificar ninguém. Elas mostram que você ouve.
- **O seu raciocínio clínico,** a forma como você explica uma avaliação, compara caminhos e diz o que depende de cada caso. Ele mostra como você pensa.
- **A sua forma de atender,** os bastidores do que você elevou e criou na Parte 3, como o plano por escrito, a avaliação mais longa ou o retorno por mensagem. Ela mostra o que o paciente vai encontrar.

A inteligência artificial é ótima para organizar, rascunhar e revisar esse material. Sem ele, ela produz o conteúdo médio da internet, que é exatamente o Oceano Vermelho. Por isso, todo prompt deste guia pede o seu contexto e o seu diferencial.

Uma regra decide o que entra nessa terceira origem: **só vira conteúdo a diferença que já acontece no consultório.** Um Reel sobre o plano por escrito que você ainda não entrega promete o que a consulta não cumpre, e isso destrói a confiança que o conteúdo deveria construir. A ferramenta Estratégia Oceano Azul pergunta, item por item, o que já está implementado e como mostrar, e monta um plano de 12 semanas para demonstrar a diferença com uma série recorrente.

A IDEIA CENTRAL

**O teste da diferença também vale para o conteúdo.**
Um colega da mesma especialidade poderia publicar este vídeo sem mudar nada? Se sim, falta uma das três origens acima. Acrescente um exemplo do seu consultório, a sua forma de explicar ou um bastidor do seu atendimento.

## O que o Instagram premia

Conferido em outubro de 2026. Reconfira periodicamente.

- **Tempo de visualização e conclusão,** inclusive reassistir. É o sinal mais forte em Reels.
- **Envios por mensagem** em relação ao alcance. É o que leva o conteúdo a quem ainda não segue você.
- **Curtidas em relação ao alcance,** mais relevantes entre seguidores.
- **Salvamentos, comentários longos, conversas, visitas ao perfil e originalidade.** Repost sem valor agregado perde alcance.
- **Hashtags não aumentam alcance** (use de 0 a 5, relevantes). Palavras-chave na fala, no texto na tela, na legenda, no nome e na bio, sim.
- **Trial Reels** testam um vídeo primeiro com quem não segue, em contas públicas com mais de 1.000 seguidores. Carrosséis são os mais salvos; fotos únicas performam pior.

Os três primeiros sinais foram confirmados publicamente pela própria plataforma. O restante é heurística de fontes de mercado.

## A escada de crescimento

O crescimento de um perfil acontece em sete degraus, e cada um prepara o seguinte. Aqui eles estão adaptados ao Instagram e à saúde.

A IDEIA CENTRAL

**1. Entender a plataforma.**
A plataforma entrega o que segura atenção. Seu trabalho é falar a língua dela: tema claro, retenção e compartilhamento.

**2. Definir a promessa.** Use a proposta de valor da Parte 3: "Ajudo [paciente com perfil X] a [entender ou cuidar de algo] com [diferencial]". Na saúde, a promessa é de informação e atendimento, nunca de desfecho individual. Defina até cinco adjetivos de marca e três temas de conteúdo.

**3. Montar a vitrine.** Palavra-chave no nome e na bio, credenciais corretas, link único para o canal oficial (Parte 3).

**4. Produzir com rotina.** Ideia, palavra-chave, gancho, roteiro, gravação, edição, capa, legenda e publicação.

**5. Ler os números.** Compare formatos e temas, não posts isolados.

**6. Combinar formatos.** Reels para descoberta, carrosséis para salvamento, Stories para relacionamento, parcerias com colegas para audiência cruzada.

**7. Fixar metas que cabem na semana.** Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo. Por exemplo: "3 Reels e 1 carrossel por semana durante 8 semanas" ou "20 conversas qualificadas por mês".

## Exemplos de promessa

- **Fisioterapeuta:** "Ajudo corredores amadores a entender a dor no joelho e a voltar a treinar com segurança, com reabilitação baseada em força".
- **Psicóloga:** "Ajudo adultos a entender a ansiedade no trabalho e a saber quando procurar terapia".

# Três temas de conteúdo por profissão

| Profissão | Tema 1: educar | Tema 2: humanizar | Tema 3: desmistificar |
|---|---|---|---|
| **Médico** | Quando procurar avaliação, o que levar à primeira consulta | Rotina, formação, congressos | Mitos e informações falsas sobre a doença |
| **Dentista** | Como funciona cada avaliação e tratamento | Bastidores, biossegurança, equipe | Mito ou verdade (clareamento, aparelho, implante) |
| **Psicólogo e psiquiatra** | Psicoeducação: o que é, como se trata | Como é uma sessão, o que a terapia não é | Estigmas e confusões comuns |
| **Fisioterapeuta** | Como funciona a avaliação, prevenção de lesão | Equipe, estrutura, raciocínio clínico com modelo | Mitos sobre dor, repouso, coluna |
| **Nutricionista** | Como funciona a consulta e o plano alimentar, leitura de rótulos | Rotina do consultório, preparo de refeições sem marcas em destaque | Mitos sobre dietas da moda e alimentos “proibidos” |

A tabela é um ponto de partida comum a toda a profissão, e por isso ainda é Oceano Vermelho. Faça dela a sua: pelo menos um dos três temas deve nascer diretamente do seu diferencial. Uma fisioterapeuta que criou o plano de exercícios acompanhado pode ter o tema “a semana depois da avaliação”; um dentista que atende adultos com medo pode ter “como é, de verdade, cada etapa”.

# O que você sabe e o que você atende

Uma proporção de partida, comum no marketing digital: perto de 80% do conteúdo mostra o que você sabe; perto de 20% mostra o que você atende e como agendar. Não é regra. É um lembrete de que o perfil que só anuncia serviço perde quem ainda não precisa, e o que nunca fala de serviço deixa o paciente sem saber que pode marcar.

Nos 20% sobre o atendimento, mostre a diferença em vez de anunciar o serviço. "Agende a sua avaliação" diz o mesmo que todos os colegas. "Na avaliação, a gente conversa uma hora e você sai com o plano por escrito" diz o que só você faz.

Dentro do que você sabe, organize o conteúdo em três camadas, conforme quem vai ver:

| Camada | Para quem | O que publicar | Quanto |
|---|---|---|---|
| **Ajuda** | Quem busca uma resposta agora | Respostas diretas às dúvidas que o paciente pesquisa: Reels, carrosséis, vídeos no YouTube, atualizações no Perfil da Empresa | A maior parte do volume |
| **Vínculo** | Quem já segue você ou já é paciente | Séries recorrentes, bastidores, como funciona o tratamento, lives para responder objeções, orientações pós-consulta | Toda semana, em menor número |
| **Destaque** | A comunidade inteira | Poucas ações com potencial de ser comentadas: palestra aberta, campanha de saúde do mês (Outubro Rosa, Novembro Azul), entrevista, evento com colegas | Poucas vezes por ano |

As três camadas vêm do planejamento de conteúdo do YouTube, onde se chamam *Help*, *Hub* e *Hero*. Na saúde, o "Destaque" nunca é sorteio, brinde ou promoção: vários conselhos proíbem (Parte 2).

# Pautas pela jornada do paciente

Organize o banco de pautas pelo momento em que o paciente está: entender um sintoma, compreender a avaliação, comparar caminhos de cuidado, preparar-se para a consulta, acompanhar o tratamento, conhecer a equipe. As perguntas frequentes do consultório, agregadas e sem expor conversa privada, são o melhor banco de pautas.

Registre cada pauta com: dúvida, público, momento da jornada, formato, fonte clínica, imagem de apoio, responsável pela revisão e CTA.

- **Odontologia:** "Como é uma avaliação para implante?", com modelo ou fluxograma (exame, planejamento, discussão individual), sem indicar tratamento à distância.
- **Medicina:** "O que levar à primeira consulta?" (exames anteriores, lista de medicamentos, dúvidas), sem diagnóstico nem orientação de suspender remédio.
- **Fisioterapia:** "Como funciona uma avaliação fisioterapêutica?", com o próprio profissional ou modelo, sem sequência universal de exercícios.
- **Psicologia:** "Como é uma primeira sessão de terapia?", sem casos reais.

## Ouça o mercado, não só o seu perfil

Curtidas e comentários dizem como foi o seu post. Não dizem o que o mercado está perguntando. Uma vez por mês, reserve 30 minutos para ouvir fora do seu perfil:

- **As conversas de atendimento:** as dúvidas que chegam no WhatsApp e no Direct, agregadas, sem nomes nem casos.
- **Os comentários em perfis de referência:** as perguntas que o público faz a colegas da sua área e que ficam sem resposta.
- **As avaliações de outras clínicas da região no Google:** o que os pacientes elogiam e do que reclamam (espera, explicação, preço, atendimento).
- **As buscas em alta:** o Google Trends e a busca do YouTube mostram como as pessoas escrevem a dúvida.

- **As notícias de saúde da semana:** o assunto que os pacientes vão levar para a consulta.

Cada sinal vira uma pauta, um ajuste no atendimento ou uma objeção respondida no fechamento (Parte 12).

## Formatos recorrentes: séries que o público reconhece

Produzir em séries reconhecíveis poupa decisões e cria o hábito de voltar. Adaptados à saúde, os princípios são:

- **Promessa, curiosidade e recompensa.** Promessa clara, curiosidade a serviço da explicação, resposta cedo e recompensa de compreensão no fim.
- **Quadros recorrentes.** "Pergunta do consultório", "Como funciona a avaliação?", "Mito ou verdade". Uma pergunta por episódio. O seguidor reconhece a série e volta.
- **Personagens editoriais.** Se encenar uma dúvida, deixe claro que é representação. Personagem não é credencial, e humor nunca ridiculariza quem sente dor ou insegurança.
- **Formatos de vídeo.** Tela dividida ou tela verde para explicar uma ilustração autorizada; vídeo caseiro para respostas próximas; quadro a quadro para mostrar etapas ou ambiente sem terceiros; ranking só com critério e fonte declarados, nunca "o melhor tratamento".
- **Análise de referências.** Leia como as peças de referência começam, sustentam e encaminham, no seu nicho e em outros mercados, sem copiar texto nem identidade. Não construa pauta só porque um vídeo teve pico de audiência fora do seu público.
- **Frequência cabe na qualidade.** Postar todo dia não é virtude. A frequência é a que você consegue revisar.
- **Sem exageros sobre o cérebro.** Não afirme que um vídeo "ativa dopamina" ou "gera cortisol" no espectador.

### O ciclo de adaptação de referências

Quando uma peça de referência funciona, adapte-a em quatro movimentos: **Referência** (escolha uma peça e anote a estrutura), **Observação** (o que prende, onde a promessa é entregue), **Adaptação** (reescreva para o seu tema e a sua voz) e **Troca** (substitua exemplos, imagens e termos por material seu e autorizado).

> ATENÇÃO
>
> **Não confunda com ROAS.**
> O ciclo acima serve para criar roteiros. ROAS, em mídia paga, é a receita atribuída dividida pelo gasto em anúncios (Parte 9).

## Roteiro de Reel para saúde

1. **Pergunta específica** (0 a 3 segundos), com texto grande na tela. "Gelo ou calor na dor nas costas?"
2. **Resposta curta,** logo no início.
3. **Demonstração ou exemplo seguro,** com o profissional, um modelo ou uma ilustração.
4. **Limite da orientação:** o que depende de avaliação individual.
5. **Próxima ação única:** enviar para alguém, salvar, ou conhecer o atendimento.
6. **Final que retoma a abertura:** a última frase conversa com a primeira, o que convida a assistir de novo.

Para clínicas, teste de 30 a 60 segundos quando o assunto couber, sem cortar explicação essencial. Use legenda na tela sem cobrir o que se demonstra e revise termos técnicos nas legendas automáticas. Um vídeo longo não vira bom Reel só por ser cortado: regrave abertura e fechamento.

### Ganchos sem sensacionalismo

- "Antes de escolher [procedimento], entenda o que a avaliação precisa esclarecer."
- "Essa dúvida aparece com frequência na consulta: [pergunta]. A resposta depende de [fator]." (só se a frequência foi observada)

- “Você sabe a diferença entre [A] e [B]? Veja neste modelo.”
- “Uma imagem sozinha não responde tudo. Vou explicar o que também entra na avaliação.”
- “O que você pode preparar antes da sua primeira consulta?”

**Evite:** cura em segundos, ameaça de desastre, “o segredo que os médicos escondem”, garantia de resultado, diagnóstico por aparência, percentual sem fonte, explorar vergonha ou insegurança corporal.

## YouTube, carrossel e Stories

- **YouTube** (6 a 10 minutos como ponto de partida): abertura de 0 a 20 segundos nomeando a dúvida; de 20 a 60 segundos, a resposta central e o que depende de avaliação individual; 3 a 5 blocos com ideia, exemplo seguro e limitação; fechamento com recapitulação e próximo passo sem urgência. Escreva três títulos com a mesma promessa verdadeira. Miniatura sem radiografia nem transformação fictícia. Descrição com fontes, identificação profissional e canal oficial.
- **Carrossel** (5 a 10 slides): capa com promessa precisa, uma ideia por slide, penúltimo com o insight mais compartilhável, último com o CTA. Serve para comparar etapas, preparar a consulta e guardar checklists; nunca para árvore de autodiagnóstico.
- **Stories:** bastidores sem pacientes identificáveis, equipe, dúvidas gerais. Enquete sobre temas, nunca sobre histórico de saúde.
- **LinkedIn:** reescreva o melhor tema do mês em tom técnico, com referência científica, para colegas.

## Gravação e confiança na câmera

Celular, luz natural e um ponto silencioso bastam. Fundo sem prontuários, telas ou dados de pacientes. Teste a voz e confira o enquadramento na tela do celular. Nada de filtros que alterem a aparência de um resultado clínico. Para perder o medo da câmera, ensaie sem obrigação de publicar e revise um aspecto por vez: clareza, velocidade, apoio visual. Equipamento, luz, som, enquadramento e teleprompter estão na Parte 6; a edição, na Parte 7.

# Frequência sustentável

| Rotina | Instagram | YouTube | LinkedIn |
|---|---|---|---|
| Profissional sozinho | 2 Reels + 1 carrossel por semana, Stories em dias de atendimento | 1 vídeo por mês | 1 post por semana |
| Clínica com equipe | 3 Reels + 2 carrosséis por semana, Stories diários | 2 a 4 vídeos por mês | 2 posts por semana |

**A primeira hora depois de publicar** (heurística de mercado): divulgue nos Stories, responda os comentários com uma pergunta e, depois de uma a duas horas, veja alcance, envios e salvamentos. O que performar bem vira anúncio (Parte 9).

# Medir sem confundir grandeza com resultado

- **Views** seguem a definição de cada plataforma. Não compare Reels, Shorts e YouTube longo como a mesma unidade de atenção.
- **Interação pública por view** = (curtidas + comentários) ÷ views × 100. Não é engajamento total: não inclui envios nem salvamentos.
- **Use a mediana** de views de peças comparáveis, não a média. Retenção vem dos dados da conta.
- **Conversão** são contatos qualificados, agendamentos e comparecimentos vindos do conteúdo, medidos no CRM (Parte 13).
- **Reconhecimento** é o sinal que mais interessa a este guia: a pessoa que chama dizendo "vi o seu vídeo sobre…" ou "a doutora que explica…". Anote no CRM a origem e a peça citada. É assim que você descobre quais conteúdos trazem pacientes pela porta da confiança.

- **Ciclo de testes:** uma variável por vez (pergunta, abertura, demonstração ou convite), lote pequeno e comparável, registro de data, formato e duração. Muito alcance e pouca permanência: revise promessa e entrega. Muitos contatos e poucas consultas: revise público, localização e atendimento antes de culpar o roteiro.

## Os indicadores da ressonância

Conteúdo que ressoa passa por três etapas, nesta ordem: prende a **atenção**, **retém** e gera **interação**. Meça na mesma ordem. Se a atenção falha no primeiro segundo, não adianta analisar curtidas. E alcance não é influência: muita gente vê, poucos ficam, e são os que ficam que chegam à consulta.

| Indicador | O que mede | Referência de mercado | Leitura para a saúde |
|---|---|---|---|
| **Atenção inicial** | Se a pessoa parou de rolar | No feed do celular, a pessoa decide em cerca de 1,7 segundo se para ou passa (pesquisa do Facebook) | A pergunta escrita na tela já no primeiro quadro, sem vinheta nem apresentação |
| **Retenção em vídeo curto** | Quanto do vídeo foi assistido | Reter cerca de 15 segundos tende a fazer o Instagram mostrar o vídeo a mais gente; um Reel de 60 segundos retém, em média, de 12 a 15 segundos | Resposta central antes dos 15 segundos; o restante aprofunda e traz o limite da orientação |
| **Retenção em vídeo longo** | Tempo médio assistido | Um vídeo de 16 minutos no YouTube retém, em média, cerca de 8 minutos | O YouTube é onde se explica a avaliação e o tratamento, e onde a confiança se constrói |

| Indicador | O que mede | Referência de mercado | Leitura para a saúde |
|---|---|---|---|
| **Interação real** | Envios, salvamentos e comentários com conteúdo | Engajamento real (enviar, salvar, perguntar) pesa mais que o superficial (curtir de passagem); a Meta confirma envios e curtidas por alcance como sinais | Um envio vale mais que uma curtida; um comentário com dúvida vira pauta |
| **Rejeição** | Quem pula o vídeo ou deixa de seguir | Em palestra de mercado, 80% das pessoas rejeitariam conteúdo genérico e 43% deixariam de seguir por isso (números sem fonte divulgada) | Veja, nas estatísticas da conta, quantos deixaram de seguir na semana; pico depois de post genérico ou promocional é sinal de ajuste |
| **Validação por terceiros** | O que outras pessoas dizem de você | 77% dos brasileiros já decidiram uma compra com base em conteúdo de outros consumidores (pesquisa da mLabs) | Avaliações no Google e indicações registradas no CRM, nunca depoimento pedido em troca de benefício |

Os números vêm de palestras e pesquisas de mercado de 2025 e 2026, listadas em Fontes. Variam por conta, nicho, país e período. Use-os como referência e compare cada vídeo com a mediana dos seus próprios vídeos do mesmo formato.

ATENÇÃO

**Um dado que este guia não usa.**
É comum ouvir que a atenção humana caiu para 8 segundos, menos que a de um peixe-dourado. O estudo de origem é contestado e não mede atenção dessa forma. O que vale, e os números acima mostram, é que os primeiros segundos de cada peça decidem se ela será vista.

## Ser citado, não só publicar

A disputa já não é só por atenção; é por credibilidade. Antes de marcar, o paciente confere o que outras pessoas dizem de você. Os assistentes de IA fazem o mesmo quando alguém pergunta "qual dentista procurar em São Roque": respondem com base em avaliações, entrevistas, artigos e perfis profissionais, não só no seu Instagram. Publicar mais no próprio perfil ajuda pouco se ninguém mais fala de você.

Na saúde, fazer os outros falarem de você tem limites claros. O que pode, e funciona:

- **Avaliações no Google,** pedidas a todos os pacientes depois do atendimento, nunca em troca de benefício (Parte 3).
- **Indicação técnica de colegas,** registrada e cuidada (Parte 8), e collabs com colegas de outras áreas.
- **Presença como fonte:** entrevistas para a imprensa local, palestras em escolas e empresas, posts técnicos no LinkedIn, participação em podcasts.
- **O mesmo nome, especialidade e cidade em todo lugar:** Google, Instagram, YouTube, LinkedIn, plataformas de agendamento e site. É assim que buscadores e IAs entendem que se trata da mesma pessoa.
- **Experiência que merece ser contada:** pontualidade, explicação clara e acompanhamento depois da consulta. Quem conta para alguém faz isso por conta própria.

O que não pode, pelas regras dos conselhos e das plataformas: depoimento inventado ou pago, recompensa por avaliação, "indique e ganhe", sorteio e repostar conteúdo de paciente que o seu conselho não permite. Para os médicos, o que se reposta passa a ser conteúdo próprio (Parte 2).

# Estruturas que vale adaptar

Uma amostra editorial de perfis clínicos brasileiros analisados em outubro de 2026, não um ranking. Use as estruturas, não os conselhos clínicos, e não atribua resultado às views. Os perfis estão listados em Fontes e agradecimentos.

| Área | Estrutura que vale adaptar |
|---|---|
| **Pediatria** | Pergunta específica, acolhimento, passos compreensíveis, registro e RQE visíveis |
| **Odontologia** | Quadro Mito ou Verdade com afirmações verificadas |
| **Odontologia estética** | Analogia concreta para explicar raciocínio e acompanhamento |
| **Ortopedia e medicina esportiva** | Dúvidas gerais com proximidade e ressalvas |
| **Cirurgia vascular** | Dupla de entrevistador e especialista com objetos do cotidiano |
| **Medicina da dor** | Série temática com conversa e bibliografia |
| **Fisioterapia** | Pergunta real anonimizada, resposta concisa com limites |
| **Fisioterapia ortopédica** | Raciocínio clínico mostrado com modelo, sem prescrição universal |

PROMPT PRONTO

**Roteiro de Reel ético**

Atue como roteirista de Reels para [PROFISSÃO] no Brasil, seguindo as normas de publicidade do [CONSELHO]. Crie 3 roteiros de 30 a 60 segundos sobre a dúvida [DÚVIDA DO PACIENTE], no tema [TEMA], momento da jornada [MOMENTO]. O meu diferencial é [SUA PROPOSTA DE VALOR]; use-o para escolher o exemplo e a forma de explicar, sem transformá-lo em propaganda.

Para cada um: pergunta de abertura com texto na tela, resposta curta, demonstração segura (profissional, modelo ou ilustração), limite da orientação, CTA único, final que retoma a abertura, legenda com a palavra-chave [PALAVRA-CHAVE], a cidade [CIDADE] e a identificação profissional, e uma lista de pendências (fontes clínicas, autorizações, norma aplicável). Diga também, em uma linha, o que neste roteiro um colega da mesma especialidade não poderia publicar igual.

Proibido: promessa de resultado, superlativos, medo, autodiagnóstico, preço como chamariz. Marque afirmações clínicas sem fonte como [PENDENTE DE VALIDAÇÃO].

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

**O QUE FOI COLOCADO**

Dúvida: "Preciso tomar gel durante uma corrida de 10 km?" Tema: energia em provas curtas. Momento: pesquisa. Palavra-chave: nutrição para corrida de rua. Cidade: São Paulo.

**O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)**

ROTEIRO 1 (45 s)
Abertura, texto na tela: "Gel numa corrida de 10 km: precisa mesmo?"
Resposta curta (fala): "Para a maioria das pessoas que corre 10 km em menos de uma hora, a refeição de antes e a hidratação costumam bastar. Depende do seu ritmo, do jejum e de como você se sente."
Demonstração: mostrar um café da manhã de 2 a 3 horas antes da prova, em prato real, sem marcas.
Limite da orientação: "Isso é informação geral. Se você tem uma condição de saúde ou usa medicamento, combine o plano com seu nutricionista."
CTA único: "Quer montar a sua estratégia de prova? Chame no WhatsApp pelo link da bio."
Final que retoma a abertura: "Então, gel em 10 km? Depende, e dá para decidir com tranquilidade."
Legenda: "Gel em corrida de 10 km: quando faz sentido. Nutrição para corrida de rua em São Paulo. Bia Nunes, nutricionista, CRN-3 00000."

ROTEIROS 2 E 3 (títulos): "Café da manhã antes de correr: o que muda com a distância"; "Cãibra na corrida: o que é mito e o que vale conversar com o profissional".

PENDÊNCIAS: [PENDENTE DE VALIDAÇÃO] "menos de uma hora" e "2 a 3 horas antes" precisam de fonte (posicionamento de sociedade de medicina esportiva ou de nutrição); autorização para qualquer pessoa que apareça no vídeo; sem marca de produto no prato.

**ANTES DE USAR**

- Valide cada afirmação clínica com uma fonte antes de gravar.
- Não use preço, promoção nem "antes e depois".

## Checklist antes de publicar

- Gancho claro em 3 segundos

- Promessa entregue
- Legenda na tela
- Palavra-chave na legenda
- CTA único com destino confirmado
- Fonte para cada afirmação clínica
- Imagem autorizada e permitida para aquela profissão e tipo de conta
- Identificação profissional correta
- Ressalvas preservadas na versão curta
- Revisão clínica feita
- Teste da diferença: algo nesta peça é só seu

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** posts de data comemorativa sem conteúdo, frases motivacionais e textos que qualquer IA escreveria igual.
- **Reduzir:** a busca por viralizar e o volume de posts que você não consegue revisar.
- **Elevar:** as dúvidas reais do consultório e o seu raciocínio clínico, explicados com a sua voz.
- **Criar:** um quadro recorrente que nasce do seu diferencial e que o paciente associa a você.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Liste as dez perguntas que você mais ouve no consultório. Escolha uma, encaixe no tema que nasce do seu diferencial e grave hoje um Reel de 30 segundos com o roteiro em seis tempos, usando um exemplo do seu atendimento.

NO CLINILOOP

**Pautas e roteiros de conteúdo.**
Transforma dúvidas reais em pautas por tema e gera roteiros de Reels, carrosséis e vídeos com a palavra-chave da sua cidade e o diferencial que você definiu na Estratégia Oceano Azul.

---

**Próxima passagem.** *A prova do conteúdo assusta menos quando você descobre que já carrega um tesouro: as aulas, palestras e entrevistas que já deu.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · As provas: o tesouro esquecido*

05

# Reaproveitamento: uma aula, quatro entregas

*As aulas, palestras, podcasts e entrevistas que você já deu são a fonte mais rica da sua diferença. Ali está o seu raciocínio clínico, com a sua voz, sem roteiro de agência. O trabalho é fazer esse material chegar ao paciente.*

NESTA PARTE · PARTE 05

Por que reaproveitar diferencia · Fontes boas e fontes proibidas · Do episódio ao conjunto de peças · As quatro entregas · Comentário que leva ao guia · Bastidores · A página da bio

Muitos heróis descobrem, no meio do caminho, que já carregavam o que procuravam. Aqui, o tesouro esquecido são as aulas, palestras, podcasts e entrevistas que você já deu.

Antes de criar conteúdo novo, procure o que já existe. O gargalo de quem já fala bem sobre saúde quase nunca é falta de ideia. É transformar o que já foi dito em peças que o paciente encontra. A IA entra entre a experiência humana e a distribuição; o profissional continua sendo a fonte, o revisor e quem grava.

## Por que reaproveitar diferencia

Quando você dá uma aula ou responde a uma entrevista, faz exatamente o que a Parte 4 pede: explica com exemplos do seu consultório, mostra como pensa e diz o que depende de cada caso. Esse material carrega naturalmente as três origens do conteúdo que só você poderia publicar.

Um post escrito do zero, com pressa, tende ao genérico. Um trecho da sua aula, recortado com cuidado, tende ao contrário: tem a sua voz, o seu ritmo e o seu jeito de responder. Por isso o reaproveitamento é, ao mesmo tempo, o atalho de produção e o atalho de diferenciação.

Há uma ressalva. O método desta parte nasceu da observação de um vídeo que prometia multiplicar a produção no Instagram com IA, sem trazer medição. Trate o ganho de tempo como hipótese e meça o seu próprio tempo por conjunto de peças.

## Fontes boas e fontes proibidas

| Use | Não use sem autorização formal e anonimização |
|---|---|
| **Aulas, palestras e participação em congressos** | Gravações ou transcrições de consultas e atendimentos |
| **Podcasts e entrevistas em que você participou** | Lives em que pacientes contaram casos pessoais |

| Use | Não use sem autorização formal e anonimização |
|---|---|
| Respostas a perguntas gerais, agregadas | Conversas privadas de Direct ou WhatsApp |
| Bastidores da rotina sem pacientes identificáveis | Telas, prontuários ou exames de terceiros |

Afirmação clínica dita na fonte continua pendente de validação até ter referência, e as ressalvas dela devem sobreviver ao corte curto.

## Do episódio ao conjunto de peças

1. **Diagnostique antes de gerar.** Público, objetivo, voz (como você fala, o que evita), restrição principal (tempo, gravação, edição) e destino confirmado do CTA.
2. **Leia a fonte inteira** e registre cada ideia aproveitável: nome curto, trecho e tempo, quem disse (você ou o convidado), síntese fiel, exemplo presente na fonte, ressalva a preservar e destino da peça.
3. **Marque o que é só seu.** Entre as ideias, destaque as que mostram o seu diferencial: um exemplo do seu atendimento, uma comparação que você sempre usa, uma posição clínica fundamentada. Elas têm prioridade.
4. **Escolha um tema central por conjunto.** Não junte assuntos desconexos só porque estão no mesmo episódio. Uma fonte pode render mais de um conjunto se os temas forem independentes, mas não force quantidade.
5. **Distribua a profundidade.** O carrossel apresenta parte dos insights, o Reel dá uma mensagem curta com presença humana, o guia desenvolve a aplicação e o episódio completo fica como aprofundamento.
6. **Preserve autoria e voz.** Fala de convidado não vira experiência do apresentador. Nada de “eu testei” ou “meus pacientes conseguiram” sem suporte na fonte. Pergunte sempre: “Isso parece algo que eu realmente diria?”
7. **Revise e só então distribua,** com a revisão editorial e a aprovação clínica separadas (Parte 2).

## As quatro entregas

- **Carrossel:** abertura com uma dúvida ou contradição sustentada na fonte, uma ideia por card, aplicação prática e fechamento com o próximo passo. A legenda complementa os cards, não repete.
- **Guia:** entrega valor sozinho e não repete os cards. Para quem serve, o problema, como aplicar em passos, um exemplo (da fonte ou marcado como proposto), um checklist e o link do episódio completo. Sem link real, o guia não é divulgado.
- **Reel:** 30 a 45 segundos como hipótese inicial para Reel de atração, com gancho nos 3 primeiros segundos. Entregue em duas versões: roteiro falado e tópicos de gravação, mais natural que teleprompter. A duração é estimada lendo em voz alta.
- **Stories:** bastidor de quem atende ou de como a aula foi preparada, sem pacientes.

O guia é a entrega que mais diferencia. Um material útil, com o seu nome, que o paciente guarda e envia para alguém, faz o trabalho da porta da confiança por semanas.

## Comentário que leva ao guia

O fluxo comum é: conteúdo, interesse no guia, comentário com uma palavra-chave, envio automático do guia e do episódio por Direct (ferramentas como o Manychat exigem configuração). Antes de anunciar entrega automática, confirme que a conta e a integração suportam o fluxo e teste o envio.

Na saúde, a palavra-chave e a mensagem automática seguem as regras do conselho: nada de sorteio, promoção ou preço onde for vedado, e nenhuma pergunta sobre histórico de saúde no Direct. Quem recebe o guia ainda não é paciente. Registre o contato com a origem “guia” e trate a conversa com calma, sem abordagem comercial.

## Bastidores como fonte de conteúdo

Documente a rotina que já existe, em vez de criar agenda artificial. Cada registro vira uma pequena história: situação real, observação, aprendizado e utilidade para o público. Os bastidores mais valiosos são os do seu diferencial: como você prepara o plano por

escrito, como organiza o retorno por mensagem, como a sala foi pensada para quem tem medo.

Com apenas uma foto ou nota solta, não invente o contexto. Não presuma autorização para mostrar colegas, pacientes ou telas.

## A página da bio como próximo passo

Primeiro o conteúdo atrai e cria conexão; depois a bio facilita o próximo passo. Uma página de bio pode ter um assistente de orientação rápida que, em uma ou duas perguntas, leva a pessoa ao destino certo: o guia, o episódio, o agendamento. Ele usa apenas a base aprovada de serviços e conteúdos, diz que é um assistente de IA, não inventa preços, resultados nem condições, e nunca faz triagem clínica. Painel de conversas e métricas exigem implementação, hospedagem e proteção de dados.

## Comece com um piloto pequeno

Escolha dois episódios ou aulas de que você gostou e em que participou bem, não necessariamente os mais vistos. Um por vez: gere carrossel, guia e Reel; revise fidelidade, voz e utilidade; publique só com destinos reais. Avalie o tempo por conjunto, o número de correções e a identificação com a sua voz. Depois de publicar, acompanhe salvamentos, envios, acesso ao guia e conversas qualificadas. Um resultado isolado não prova que o método funciona.

PROMPT PRONTO

**Do episódio ao conjunto de peças**

Vou colar a transcrição de [AULA/PODCAST/ENTREVISTA] em que participei como [PAPEL]. Público: [PÚBLICO]. Objetivo: [OBJETIVO]. Profissão e conselho: [PROFISSÃO, CONSELHO]. Meu diferencial: [SUA PROPOSTA DE VALOR].

1. Liste as ideias aproveitáveis com trecho, quem disse, síntese fiel, exemplo da fonte e ressalva a preservar. Marque com [MEU] as que mostram o meu diferencial.
2. Escolha UM tema central, de preferência entre as ideias marcadas, e gere: carrossel (cards e legenda), guia (para quem, problema, passos, exemplo, checklist) e Reel de 30 a 45 s em duas versões (roteiro falado e tópicos de gravação).
3. Liste pendências: afirmações clínicas sem fonte, autoria a confirmar, links que faltam e pontos de compliance.

Não invente experiências, números nem depoimentos. Não use dados de pacientes.

Transcrição: [COLE AQUI]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Transcrição de uma aula de 40 minutos para um clube de corrida (trechos). Papel: palestrante. Público: corredores amadores. Objetivo: levar à primeira conversa.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

1. IDEIAS APROVEITÁVEIS (trecho)
- "Eu vejo gente treinando bem e comendo mal antes da prova longa." Quem disse: a palestrante, minuto 06. Síntese fiel: o preparo alimentar da véspera costuma ser menos planejado que o treino. Exemplo da fonte: o jantar de véspera em um clube. Ressalva: depende do histórico de cada pessoa.
- "O gel não é obrigatório." Minuto 18. Síntese: o uso depende do tempo de prova e do ritmo. Ressalva: não vale para quem tem restrição clínica.

2. TEMA CENTRAL ESCOLHIDO: o que comer na véspera e na manhã da prova.
Carrossel (6 cards): 1 "Véspera de prova: o erro mais comum" | 2 "Por que o jantar importa" | 3 "O que a maioria faz" | 4 "O que costuma ajudar" | 5 "Quando ajustar com o profissional" | 6 "Salve para a véspera". Legenda com identificação profissional.
Guia (resumo): para quem (corredores de 5 a 21 km), problema (ansiedade sobre a véspera), 4 passos, um exemplo da aula, checklist de 6 itens.
Reel 30 a 45 s, duas versões: roteiro falado e tópicos de gravação.

3. PENDÊNCIAS: fonte das orientações sobre a véspera; confirmar autoria das frases; link do guia; conferir norma do CFN sobre imagens de alimentos de marcas.

### ANTES DE USAR

- Confirme que cada citação está fiel ao trecho original.
- Remova telefones e e-mails da transcrição antes de colar (o app já troca por marcadores).

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** conteúdo novo e genérico feito às pressas quando você já tem uma aula sobre o tema.
- **Reduzir:** a dependência de tendências e de roteiros que não nasceram da sua experiência.
- **Elevar:** os trechos em que você explica com exemplos do seu consultório e mostra como pensa.
- **Criar:** um guia útil, com o seu nome, que o paciente guarda e envia, ligado ao episódio completo.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Escolha uma aula, podcast ou entrevista em que você participou bem. Liste as ideias aproveitáveis, com quem disse cada uma, marque as que mostram o seu diferencial e escolha entre elas o tema central do primeiro conjunto.

NO CLINILOOP

**Reaproveitamento de conteúdo.**
Cole a transcrição de uma aula ou podcast e receba o registro de ideias, o carrossel, o guia e o Reel em duas versões, com as pendências de fonte, autoria e compliance.

---

**Próxima passagem.** *O material está escolhido. Falta enfrentar o guardião que barra a passagem de muita gente boa: a câmera.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · As provas: o guardião da câmera*

# 06

# Vídeo: como produzir com o que você tem

*O vídeo é a prova de diferença mais difícil de copiar: mostra como você explica, como trata quem pergunta e se transmite segurança. Um vídeo claro, bem iluminado e com som limpo vale mais que um vídeo caro, e o celular no seu bolso já basta.*

---

NESTA PARTE · PARTE 06

O kit por nível · Celular ou câmera · Luz · Som · Fundo e cenário · Enquadramento e postura · Teleprompter · A sessão de gravação · Medo da câmera

Em quase toda jornada há um guardião na porta, alguém que testa se o herói está pronto para seguir. Para muitos profissionais de saúde, esse guardião é a câmera do celular. Ele assusta mais do que machuca, e se vence com repetição, não com coragem.

A Parte 4 ensinou o que dizer. Esta parte ensina como gravar: equipamento, luz, som, fundo, a sua posição diante da câmera e os aplicativos que ajudam a falar o texto sem decorar. A edição vem na Parte 7. O passo a passo detalhado dos aplicativos está no **Anexo A**.

## Por que vídeo

O Reel é o principal meio de ser descoberto por quem ainda não segue você, e o YouTube é o lugar onde o paciente pesquisa dúvidas e encontra respostas por anos. Em vídeo, a pessoa avalia algo que nenhum texto mostra: como você explica, como trata quem pergunta e se transmite segurança. É a decisão da confiança (Parte 1) acontecendo antes da primeira consulta.

É também onde a diferença entre os dois jogos fica mais visível. O vídeo genérico de banco de imagens, com locução e música, pode até chamar atenção, mas não mostra ninguém. O seu vídeo, gravado no seu consultório, com a sua voz explicando uma dúvida real, mostra exatamente o que o paciente vai encontrar. Nenhuma agência consegue produzi-lo sem você.

Isso não exige estúdio. A plataforma premia retenção, e retenção vem de uma pergunta clara, uma resposta útil e um som que se entende, não de câmera cara. Um vídeo simples e verdadeiro diferencia mais que um vídeo sofisticado e impessoal.

## O kit por nível

Comece pelo nível 1 e só suba quando a rotina estiver estável. Equipamento novo não resolve roteiro fraco.

| Nível | Imagem | Luz | Som | Apoio |
|---|---|---|---|---|
| **1. Comece hoje** | Câmera traseira do celular | Janela de frente ou de lado | Fone com microfone ou o próprio celular perto da boca, em sala silenciosa | Livros ou uma prateleira na altura dos olhos |
| **2. Rotina semanal** | Celular, com a câmera traseira | Ring light ou painel de LED com regulagem de intensidade e de cor | Microfone de lapela sem fio, com receptor que encaixa no celular | Tripé com suporte de celular e controle remoto por Bluetooth |
| **3. Produção frequente** | Celular topo de linha ou câmera mirrorless | Dois painéis de LED com difusor (softbox) | Microfone direcional (shotgun) ou lapela de duas transmissoras, para entrevistas | Teleprompter físico de vidro, fundo fixo e cenário montado |

A IDEIA CENTRAL

**A ordem de investimento:**
primeiro som, depois luz, por último câmera. O espectador perdoa uma imagem simples, mas abandona o vídeo quando não entende o que você fala.

## Celular ou câmera

O celular é suficiente para Reels, Shorts, TikTok e até para o YouTube. A câmera só compensa quando você grava aulas longas, entrevistas com dois ângulos ou já tem uma rotina semanal estável.

**Para gravar bem com o celular:**

1. **Use a câmera traseira.** Ela tem qualidade bem superior à frontal. Para se ver enquanto grava, use um monitor de retorno, o espelhamento do celular ou o teleprompter do próprio aplicativo de gravação.
2. **Limpe a lente** com um pano macio antes de cada sessão. Lente engordurada é a causa mais comum de imagem "leitosa".
3. **Grave na vertical (9:16)** para Reels, Shorts, TikTok e Stories, e na horizontal (16:9) para o YouTube. Se precisar das duas, grave na horizontal com você no centro e espaço dos lados.
4. **Resolução:** 1080p ou 4K, a 30 quadros por segundo. 4K ocupa mais memória; use se tiver espaço e quiser recortar depois.
5. **Trave foco e exposição.** Toque e segure no seu rosto na tela até aparecer o aviso de bloqueio. Assim a imagem não "pisca" quando você gesticula.
6. **Desligue filtros e o modo beleza.** Na saúde, filtro que altera pele, dentes ou contorno do corpo pode ser lido como alteração de resultado e é vedado em várias profissões.
7. **Ative o modo avião ou o "não perturbe".** Uma notificação no meio da fala perde a melhor tomada.
8. **Confira o espaço livre** antes de começar: dez minutos de vídeo em 4K ocupam alguns gigabytes.

## Luz

A luz faz mais pela imagem do que a câmera.

- **Luz natural:** fique de frente para a janela ou com ela a 45 graus do rosto. Nunca grave de costas para a janela: o rosto fica escuro e o fundo, estourado. Prefira horários de luz estável e evite o sol direto.
- **Ring light:** posicione-a atrás do celular, na altura dos olhos ou um pouco acima. Se você usa óculos, suba e incline a luz levemente, ou afaste-a, até o reflexo sair da lente. Use intensidade média: luz forte demais achata o rosto.
- **Painel de LED:** a 45 graus do rosto, com difusor. Um segundo painel, mais fraco, do outro lado, suaviza as sombras.
- **Temperatura de cor:** não misture luz amarela da sala com luz branca do painel. Apague as luzes do teto quando elas deixarem sombras duras nos olhos.

- **Teste em dez segundos:** grave, assista no celular e confira se os olhos aparecem bem, sem sombra embaixo e sem brilho excessivo na testa.

## Som

Som ruim derruba a retenção mais rápido que imagem ruim.

- **Microfone de lapela** é o melhor custo-benefício. Prenda-o no peito, a um palmo da boca, longe de colar, crachá ou jaleco que roce nele.
- **Sala com tecidos** (cortinas, tapete, estofados) reduz o eco. Paredes nuas e piso frio fazem a voz soar distante.
- **Desligue** ar-condicionado barulhento, ventilador e equipamentos com ruído contínuo. Avise a equipe e feche portas.
- **Teste antes:** grave dez segundos, ouça com fone e confira se a voz está clara e sem chiado.
- **Redução de ruído** nos editores (Parte 7) ajuda, mas não salva um áudio gravado em sala com eco.

## Fundo e cenário

O fundo comunica tanto quanto você.

- **Consultório organizado,** com profundidade: afaste-se cerca de um metro da parede para o fundo não "colar" em você.
- **Nada de dados de pacientes:** prontuários, telas de computador, agendas, exames e pessoas identificáveis ficam fora do quadro. Confira o reflexo em vidros e espelhos.
- **Identidade:** uma cor da sua marca, um objeto que remete à sua área (modelo anatômico, livro, planta) e iluminação limpa. Evite excesso de elementos.
- **O cenário do seu diferencial:** se o que você elevou ou criou tem um lugar, grave ali. A mesa onde você entrega o plano por escrito, a sala pensada para quem tem medo, o espaço onde a avaliação acontece. O paciente reconhece o lugar quando chega.

- **Marcas comerciais:** evite produtos e logotipos de fabricantes em destaque. Para nutricionistas, associar a própria imagem a marcas de alimentos é vedado.
- **Equipe e terceiros:** quem aparecer precisa autorizar o uso da imagem, por escrito.
- **Fundo neutro ou tela verde** servem para formatos de explicação com ilustração atrás de você. A tela verde exige luz uniforme no fundo para o recorte funcionar.

## Enquadramento e postura: como se posicionar diante da câmera

- **Lente na altura dos olhos.** Câmera de baixo para cima distorce o rosto e passa distância; de cima para baixo diminui a sua presença.
- **Olhos no terço superior** da tela e espaço pequeno acima da cabeça.
- **Plano médio** (do peito para cima) para falar com o paciente; plano mais aberto quando for demonstrar algo com as mãos ou com um modelo.
- **Zona segura:** no Reels e no TikTok, a parte de baixo e a lateral direita da tela ficam cobertas por botões e legenda. Mantenha rosto, objetos e textos importantes no centro.
- **Olhe para a lente, não para a tela.** É assim que o paciente sente que você fala com ele.
- **Postura:** ombros relaxados, coluna ereta, um leve sorriso no início. Gestos na altura do peito, dentro do quadro.
- **Roupa:** cores lisas, sem listras finas nem estampas miúdas, que "tremem" no vídeo. Jaleco quando fizer sentido para o tema; roupa de trabalho limpa sempre.
- **Voz:** fale um pouco mais devagar do que numa conversa e faça pausas entre as ideias. As pausas serão cortadas na edição.

## Teleprompter: falar o texto sem decorar

O teleprompter faz o texto rolar na tela enquanto você grava, perto da lente, para que você leia sem desviar o olhar. Ele é útil para quem tem pouco tempo, roteiro técnico ou medo de esquecer o que vai dizer.

**Aplicativos para celular (confira versões e preços na loja do seu aparelho):**

| Aplicativo | Onde funciona | Destaque |
|---|---|---|
| BIGVU | iPhone, Android, computador | Plano gratuito com teleprompter e gravação básica |
| PromptSmart | iPhone, Android, computador | O texto acompanha a sua voz e para quando você para |
| Teleprompter.com | iPhone e iPad | Rolagem pela voz e gravação em alta resolução |
| Teleprompter for Video e similares | iPhone e Android | Opções simples e gratuitas para começar |
| Recursos de teleprompter em editores | Varia por aplicativo e versão | Alguns editores de vídeo, como o CapCut, também oferecem teleprompter na câmera |

**Como usar bem:**

1. **Escreva para falar,** não para ler: frases curtas, uma ideia por frase, palavras que você usaria no consultório.
2. **Divida em blocos** de 10 a 20 segundos. Grave um bloco por vez; a edição junta tudo.
3. **Letra grande e janela estreita,** posicionada logo abaixo da lente. Quanto mais perto da lente, menos o olhar "corre" pela tela.
4. **Velocidade lenta.** Prefira a rolagem pela voz, quando o aplicativo oferecer.
5. **Ensaie uma vez em voz alta** antes de gravar. Troque o que soar artificial.
6. **Ou abandone o texto corrido:** muitos profissionais falam melhor a partir de três ou quatro tópicos na tela.

O roteiro em blocos para o teleprompter sai pronto na ferramenta **Roteiros e copy** do app.

## A sessão de gravação

Gravar em lote poupa tempo e cria constância. Reserve uma hora a cada uma ou duas semanas e grave de quatro a seis vídeos.

1. **Antes:** roteiros revisados (revisão editorial e revisão clínica e ética, Parte 2), bateria carregada, espaço livre, lente limpa, sala silenciosa, roupa escolhida.
2. **Montagem:** tripé, luz, microfone e teste de dez segundos de imagem e som.
3. **Para cada vídeo:**
   - três versões do gancho, com aberturas diferentes, para escolher na edição ou testar com Trial Reels;
   - o corpo do roteiro, em blocos;
   - o fechamento que retoma a abertura (Parte 4);
   - de três a cinco imagens de apoio, sem pacientes: suas mãos explicando um modelo, o ambiente, a fachada, a sala de espera vazia.
4. **Variação:** troque de camisa ou de ângulo entre um vídeo e outro, para que a série não pareça gravada no mesmo minuto.
5. **Depois:** copie os arquivos para o computador ou para a nuvem, nomeie por tema e data e registre o conteúdo no CRM (Parte 13).

## Perder o medo da câmera

O desconforto diante da câmera é comum e diminui com repetição, não com coragem.

- **Cinco minutos por dia, sem publicar.** Durante duas semanas, grave cinco minutos respondendo a uma pergunta de consultório. Assista e anote um único ajuste para o dia seguinte: clareza, velocidade, olhar ou apoio visual.
- **Comece com o que você domina:** a pergunta que você responde dez vezes por semana.
- **Fale com uma pessoa,** não com "o público". Imagine o paciente que fez aquela pergunta.
- **Peça um retorno respeitoso** a alguém de confiança e revise um aspecto por vez.

- **Formatos sem rosto** também valem no começo: mãos explicando um modelo, tela com ilustração, narração sobre imagens do ambiente.

Esse exercício é um treino de comunicação, não tratamento para ansiedade. Se o medo atrapalhar sua rotina, procure ajuda profissional.

## Checklist antes de apertar o botão de gravar

- Roteiro revisado e aprovado
- Lente limpa, modo avião ativado
- Luz de frente ou a 45 graus, sem janela atrás
- Microfone testado, sala silenciosa
- Fundo sem dados de pacientes e sem marcas em destaque
- Lente na altura dos olhos, rosto na zona segura
- Filtros e modo beleza desligados
- Autorização de imagem de quem aparecer

PROMPT PRONTO

**Roteiro para teleprompter e plano de gravação**

Atue como diretor(a) de vídeo para [PROFISSÃO] no Brasil, seguindo as normas de publicidade do [CONSELHO]. Transforme o roteiro abaixo em um texto para teleprompter e em um plano de gravação.

Entregue: (1) o texto em blocos de até 20 segundos, com frases curtas e palavras que eu usaria no consultório; (2) três versões do gancho, com aberturas diferentes; (3) o fechamento que retoma a abertura; (4) de três a cinco imagens de apoio que eu possa gravar sem pacientes nem dados identificáveis; (5) o texto na tela de cada bloco, com no máximo seis palavras; (6) a lista de pendências de fonte e de autorização.

Não acrescente promessas de resultado, superlativos nem afirmações clínicas que não estejam no roteiro original. Preserve o meu jeito de falar e os exemplos do meu consultório; eles são o que diferencia o vídeo.

Roteiro: [COLE AQUI O ROTEIRO]

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** vídeos de banco de imagens com locução genérica e filtros que mudam a sua aparência.
- **Reduzir:** a preocupação com equipamento caro antes de ter rotina.
- **Elevar:** o som, a clareza da explicação e o olhar para a lente, que fazem o paciente sentir que você fala com ele.
- **Criar:** um cenário que mostra o seu diferencial e que o paciente reconhece quando chega ao consultório.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Grave hoje um teste de 30 segundos com a câmera traseira do celular, apoiado na altura dos olhos, de frente para a janela, explicando uma dúvida com um exemplo do seu atendimento. Assista com fone e anote um único ajuste para o próximo.

NO CLINILOOP

**Roteiros e copy.**
Gera o roteiro em blocos curtos, pronto para o teleprompter, com três versões do gancho. Em **Ferramentas recomendadas**, monte o kit de gravação que cabe no seu orçamento.

---

**Próxima passagem.** *O vídeo está gravado. Antes de mostrá-lo ao mundo, ele passa pela forja da edição, onde se corta o que sobra sem apagar quem você é.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · As provas: a forja*

07

# Edição de vídeo: das ferramentas nativas às externas

*Editar não é enfeitar. É cortar o que sobra, deixar o gancho legível nos primeiros segundos, garantir que se entenda cada palavra e entregar o vídeo no formato certo para cada rede.*

NESTA PARTE · PARTE 07

O que a edição resolve · Três níveis de ferramenta · Comparativo · Como escolher · Legendas · Avatares e voz por IA · Imagens com IA · Exportar sem perder qualidade

Na forja, o metal bruto vira ferramenta. Na edição, a gravação vira vídeo. A regra é a mesma nos dois casos: tirar o excesso sem perder o que dá força à peça.

Comece pelo editor que já existe dentro da rede onde você vai publicar. Só passe para um aplicativo externo quando sentir falta de algum recurso. Esta parte apresenta as opções e ajuda a escolher; os passos de cada uma, toque por toque, estão no **Anexo A**.

Uma regra atravessa todas as ferramentas: a edição serve à clareza, não à padronização. Modelos prontos, trilhas da moda e efeitos que todos usam deixam o vídeo com cara de qualquer perfil. Corte o que sobra, mas preserve o seu jeito de explicar, os exemplos do seu consultório e as pausas que fazem parte da sua fala. É isso que o paciente vai reconhecer.

## O que a edição precisa resolver

1. **Cortar pausas, repetições e tomadas erradas.** O ritmo do vídeo curto é de uma ideia por vez, sem silêncio longo.
2. **Gancho legível em três segundos:** a pergunta da abertura escrita na tela, em letra grande e alto contraste.
3. **Legenda em todo o vídeo.** Muita gente assiste sem som, e a legenda também é acessibilidade.
4. **Som limpo:** volume da voz uniforme, ruído reduzido e música, quando houver, bem abaixo da fala.
5. **Imagens de apoio** que mostram o que a fala explica: modelo anatômico, ilustração, ambiente.
6. **Capa** com a pergunta do vídeo, legível no perfil.
7. **Formato e exportação certos** para cada rede, sem marca d'água de outra plataforma.

## Três níveis de ferramenta

**Nível 1: o editor da própria rede.** O Instagram, o TikTok, o YouTube e o LinkedIn têm editores embutidos. Eles cortam, juntam trechos, geram legenda automática, colocam texto, música e figurinhas, e publicam na hora. É o melhor ponto de partida: nada a instalar, nada a exportar.

**Nível 2: editores de celular e de computador.** Aplicativos como o **Edits** (da própria Meta), o **CapCut**, o **InShot**, o **VN** e o editor de vídeo do **Canva** oferecem linha do tempo com várias camadas, legendas estilizadas, recorte de fundo, redução de ruído, modelos e exportação em alta qualidade. Para aulas e vídeos longos no computador, o **CapCut para desktop**, o **Descript** (que edita o vídeo editando o texto da transcrição) e o **DaVinci Resolve** (gratuito e profissional, com curva de aprendizado maior) são as opções mais usadas.

**Nível 3: criação com inteligência artificial.** Ferramentas como o **HeyGen** e o **Synthesia** criam vídeos com avatares digitais e vozes sintéticas, e traduzem vídeos para outros idiomas com a sua própria voz. Os editores do nível 2 também ganharam recursos de IA: roteiro para vídeo, legendas automáticas, recorte de fundo e geração de imagens. Na saúde, esses recursos pedem cuidados próprios, descritos adiante.

## Comparativo

Ferramentas listadas, não avaliadas. Recursos, planos e preços mudam com frequência: confira antes de assinar.

| Ferramenta | Onde | Bom para | Custo | Atenção |
|---|---|---|---|---|
| **Editor do Instagram** | Celular | Reels e Stories rápidos, legendas automáticas, publicação direta | Gratuito | Recursos variam por conta e país |

| Ferramenta | Onde | Bom para | Custo | Atenção |
|---|---|---|---|---|
| **Edits (Meta)** | Celular | Reels com linha do tempo, legendas, tela verde, recorte de pessoa, estatísticas | Gratuito | Pensado para o Instagram; exporta sem marca d'água |
| **Editor do TikTok e TikTok Studio** | Celular e computador | Vídeos curtos, legendas, efeitos, publicação e análise | Gratuito | Marque o conteúdo gerado por IA quando for o caso |
| **YouTube (app e YouTube Studio)** | Celular e computador | Shorts com cortes e textos; vídeos longos com legendas e capítulos | Gratuito | Edição de vídeo longo é limitada no Studio |
| **LinkedIn** | Celular e computador | Cortes simples, legenda e capa de vídeo | Gratuito | Edite antes, em outro aplicativo, se precisar de mais |
| **CapCut** | Celular, computador e navegador | Legendas estilizadas, cortes rápidos, modelos, redução de ruído | Gratuito com limites; plano Pro | Confira se o vídeo saiu sem marca d'água ou vinheta final |
| **Canva** | Celular, computador e navegador | Vídeos com a identidade visual da clínica, carrosséis, capas | Gratuito com limites; plano Pro | Recursos de IA têm cota mensal |

| Ferramenta | Onde | Bom para | Custo | Atenção |
|---|---|---|---|---|
| InShot e VN | Celular | Edição simples e rápida no celular | Gratuito com limites | Versão gratuita do InShot pode inserir marca d'água |
| Descript | Computador | Aulas, podcasts e entrevistas: corta o vídeo cortando o texto | Gratuito com limites; planos pagos | Nunca use com gravação de consulta |
| DaVinci Resolve | Computador | Edição profissional, correção de cor e áudio | Gratuito; versão paga | Exige computador potente e aprendizado |
| HeyGen | Navegador | Avatar digital, tradução com a sua voz, vídeos a partir de texto | Plano gratuito com marca d'água; planos pagos | Leia os cuidados com avatar e voz abaixo |

## Como escolher

- **Está começando e publica no Instagram:** editor do Instagram ou Edits.
- **Quer legendas com estilo, cortes rápidos e modelos:** CapCut ou Edits.
- **Já usa o Canva para posts e carrosséis:** o editor de vídeo do Canva mantém a identidade visual num lugar só.
- **Grava aulas, lives ou entrevistas longas:** Descript ou CapCut para desktop, e depois corte trechos para Reels (Parte 5).
- **Vai delegar a edição:** mande o briefing para o editor (ferramenta Briefing para terceiros) com roteiro, identidade visual e as regras do seu conselho.

Uma ferramenta por necessidade é o bastante. Trocar de editor a cada mês custa mais tempo do que qualquer recurso economiza.

## Legendas automáticas: revise sempre

Todos os editores geram legenda automática, e todos erram termos técnicos, nomes de medicamentos, siglas e números. Revise palavra por palavra antes de publicar. Um erro na legenda de um vídeo de saúde pode mudar o sentido de uma orientação.

- Mantenha a legenda fora da zona coberta pelos botões da rede (parte de baixo e lateral direita).
- Duas linhas, no máximo, por vez. Fonte legível e contraste alto.
- Destaque, com cor, só a palavra mais importante da frase.

## Avatares e voz por IA: o que pode e o que não pode

Ferramentas como o HeyGen criam um "gêmeo digital" a partir de alguns minutos de vídeo seu, ou usam avatares prontos, e fazem esse avatar falar qualquer texto. Também clonam a voz e traduzem vídeos para outros idiomas. Na saúde, isso pede cautela redobrada.

- **Só a sua imagem e a sua voz.** Nunca crie avatar de colega, de paciente ou de pessoa conhecida. Para a equipe, só com autorização por escrito e para uma finalidade definida.
- **Rosto e voz são dados biométricos,** que a LGPD trata como dados sensíveis. Antes de enviar seu vídeo para treinar um avatar, leia os termos: onde ficam os dados, por quanto tempo e se podem ser usados para treinar outros modelos.
- **Avise que é IA.** Instagram, Facebook e TikTok pedem que conteúdo realista gerado ou alterado por IA seja identificado, e oferecem o rótulo na hora de publicar. Coloque também na legenda: "vídeo produzido com avatar digital".
- **Nunca simule paciente nem depoimento.** Avatar de "paciente satisfeito" é depoimento inventado e fere as regras de todos os conselhos.

- **O avatar não substitui você nos vídeos de confiança.** Use-o para conteúdos informativos de apoio (como funciona a primeira consulta, orientações gerais, versões em outro idioma), não para o vídeo de apresentação.
- **O avatar apaga parte da diferença.** O que distingue o seu vídeo é a sua presença: o olhar, o tom, a forma de reagir a uma dúvida. Um avatar reproduz o rosto, mas não o raciocínio ao vivo. Quanto mais o perfil depender dele, mais parecido fica com o de qualquer outro profissional que use a mesma ferramenta.
- **Confira o seu conselho.** As normas sobre publicidade e inteligência artificial evoluem; em caso de dúvida, consulte o conselho regional antes de publicar.

## Imagens com IA para capas, carrosséis e apoio

Os assistentes de IA também geram imagens: ilustrações, ícones, cenários e capas. O ChatGPT, o Gemini, o Meta AI, o Copilot, o Canva, o Adobe Firefly e outros têm geradores próprios. O Anexo A traz a lista por ferramenta, como escrever o pedido e um exemplo pronto.

Três regras valem para todos:

1. **Imagem gerada nunca aparece como paciente real, resultado clínico ou "antes e depois".**
2. **Revise a anatomia.** Geradores de imagem erram dentes, mãos, articulações e órgãos com frequência. Uma ilustração anatomicamente errada desinforma.
3. **Prefira ilustração a foto realista** em temas clínicos, e identifique como "imagem ilustrativa" quando houver risco de confusão.

## Exportar sem perder qualidade

- **Vertical:** 1080 × 1920 pixels, 30 quadros por segundo. **Horizontal (YouTube):** 1920 × 1080 ou 4K.

- **Sem marca d'água de outra rede.** O Instagram e o TikTok reduzem o alcance de vídeos com marca de outra plataforma. Exporte o arquivo limpo do editor, não baixe o vídeo publicado em outra rede.
- **Música:** em anúncios e impulsionamentos, use só a biblioteca de áudio comercial da plataforma ou trilhas com licença. Música do catálogo comum pode impedir o impulsionamento (Parte 9).
- **Guarde o projeto e o arquivo final** em uma pasta por mês, com o nome do tema. O melhor vídeo de hoje pode virar anúncio ou ser reaproveitado amanhã.

PROMPT PRONTO

**Plano de edição a partir da transcrição**

Atue como editor(a) de vídeos curtos para profissionais de saúde, seguindo as normas de publicidade do [CONSELHO]. Vou colar a transcrição de um vídeo de [DURAÇÃO] sobre [TEMA].

Entregue: (1) os trechos a cortar (pausas, repetições, frases que dependem de contexto); (2) o texto na tela do gancho, em até seis palavras; (3) as palavras da legenda que merecem destaque; (4) onde entram imagens de apoio e quais, sem pacientes; (5) três opções de texto para a capa; (6) a legenda do post com a palavra-chave [PALAVRA-CHAVE] e a identificação profissional; (7) os termos técnicos que preciso conferir na legenda automática.

Não acrescente promessas de resultado nem informações que não estejam na transcrição. Não corte os trechos em que eu dou exemplos do meu atendimento, a não ser que estejam repetidos.

Transcrição: [COLE AQUI]

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** efeitos, trilhas e transições da moda que fazem o vídeo parecer com o de todo mundo.
- **Reduzir:** o uso de avatar e de voz sintética nos vídeos em que o paciente quer conhecer você.
- **Elevar:** a legibilidade do gancho, a legenda revisada e o som limpo.
- **Criar:** uma identidade visual simples e sempre igual, de capa e de texto na tela, que o seguidor reconhece antes de ler o seu nome.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Edite o teste da Parte 6 no editor do próprio Instagram ou no Edits: corte as pausas, gere a legenda automática, revise os termos técnicos, escreva o gancho na tela e salve como rascunho.

NO CLINILOOP

**Ferramentas recomendadas.**
Indica o editor, o kit de gravação e o gerador de imagem que cabem no seu orçamento, e monta o prompt de imagem com as regras do seu conselho. Para delegar, use o **Briefing para terceiros**.

---

**Próxima passagem.** *Até aqui você caminhou sozinho, e nenhum herói chega ao fim assim. É hora de encontrar os aliados: os colegas que atendem o mesmo paciente antes ou depois de você.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · Os aliados*

# 08

# A decisão dos colegas: a rede de indicação

*Na fábrica de leads, os colegas quase não aparecem. Neste guia, eles são um canal. O paciente indicado por quem ele já confia chega pela porta da confiança, com boa parte das dúvidas resolvidas antes do primeiro contato.*

---

NESTA PARTE · PARTE 08

Por que o colega indica você · Quem indica quem · Os cinco movimentos da indicação · Limites éticos · Collabs entre colegas

Nenhum herói chega ao fim sozinho. Os aliados aparecem no caminho, e na saúde eles têm nome, especialidade e consultório: são os colegas que atendem o seu paciente antes ou depois de você.

A indicação não se compra; se conquista com quatro coisas: um foco claro, competência visível, comunicação de retorno e facilidade de encaminhar.

## Por que o colega indica você

Um colega encaminha um paciente quando, diante de um caso, lembra de um nome. Ninguém lembra de "um bom fisioterapeuta". Lembra de "a fisioterapeuta que pega corredor com dor no joelho e manda relatório depois". O foco é o que transforma competência em lembrança.

É por isso que a diferenciação da Parte 3 vale para os colegas tanto quanto para os pacientes. Para o paciente, ela responde "por que você?". Para o colega, responde "em que caso eu mando para você?". Quanto mais clara a resposta, mais fácil indicar.

Há também uma razão de qualidade. O paciente indicado chega com a confiança emprestada de quem indicou. A hipótese deste guia é que ele agenda, comparece e adere mais do que o paciente que chegou comparando preço. Registre a origem de cada indicação no CRM e confira, com os seus números, se isso se confirma no seu consultório (Parte 13).

## Quem indica quem

| Você é | Quem pode indicar você | Para quem você pode indicar |
|---|---|---|
| **Fisioterapeuta** | Ortopedistas, reumatologistas, neurologistas, cirurgiões, geriatras, educadores físicos, dentistas (DTM) | Médicos especialistas, nutricionistas, psicólogos |

| Você é | Quem pode indicar você | Para quem você pode indicar |
|---|---|---|
| Dentista | Clínicos gerais, pediatras, otorrinos, fonoaudiólogos, outros dentistas especialistas | Médicos, fisioterapeutas (DTM, postura), nutricionistas |
| Médico especialista | Clínicos, médicos de família, outros especialistas, dentistas, fisioterapeutas | Fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, outros especialistas |
| Psicólogo | Psiquiatras, clínicos, pediatras, ginecologistas, escolas, RH de empresas | Psiquiatras, médicos, nutricionistas |
| Nutricionista | Endocrinologistas, cardiologistas, gastroenterologistas, pediatras, ginecologistas, educadores físicos, psicólogos | Médicos, psicólogos, fisioterapeutas |

## Os cinco movimentos da indicação

1. **Mapear.** Liste no CRM de 20 a 50 profissionais da sua região que atendem o mesmo paciente antes ou depois de você. Registre especialidade, endereço, canal preferido e quem já indicou.
2. **Apresentar-se com foco.** Uma mensagem curta ou visita com um material técnico de uma página: o que você trata com mais frequência, em quais casos encaminhar, como encaminhar e o que o colega recebe de volta. O foco vem antes da lista de serviços.
3. **Facilitar o encaminhamento.** Um link ou número de WhatsApp exclusivo para colegas, com prioridade de agenda para pacientes encaminhados e um formulário simples de encaminhamento.
4. **Devolver informação (contrarreferência).** Com autorização do paciente, envie ao colega um relatório breve de avaliação e, depois, de alta. É o gesto que mais gera novas indicações, e um dos diferenciais mais raros: poucos profissionais fazem isso

com regularidade.

5. **Manter o relacionamento.** Agradecimento a cada indicação, convites para aulas e discussões de caso, conteúdo técnico no LinkedIn, collabs no Instagram com temas complementares.

ATENÇÃO

**Limites éticos inegociáveis.**
Não pague, não receba e não prometa vantagem financeira por encaminhamento. Isso é vedado pelos códigos de ética e configura captação indevida. Indicação se retribui com qualidade, retorno técnico e reciprocidade quando faz sentido clínico. O paciente sempre tem liberdade de escolher outro profissional.

## Collabs entre colegas

Um ortopedista e um fisioterapeuta gravam juntos "Quando operar e quando fazer fisioterapia no menisco". Um dentista e um fisioterapeuta, "Dor na mandíbula: o que é DTM". O público de um conhece o outro, a autoridade se soma e cada um sai com o foco mais claro: o paciente vê quem faz o quê.

PROMPT PRONTO

**Carta de apresentação a colegas**

Escreva uma mensagem de até 120 palavras, em tom cordial e técnico, de um(a) [PROFISSÃO] especializado(a) em [ÁREA] para um(a) [ESPECIALIDADE DO COLEGA] da região de [BAIRRO/CIDADE]. Comece pelo meu foco: [SUA PROPOSTA DE VALOR]. Objetivo: explicar em quais casos o encaminhamento ajuda o paciente, como encaminhar ([CANAL]) e que o colega receberá relatório de avaliação e alta com autorização do paciente. Sem bajulação, sem oferta de vantagem, sem superlativos.

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

**O QUE FOI COLOCADO**

Profissão: nutricionista. Área: nutrição esportiva. Colega: ortopedista da região de Pinheiros. Canal: WhatsApp profissional.

**O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)**

> Olá, Dr. Rafael, tudo bem? Sou Bia Nunes, nutricionista esportiva (CRN-3 00000), com consultório em Pinheiros. Atendo corredores amadores e pessoas que voltam a treinar depois de lesão. Escrevo porque, nos casos em que a alimentação interfere na recuperação ou no desempenho, o encaminhamento pode ajudar o seu paciente a seguir o tratamento com mais segurança. Para encaminhar, basta me enviar o nome e o contato do paciente pelo WhatsApp, com autorização dele. Depois da avaliação e da alta, você recebe um relatório com os achados e a conduta. Posso lhe apresentar o consultório num café de 15 minutos? Agradeço a atenção.

**ANTES DE USAR**

- Ajuste ao seu estilo e à sua relação com o colega.
- Nada de vantagem, desconto ou comissão pela indicação.

PROMPT PRONTO

**Relatório de contrarreferência**

Com base nas anotações abaixo, redija um relatório de contrarreferência de até 200 palavras para o(a) Dr(a). [NOME], que encaminhou o paciente.

Estrutura: motivo do encaminhamento, achados da avaliação, conduta proposta, previsão de reavaliação, agradecimento. Linguagem técnica e objetiva. Use apenas iniciais do paciente.

Anotações: [COLE AQUI, SEM DADOS IDENTIFICÁVEIS]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

**O QUE FOI COLOCADO**

Anotações (sem identificação): paciente M.S., 38 anos, encaminhada pelo Dr. Rafael por tendinopatia; avaliação: ingestão proteica abaixo da orientação, jejum prolongado antes dos treinos; conduta: plano alimentar com ajuste de refeições; reavaliação em 6 semanas.

**O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)**

Prezado Dr. Rafael,

Agradeço o encaminhamento da paciente M.S., que atendi em consulta de avaliação.
Motivo do encaminhamento: apoio nutricional durante o tratamento de tendinopatia.
Achados da avaliação: ingestão de proteínas abaixo do que se recomenda para o seu nível de atividade e jejum prolongado antes dos treinos.
Conduta proposta: plano alimentar com redistribuição das refeições ao longo do dia e ajuste do horário da refeição pré-treino, em acordo com as suas orientações de carga.
Reavaliação: em seis semanas. Enviarei novo retorno ao final.

Fico à disposição para discutir o caso.
Atenciosamente,
Bia Nunes, nutricionista, CRN-3 00000

**ANTES DE USAR**

- Use só iniciais e confirme a autorização do paciente.
- Revise os achados: o texto deve refletir o que você realmente avaliou.

**Na clínica com várias especialidades,** o aliado mais próximo está no corredor. O encaminhamento interno segue as mesmas regras: critério clínico, registro da origem como encaminhamento interno e retorno ao colega que encaminhou.

**Métricas no CRM:** colegas ativos (indicaram nos últimos 90 dias), indicações por colega por mês, taxa de agendamento, de comparecimento e de adesão dos pacientes indicados, e relatórios de contrarreferência enviados. Compare as taxas dos indicados com as das outras origens: é um dos testes mais diretos da hipótese deste guia.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** a carta genérica com a lista de todos os serviços que você oferece.
- **Reduzir:** o contato só quando você precisa de pacientes.
- **Elevar:** o retorno ao colega: relatório de avaliação e de alta, com autorização do paciente.
- **Criar:** um canal exclusivo de encaminhamento, com prioridade de agenda, e uma frase de foco que o colega consegue repetir para o paciente.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Cadastre no CRM dez colegas que atendem o mesmo paciente antes ou depois de você. Escreva em uma linha em que caso cada um deveria lembrar de você e envie a carta de apresentação para os três mais próximos.

NO CLINILOOP

**Rede de colegas.**
Funil de colegas, carta de apresentação, relatório de contrarreferência e registro de quem indicou cada paciente.

---

**Próxima passagem.** *Com aliados ao lado, aparece uma arma poderosa e perigosa ao mesmo tempo: o anúncio pago. Nas mãos certas, ele amplifica a sua diferença. Nas erradas, devolve você ao Oceano Vermelho.*

NO ROTEIRO · ETAPA 3 DE 6 · GERE AUTORIDADE E DEMANDA

*Na jornada · A arma de dois gumes*

09

# Anúncios: Meta Ads e Google Ads

*Este guia não é contra anúncio. Anúncio amplifica o que já é seu: leva a sua diferença a mais gente. O que ele não faz é criar essa diferença. A métrica final não é clique nem mensagem: é o custo por paciente que compareceu.*

NESTA PARTE · PARTE 09

Anúncio amplifica o que já é seu · Se você trabalha com agência · Qual plataforma para qual intenção · Meta Ads · Google Ads · Mensagens éticas · Impulsionamento passo a passo

Toda jornada oferece ao herói uma arma de dois gumes. Aqui, ela se chama anúncio. Usada para amplificar o que é seu, leva a sua diferença a quem nunca ouviria falar de você. Usada no lugar da diferença, devolve você à disputa por preço.

Anúncio não conserta perfil fraco nem atendimento lento. Por isso a ordem é: proposta de valor e perfis prontos (Parte 3), conteúdo orgânico testado (Parte 4), atendimento e CRM prontos (Partes 10 a 13), e só então dinheiro em mídia.

## Anúncio amplifica o que já é seu

A diferença entre os dois jogos da Apresentação não está em anunciar ou não. Está no que se anuncia.

| | Anúncio de fábrica de leads | Anúncio que amplifica o que é seu |
|---|---|---|
| **O criativo** | Modelo genérico, foto de banco de imagens, frase que serviria a qualquer colega | O seu Reel que já foi bem no orgânico, com a sua voz e um exemplo do seu atendimento |
| **A promessa** | Benefício vago ou condição comercial | Uma explicação útil e o convite para conhecer como você atende |
| **Quem responde** | Quem procura o mais barato ou o mais perto | Quem se identificou com a forma como você explica |
| **A primeira pergunta no WhatsApp** | "Quanto custa?" | "Vi o seu vídeo sobre..." |
| **O que você mede** | Custo por mensagem | Custo por paciente que compareceu e seguiu o tratamento, por origem |

O segundo tipo de anúncio funciona como atalho para a porta da confiança: a pessoa vê você explicando antes de chamar. Ele pode custar mais por mensagem, porque é menos "chamativo". A hipótese deste guia é que ele compensa nas decisões 5 a 7. Meça no CRM:

compare o custo por paciente que compareceu e o custo por paciente que iniciou tratamento, e não só o custo por conversa.

## Se você trabalha com agência ou gestor de tráfego

Muitos profissionais já pagam uma agência ou um gestor de tráfego. Este guia não pede que você troque. Pede que você entregue a eles o que só você tem e que meça o que importa.

**O que entregar:**

- a proposta de valor e as quatro ações da Parte 3;
- as dúvidas reais do consultório e os temas de conteúdo da Parte 4;
- os seus vídeos e carrosséis com melhor retenção e mais envios, para virar criativo;
- as regras do seu conselho e o resultado do Verificador ético.

**O que pedir:**

- criativos feitos a partir do seu conteúdo, e não de modelos usados para outros clientes;
- origem marcada em cada conversa, para registro no CRM;
- relatório por custo por agendamento e por comparecimento, e não só por mensagem ou clique;
- aprovação sua, clínica e ética, antes de cada peça ir ao ar (Parte 2).

Se a agência não consegue trabalhar assim, você sabe em qual dos dois jogos ela está.

# Qual plataforma para qual intenção

| Situação do paciente | Plataforma | Tipo de campanha |
|---|---|---|
| **Já sabe que precisa e está procurando ("fisioterapia joelho Moema")** | Google Ads | Pesquisa, com palavras-chave de intenção e local |
| **Precisa, mas ainda não está procurando** | Meta Ads (Instagram e Facebook) | Mensagens para WhatsApp com Reel educativo |
| **Ainda não conhece você** | Meta Ads e YouTube | Alcance ou visualização de vídeo de autoridade |
| **Já interagiu e não agendou** | Meta Ads | Público de envolvimento com o perfil (sem listas de pacientes) |
| **Tema de prevenção para público amplo, a partir de 18 anos** | TikTok | Promote ou TikTok Ads Manager, com vídeo que já foi bem no orgânico |

O passo a passo, clique por clique, do Gerenciador de Anúncios da Meta e dos anúncios no TikTok está no **Anexo A**.

## Ser visto vem antes de ser escolhido

Anúncios funcionam melhor em sequência do que como peças soltas. Uma forma de organizar, comum no marketing digital, tem cinco passos, cada um com o seu objetivo:

1. **Estímulo.** Quem ainda não conhece você vê um vídeo de autoridade. Objetivo: alcance ou visualização. Muita gente assiste sem curtir nem comentar, e ser visto vem antes de interagir.
2. **Descoberta.** Quem se interessou pesquisa e encontra o seu conteúdo orgânico, o Perfil da Empresa e o YouTube. Aqui não se paga: colhe-se o que a Parte 4 plantou.
3. **Ação.** Quem já interagiu recebe o convite para conversar. Objetivo: mensagens para o WhatsApp, com público de envolvimento.

4. **Experiência própria.** Atendimento, consulta e acompanhamento (Partes 10 a 12). Nenhum anúncio compensa uma experiência ruim.
5. **Experiência compartilhada.** O paciente satisfeito avalia e indica, o que alimenta a descoberta de outras pessoas. Na saúde, sem recompensa e sem sorteio.

Comece pelos passos 2 e 3, que pedem orçamento menor, e só invista em estímulo quando o atendimento já transformar conversas em consultas.

## Meta Ads passo a passo

1. **Estrutura.** Crie um Portfólio empresarial no Meta Business Suite, vincule a página do Facebook, a conta do Instagram e o número de WhatsApp Business. Cadastre forma de pagamento e verifique a empresa.
2. **Rastreamento.** Instale o Pixel e, se houver site, a API de Conversões. Para campanhas de WhatsApp, a conversão real (agendou, compareceu) é registrada no CRM e, quando possível, devolvida à Meta como evento offline, sem dados clínicos.
3. **Objetivo.** No Gerenciador de Anúncios, escolha Engajamento com destino "Apps de mensagem / WhatsApp" para gerar conversas, ou Cadastros com formulário instantâneo quando a clínica tem equipe para ligar rapidamente.
4. **Orçamento.** Comece com um valor diário que você possa manter por pelo menos 14 dias sem mexer. Mudanças frequentes reiniciam o aprendizado.
5. **Público.** Localização por raio em torno da clínica (geralmente de 3 a 10 km nas capitais), idade compatível com o paciente e segmentação ampla. A Meta removeu opções de interesse ligadas a condições de saúde; deixe o criativo selecionar o público.
6. **Posicionamentos.** Advantage+ ou manual com Reels, Stories e Feed do Instagram.
7. **Criativo.** Use os Reels orgânicos com melhor retenção e mais envios, de preferência os que mostram o seu diferencial. Teste de 3 a 5 criativos por conjunto. Texto principal curto, título com o benefício informativo, CTA "Enviar mensagem".
8. **Mensagem de boas-vindas no WhatsApp.** Pergunta simples que qualifica: "Olá! Você gostaria de agendar uma avaliação ou tirar uma dúvida sobre [tema]?"
9. **Leitura.** Depois de 7 dias, compare custo por conversa, taxa de agendamento e custo por comparecimento por criativo. Desligue o pior, duplique o melhor. O criativo mais barato por conversa nem sempre é o que traz quem comparece.

# Google Ads passo a passo

1. **Conta e Perfil da Empresa.** Crie a conta no Google Ads e vincule o Perfil da Empresa no Google para exibir endereço e ligação.
2. **Conversões.** Configure a tag do Google no site, conversões de ligação, cliques no WhatsApp e envio de formulário. Importe do CRM as conversões de agendamento e comparecimento quando possível.
3. **Campanha de Pesquisa.** Uma campanha por serviço principal, grupos de anúncios por tema (“implante dentário”, “prótese protocolo”).
4. **Palavras-chave.** Correspondência de frase e exata com intenção e local (“fisioterapeuta para coluna em Campinas”, “psicólogo ansiedade online”). Palavras negativas desde o primeiro dia: “grátis”, “curso”, “emprego”, “salário”, “o que é” quando não interessa.
5. **Anúncios responsivos.** Até 15 títulos e 4 descrições, informativos e verificáveis (“Fisioterapia com avaliação individual”, “Atendimento em Moema”, “Agende pelo WhatsApp”).
6. **Recursos (extensões).** Local, ligação, sitelinks (Convênios, Como funciona, Equipe), frases de destaque (“Estacionamento no local”).
7. **Lances.** Comece com Maximizar cliques com teto ou Maximizar conversões; migre para CPA desejado quando houver ao menos 30 conversões por mês.
8. **Políticas.** O Google restringe anúncios de saúde e medicamentos e proíbe remarketing baseado em condições de saúde. Psicólogos e psiquiatras devem evitar termos que impliquem diagnóstico do usuário.
9. **YouTube.** Campanhas de vídeo para o público local com os vídeos de autoridade, medindo visualizações e buscas pelo seu nome.

# Que tipo de mensagem funciona (e é ética)

| Tipo | Exemplo | Bom para |
|---|---|---|
| **Educativa com convite** | "Dor no joelho ao subir escada tem causas tratáveis. Entenda e agende uma avaliação." | Fisioterapia, ortopedia |
| **Processo transparente** | "Como funciona a primeira consulta: 50 minutos, avaliação completa e plano por escrito." | Todas, especialmente psicologia |
| **Acesso e conveniência** | "Atendimento presencial em Moema e online. Agende pelo WhatsApp." | Todas |
| **Autoridade sem superlativo** | "Fisioterapeuta com formação em reabilitação esportiva, CREFITO-3 000000-F." | Todas |
| **Desmistificação** | "Implante dói? Veja o que acontece em cada etapa." | Odontologia |

ATENÇÃO

**Nunca anuncie:**
resultado garantido, "o melhor", antes e depois fora das regras do conselho, urgência artificial, preço ou desconto onde o conselho proíbe (odontologia e psicologia), linguagem que afirme a condição do usuário ("Você tem depressão?").

PROMPT PRONTO

**Anúncio Meta e Google**

Crie para [PROFISSÃO/CLÍNICA] em [BAIRRO, CIDADE], serviço [SERVIÇO]. Meu diferencial: [SUA PROPOSTA DE VALOR]; os textos devem mostrá-lo com fatos, sem adjetivos. Entregue: (a) 3 textos principais de até 125 caracteres e 3 títulos de até 40 caracteres para Meta Ads com CTA "Enviar mensagem"; (b) 15 títulos de até 30 caracteres e 4 descrições de até 90 caracteres para anúncio responsivo de pesquisa no Google; (c) 20 palavras-chave com intenção e local e 15 negativas.

Regras: normas do [CONSELHO], políticas de saúde da Meta e do Google, sem superlativos, sem promessa, sem afirmar condição de saúde do usuário.

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Serviço: consulta de nutrição esportiva. Bairro: Pinheiros, São Paulo. Conselho: CFN.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

META ADS (trecho)
Textos (até 125 caracteres):
1. "Corre e quer organizar a alimentação? Conheça a consulta de nutrição esportiva em Pinheiros." (92)
2. "Plano alimentar por escrito para quem corre. Atendimento presencial ou online." (78)
3. "Dúvidas sobre o que comer antes de correr? Converse com uma nutricionista." (74)
Títulos (até 40): "Nutrição para corredores" | "Consulta em Pinheiros" | "Fale pelo WhatsApp"
CTA: Enviar mensagem.

GOOGLE (trecho)
Títulos (até 30): "Nutrição esportiva Pinheiros" | "Nutricionista para corredores" | "Consulta online ou presencial" | "Agende pelo WhatsApp"
Descrições (até 90): "Consulta com nutricionista esportiva em Pinheiros. Plano alimentar por escrito." | "Atendimento presencial e online para quem corre. CRN-3 00000."
Palavras-chave (amostra): nutricionista esportiva pinheiros; nutricionista para corredor sp; consulta nutrição esportiva online
Negativas (amostra): emagrecer rápido; dieta milagrosa; receita grátis; vaga de emprego; curso

CHECAGEM: nenhum superlativo, nenhuma promessa, nenhuma afirmação sobre a condição de saúde do usuário.

### ANTES DE USAR

- Confira os limites de caracteres no gerenciador de anúncios.
- Leia as políticas de saúde da Meta e do Google vigentes antes de enviar.

# Impulsionamento na Meta: manual passo a passo

**O que é.** Impulsionar (o aplicativo chama de "Turbinar") é pagar para que um post que já está no seu perfil seja mostrado a mais pessoas. É a forma mais simples de anúncio da Meta, feita em poucos toques no próprio Instagram ou Facebook. O Gerenciador de Anúncios, descrito acima, oferece mais controle; o impulsionamento é o melhor primeiro passo para quem nunca anunciou.

## Quando impulsionar

- Só peças educativas que já foram bem no orgânico (mais envios, salvamentos e mensagens que a média) e já passaram pela revisão clínica e ética.
- Defina antes uma única ação desejada: visita ao perfil, conversa no WhatsApp ou visita à página de agendamento.
- Separe o orçamento de mídia do custo de produção.
- Para uma clínica local, alcançar pessoas perto do consultório vale mais que audiência nacional.

## Antes de começar (uma vez só)

1. Conta profissional no Instagram (Parte 3).
2. Página do Facebook da clínica vinculada à conta do Instagram, pela Central de Contas ou pelo Meta Business Suite.
3. WhatsApp Business conectado, se o objetivo for conversa, com mensagem de boas-vindas pronta e alguém para responder no horário do anúncio.
4. Forma de pagamento cadastrada (cartão e, quando disponível, Pix ou boleto).
5. Post sem música protegida por direitos autorais. Posts com músicas do catálogo comum podem não ser impulsionáveis; troque o áudio por um da biblioteca comercial.

## Passo a passo no celular (Instagram)

1. **Escolha o post.** Abra o Reel ou carrossel escolhido e toque em "Turbinar" (ou "Turbinar publicação"), logo abaixo dele.

2. **Objetivo.** O aplicativo pergunta o que você quer que as pessoas façam. As opções costumam ser: mais visitas ao perfil, mais visitas ao site e mais mensagens. Para clínicas, "mais mensagens" (Direct ou WhatsApp) é o mais próximo de um agendamento; "mais visitas ao perfil" serve para ganhar seguidores qualificados.
3. **Público.** Escolha "Criar o seu" em vez do automático. Em localização, coloque o endereço da clínica e um raio de alguns quilômetros (por exemplo, de 3 a 10 km em capitais). Defina a faixa de idade do seu paciente. Deixe interesses em branco ou amplos: a Meta não permite segmentar por condição de saúde, e o próprio conteúdo atrai as pessoas certas.
4. **Orçamento e duração.** Informe um valor por dia e o número de dias. O aplicativo mostra o alcance estimado. Comece com um valor que você possa manter por pelo menos 7 dias sem mexer; alterar a cada dia reinicia o aprendizado da plataforma.
5. **Revisão e pagamento.** Confira o resumo (post, objetivo, público, orçamento, duração) e toque em "Turbinar publicação". A Meta analisa o anúncio antes de veiculá-lo, normalmente em algumas horas.
6. **Acompanhamento.** No painel profissional, em "Anúncios", veja alcance, cliques, mensagens e custo por resultado. Não altere nada nos dois ou três primeiros dias.
7. **Registro no CRM.** Marque a origem de cada conversa como "Impulsionamento, [post], [data]". Ao final, calcule o custo por conversa, por agendamento e por paciente que compareceu.

**No computador (Meta Business Suite).** Em business.facebook.com, abra Conteúdo, escolha o post e clique em "Turbinar". As escolhas são as mesmas, com a vantagem de ver Instagram e Facebook juntos e de escolher onde o anúncio aparece (Feed, Stories, Reels). Quando quiser testar vários criativos ou públicos ao mesmo tempo, passe para o Gerenciador de Anúncios.

## Por que um impulsionamento é recusado e como corrigir

| Motivo comum | Como corrigir |
|---|---|
| Texto que afirma uma condição do leitor ("Você tem ansiedade?") | Fale do tema, não da pessoa ("Ansiedade tem tratamento") |
| Antes e depois ou foco em aparência corporal | Use explicação de processo, modelo ou ilustração; siga também a regra do conselho |

| Motivo comum | Como corrigir |
|---|---|
| **Promessa de resultado, preço ou desconto vedados pelo conselho** | Reescreva com o Verificador ético (Parte 15) |
| **Música protegida** | Troque pelo áudio da biblioteca comercial |
| **Conta ou página com restrição** | Resolva no Meta Business Suite, em Qualidade da conta |

Se achar que a recusa foi um engano, peça nova análise no próprio aviso de reprovação.

## Checklist do impulsionamento

- Post aprovado na revisão em duas etapas (Parte 2)
- Um objetivo só, ligado a uma ação mensurável
- Público local, por raio e idade, sem segmentar por saúde
- Orçamento diário e duração definidos
- WhatsApp pronto, com boas-vindas e alguém para responder
- Origem marcada no CRM
- Data de leitura dos resultados na agenda

**ROAS** é a receita atribuída dividida pelo gasto em anúncios. Só calcule com rastreamento real até o paciente que iniciou o tratamento, e não o confunda com o ciclo de adaptação de referências da Parte 4. Marque no CRM e nos relatórios o que foi impulsionado, para não comparar peças pagas com orgânicas.

PROMPT PRONTO

**Plano de impulsionamento**

Sou [PROFISSÃO] em [BAIRRO, CIDADE] e quero impulsionar o post abaixo na Meta. Objetivo: [VISITAS AO PERFIL / MENSAGENS NO WHATSAPP]. Orçamento total: [VALOR].

Devolva: (1) se o post é adequado para impulsionar e o que ajustar segundo as normas do [CONSELHO] e as políticas de saúde da Meta; (2) público sugerido (raio e idade), sem segmentar por condição de saúde; (3) orçamento diário e duração; (4) mensagem de boas-vindas no WhatsApp; (5) o que medir, quando e como registrar no CRM. Não invente números.

Post: [COLE O TEXTO E DESCREVA O VÍDEO]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Post: Reel "3 erros na hidratação de quem corre". Objetivo: mensagens no WhatsApp. Orçamento: R$ 140.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

1. Adequação: o post serve, com dois ajustes: tirar "erros graves" do título (sensacionalismo) e colocar nome, CRN e especialidade na legenda.
2. Público: moradores e frequentadores de Pinheiros, Vila Madalena e Alto de Pinheiros (raio de 5 km), 28 a 55 anos. Sem segmentar por condição de saúde, peso ou doença.
3. Orçamento: R$ 20 por dia durante 7 dias, mantido igual para não reiniciar o aprendizado.
4. Mensagem de boas-vindas: "Olá! Aqui é a equipe da Dra. Bia Nunes. Como podemos ajudar? Se for sobre consulta, conte brevemente o motivo (sem dados de saúde)."
5. O que medir: no dia 3 e no dia 7, anote no Rastreador quantas mensagens vieram do anúncio (origem "Impulsionamento"), quantas viraram conversa, quantas agendaram. Compare com um período sem anúncio.

### ANTES DE USAR

- O número de dias e o valor são ponto de partida, não garantia.
- Se o orçamento não permite um período de teste, prefira 3 posts orgânicos antes de impulsionar.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** criativos de banco de imagens, modelos usados para vários clientes e qualquer promessa ou condição comercial vedada pelo conselho.
- **Reduzir:** o orçamento em alcance amplo antes de o atendimento transformar conversas em consultas.
- **Elevar:** o uso dos seus melhores conteúdos orgânicos como criativo e a leitura por custo por paciente que compareceu.
- **Criar:** um briefing do seu diferencial para quem cuida dos seus anúncios, seja você, a sua equipe ou uma agência.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Antes de investir, confira se o Pixel ou a tag do Google estão instalados e se cada conversa vinda de anúncio chega ao CRM com a origem marcada. Escolha os dois Reels orgânicos com mais envios e mensagens: eles são os primeiros candidatos a anúncio.

NO CLINILOOP

**Gerador de campanhas.**
Monta o plano de impulsionamento, os textos, títulos, palavras-chave e públicos para Meta Ads e Google Ads e liga cada campanha aos pacientes que ela trouxe.

---

**Próxima passagem.** *Conteúdo, colegas e anúncios trazem pessoas até a porta. Agora começa o trecho mais perigoso da travessia, aquele em que a maioria dos pacientes se perde: a conversa no WhatsApp.*

NO ROTEIRO · ETAPA 4 DE 6 · CONVERTA CONTATOS EM CONSULTAS

*Na jornada · A aproximação da caverna*

# 10

# Do clique à consulta: a decisão de agendar

*A conversa no WhatsApp é o primeiro contato direto com a sua diferença. Quem chega pela porta da confiança quer confirmar o que já viu. Quem chega pela porta do preço precisa descobrir, ali, por que vale escolher você.*

---

NESTA PARTE · PARTE 10

Padrões de atendimento · Duas conversas diferentes · Roteiro de agendamento em cinco mensagens · Preço · Retomadas

Nas histórias, a caverna é o lugar onde o perigo é maior e onde está o que o herói procura. No consultório, a caverna é a conversa no WhatsApp. É ali que se perde boa parte dos pacientes que você trabalhou para atrair.

O paciente que chama no WhatsApp muitas vezes está conversando com mais de um consultório ao mesmo tempo. Velocidade e clareza contam muito. Mas, se todos responderem rápido e com o mesmo texto, a decisão volta para o preço. A diferença precisa aparecer também aqui.

## Padrões de atendimento

- **Primeira resposta em até 5 minutos** no horário comercial. Fora dele, resposta automática que informa quando haverá retorno e já oferece horários.
- **Todo contato vira um registro no CRM** com origem (Instagram orgânico, conteúdo citado, Meta Ads, Google, indicação de colega e qual, paciente antigo). Sem origem, a hipótese deste guia não pode ser testada.
- **Toda conversa termina com um próximo passo marcado:** consulta agendada, retorno combinado ou motivo de perda registrado.

## Duas conversas diferentes

A Parte 1 descreveu duas portas de entrada. Elas pedem conversas diferentes.

**Quem chega pela porta da confiança** (“vi o seu vídeo sobre...”, “a Dra. Fulana me indicou”) já sabe quem você é. Não repita o que a pessoa viu; confirme e facilite. Agradeça a indicação, mencione o conteúdo citado e vá direto aos horários. Registre no CRM o conteúdo ou o colega de origem.

**Quem chega pela porta do preço** (“quanto custa uma consulta?”) ainda não sabe por que escolher você. Antes de qualquer valor, explique em duas frases como é o seu atendimento, usando o que você elevou e criou na Parte 3. Se fizer sentido, envie um conteúdo seu que responde à dúvida da pessoa. Você está levando a conversa da porta do preço para a porta da confiança.

**Quem chega por um caminho intermediado** (convênio, plataforma de agendamento, plantão) muitas vezes escolheu você por conveniência: estava na lista, tinha horário, ficava perto. Trate essa conversa como uma chance de mostrar a diferença pela primeira vez. A mesma explicação de duas frases sobre o seu atendimento vale aqui, e o Anexo D mostra o que mais fazer nesses caminhos.

## Roteiro de agendamento em cinco mensagens

1. **Acolher e identificar.** "Olá, [nome]! Aqui é a [atendente], da clínica [nome]. Que bom que você nos procurou. Como posso ajudar?"
2. **Entender a necessidade e a origem, sem triagem clínica.** "Para eu direcionar ao profissional certo, você pode me contar em poucas palavras o motivo da consulta? Como conheceu a gente?"
3. **Explicar como funciona, com o seu diferencial:** duração, o que acontece na primeira consulta, o que o paciente leva dela, convênios ou particular, forma de pagamento, endereço ou link online.
4. **Oferecer dois horários.** "Tenho terça às 9h ou quinta às 18h. Qual fica melhor?" Duas opções fecham mais que "qual seu horário?".
5. **Confirmar e combinar a confirmação:** resumo com data, hora, endereço, o que levar, e o aviso de que haverá confirmação na véspera.

A mensagem 3 é onde o atendimento mais se parece com o de todo mundo. Escreva-a uma vez, com cuidado, a partir da sua proposta de valor. "A primeira consulta dura 60 minutos e você sai com o plano por escrito" diz mais do que "a consulta é completa".

## Quando o paciente pergunta o preço primeiro

Responda com transparência quando a norma permitir informar valor em conversa privada, mas sempre com o contexto do que está incluído: "A avaliação tem 60 minutos, inclui exame físico completo e plano por escrito. O valor é R$ [X]". Em psicologia, honorários são tratados de forma privada, nunca como propaganda.

Não entre em disputa de preço com outros consultórios. Se a pessoa disser que encontrou mais barato, explique de novo o que está incluído no seu atendimento e deixe a decisão com ela. Quem escolhe só pelo preço continua a ser bem tratado, mas não é o paciente que a sua diferença procura.

## Quem não agendou na hora

Faça uma sequência de até três retomadas no CRM (no dia seguinte, em 3 dias e em 7 dias), sempre com algo útil, como um conteúdo seu sobre a dúvida da pessoa, e nunca com pressão. Depois disso, a pessoa vai para uma lista de relacionamento, se consentiu.

PROMPT PRONTO

**Respostas rápidas**

Crie 12 mensagens de resposta rápida para o WhatsApp da [CLÍNICA], para [PROFISSÃO]. Nosso diferencial no atendimento: [SUA PROPOSTA DE VALOR]. Mensagens: boas-vindas, pedido de motivo da consulta e de como nos conheceu, resposta a quem chegou por um conteúdo, resposta a quem chegou por indicação de colega, explicação da primeira consulta com o nosso diferencial, convênios, valores (quando permitido), endereço, atendimento online, duas opções de horário, confirmação de agendamento, fora do horário, retomada em 1 dia e retomada em 7 dias. Tom acolhedor, frases curtas, sem orientação clínica, sem pressão e sem superlativos.

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Clínica: Consultório Bia Nunes. Profissão: nutricionista.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

1. Boas-vindas: "Olá! Aqui é do consultório da nutricionista Bia Nunes. Como posso ajudar?"
2. Motivo: "Para eu indicar o melhor caminho, pode contar em uma frase o que você procura? Não precisa dar detalhes de saúde por aqui."
3. Primeira consulta: "A primeira consulta dura cerca de 60 minutos e termina com um plano alimentar por escrito."
4. Convênios: "Atendemos como particular. Posso emitir recibo para pedido de reembolso."
5. Valores: "O valor da consulta é R$ [VALOR]." [CONFIRMAR se o CFN permite informar o valor no seu caso]
6. Endereço: "Atendemos na Rua [RUA], Pinheiros, a 5 minutos do metrô. Posso enviar a localização."
7. Online: "Sim, atendemos também por videochamada, com o mesmo plano por escrito."
8. Dois horários: "Tenho terça às 18h ou quinta às 8h30. Qual fica melhor?"
9. Confirmação: "Agendado: [DIA], [HORA], [LOCAL]. Se precisar remarcar, é só responder aqui."
10. Fora do horário: "Recebi sua mensagem. Respondo amanhã a partir das 9h."
11. Retomada em 1 dia: "Oi, [NOME]! Ficou alguma dúvida sobre a consulta? Posso ajudar."
12. Retomada em 7 dias: "Oi, [NOME]! Passando para saber se ainda faz sentido conversarmos. Se preferir, fico à disposição quando quiser."

### ANTES DE USAR

- Cada mensagem deve soar como você.
- Evite pressão e urgência artificial.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** a resposta padrão que poderia vir de qualquer consultório e a disputa de preço por mensagem.
- **Reduzir:** o tempo da primeira resposta e o número de mensagens até o horário.
- **Elevar:** a explicação de como é o seu atendimento, antes do valor.
- **Criar:** respostas próprias para quem chega por conteúdo e por indicação, e o registro da origem em toda conversa.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Cadastre as respostas rápidas no WhatsApp Business, incluindo a pergunta "como nos conheceu?". Durante uma semana, meça o tempo da primeira resposta e anote a origem de cada conversa.

NO CLINILOOP

**Atendimento e agendamento.**
Respostas rápidas, roteiro de agendamento e retomadas de quem não marcou, registradas no Rastreador de pacientes.

---

**Próxima passagem.** *A consulta está marcada. Mas entre o agendamento e a cadeira ainda há um trecho escuro, em que o paciente pode simplesmente não aparecer.*

NO ROTEIRO · ETAPA 4 DE 6 · CONVERTA CONTATOS EM CONSULTAS

*Na jornada · O fundo da caverna*

# 11

# A decisão de comparecer

*Cada falta é uma hora de agenda perdida que não volta. Boa parte das faltas se evita com confirmação ativa, lembrete e facilidade para remarcar. E o paciente que já sabe quem vai encontrar tem menos motivo para desistir.*

NESTA PARTE · PARTE 11

Sequência de confirmação · Boas práticas · Comparecimento por origem · Meta prática

O agendamento é uma vitória, mas a caverna ainda não acabou. Entre o dia em que a consulta foi marcada e o dia em que ela acontece, o paciente tem tempo para esquecer, adiar ou desistir.

Meça a taxa de faltas (no-show) por profissional, por origem e por dia da semana no CRM. A coluna da origem é a mais importante para este guia.

## Sequência de confirmação

| Quando | Mensagem | Objetivo |
|---|---|---|
| **Ao agendar** | Resumo com data, hora, endereço, mapa, o que levar | Clareza |
| **48 horas antes** | "Confirma sua consulta de [dia] às [hora]? Responda 1 para confirmar ou 2 para remarcar." | Confirmação ativa |
| **24 horas antes, se não respondeu** | Ligação ou segunda mensagem | Recuperar silêncio |
| **2 horas antes** | Lembrete curto com localização e estacionamento | Chegada no horário |
| **Após a falta, no mesmo dia** | "Sentimos sua falta. Quer remarcar?" com dois horários | Reagendar sem constranger |

A confirmação também pode carregar a sua diferença. Junto do resumo do agendamento, envie um conteúdo seu que explica como será a primeira consulta. O paciente chega sabendo o que vai acontecer, e a consulta deixa de ser um desconhecido que dá vontade de adiar.

## Boas práticas

- **Agende o retorno antes de o paciente sair da consulta.** Retorno “a combinar” vira falta.
- **Lista de espera no CRM** para preencher vagas liberadas por remarcação.
- **Pacientes com duas faltas seguidas** recebem contato humano, não automático.
- **Política de cancelamento clara,** informada no agendamento e aplicada com bom senso.
- **Em psicologia e psiquiatria,** a falta pode ser sinal clínico. O contato é do profissional ou de alguém treinado, com cuidado.

## Comparecimento por origem

Aqui a hipótese deste guia fica mensurável. Se o paciente que chega por confiança comparece mais, isso aparece na taxa de comparecimento separada por origem: conteúdo, indicação de colega, indicação de paciente, Google, anúncio.

Depois de dois ou três meses de registro, compare as taxas. Se uma origem tem muito mais faltas que as outras, há duas leituras possíveis. A primeira: aquela porta traz pacientes menos decididos, e vale mudar a mensagem que leva até ela. A segunda: o atendimento trata aquela origem de um jeito pior. O CRM não decide por você, mas mostra onde olhar.

A IDEIA CENTRAL

Acompanhe a taxa de comparecimento mensal e trabalhe para que ela suba mês a mês. Clínicas com sequência de confirmação bem feita costumam reduzir faltas de forma perceptível, mas o número de referência é o seu próprio histórico.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** o retorno “a combinar” e a mensagem de confirmação sem nenhuma informação útil.
- **Reduzir:** a incerteza do paciente sobre o que vai acontecer na consulta.
- **Elevar:** a confirmação ativa e o contato humano depois de duas faltas.
- **Criar:** um conteúdo seu enviado junto com o agendamento, que mostra como será a primeira consulta.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Configure a mensagem de confirmação de 48 horas e anote a taxa de faltas deste mês, separada por origem. Ela é a linha de base para o próximo.

NO CLINILOOP

**Rastreador de pacientes.**
Gera os lembretes de confirmação (.ics) e mostra a taxa de comparecimento por profissional, origem e dia da semana.

---

**Próxima passagem.** *O paciente chegou. Agora vem a provação, o momento em que tudo o que você mostrou no caminho é posto à prova diante dele.*

NO ROTEIRO · ETAPA 5 DE 6 · FECHE E ACOMPANHE O TRATAMENTO

*Na jornada · A provação*

# 12

# A decisão de tratar: fechamento com ética

*Na saúde, fechar não é vender. É o paciente entender o plano, confiar nele e decidir começar. É também o momento em que a diferença prometida no conteúdo precisa ser entregue de verdade.*

---

NESTA PARTE · PARTE 12

Por que precisa de processo · Onde a diferença é cumprida · O fechamento em cinco momentos · Fisioterapia · Clínicas · Objeções honestas

Toda jornada tem uma provação, o momento em que o herói enfrenta a prova mais séria e descobre do que é feito. Na sua, a provação é a consulta. Tudo o que você mostrou no conteúdo, no perfil e na conversa é conferido ali, de perto, pelo paciente.

Clínicas e fisioterapeutas sentem isso mais que ninguém, porque o resultado depende de um plano com várias sessões, e um plano proposto e não iniciado é o maior vazamento de receita do consultório.

## Por que é preciso um processo de fechamento

- O tratamento é uma série (10, 20 sessões; várias etapas de um tratamento odontológico), não um ato único.
- O paciente recebe o plano e diz "vou pensar". Sem acompanhamento, ele não volta.
- A adesão cai depois das primeiras sessões, quando a dor melhora e o paciente abandona antes da alta.
- A equipe (recepção, coordenação, profissional) precisa falar a mesma língua.

## Onde a diferença é cumprida

Todo o trabalho das Partes 3 a 11 cria uma expectativa: o paciente chega porque viu como você explica, como você atende e o que você faz de diferente. Na consulta, essa expectativa é conferida. Se o atendimento for igual ao de qualquer outro, a confiança construída no conteúdo se desfaz, e a decisão volta para o preço.

O contrário também vale. Um atendimento que cumpre o que o conteúdo mostrou é a melhor prova da sua diferença. É ele que gera a avaliação espontânea no Google, a indicação ao amigo e o retorno ao colega que encaminhou. A decisão 7 alimenta, de novo, as decisões 1 a 3.

A provação é a mesma para todos os caminhos. O paciente que chegou pelo convênio, pela plataforma ou pela fachada passa pela mesma consulta que o paciente indicado. Se ela cumprir o que você promete no conteúdo, esse paciente também passa a indicar, e um caminho de conveniência vira, na próxima volta, um caminho de confiança.

Por isso, o fechamento abaixo não é uma técnica de venda. É a forma de entregar, no consultório, o que você elevou e criou na Parte 3: a explicação clara, o plano por escrito, o acompanhamento entre as consultas.

## O fechamento em cinco momentos

1. **Avaliação que escuta.** Pergunte o objetivo do paciente na vida real (“voltar a correr”, “brincar com o neto sem dor”, “mastigar sem medo”). O plano será apresentado em função dele.
2. **Plano por escrito.** Diagnóstico funcional em linguagem simples, objetivos por fase, número estimado de sessões ou etapas, frequência, o que depende do paciente, critérios de reavaliação e de alta. Nunca prometa resultado; mostre metas e como serão medidas.
3. **Conversa sobre investimento, em particular.** Valor, formas de pagamento e alternativas (plano completo, por fase, convênio quando houver). Nas profissões em que o conselho permite, pacotes são uma forma de organizar o tratamento, não um chamariz publicitário.
4. **Tempo para decidir, com data.** “Fique à vontade para pensar. Posso falar com você na quinta para tirar dúvidas?” A data vai para o CRM como próximo passo.
5. **Acompanhamento do plano em aberto.** Contato em 2, 7 e 15 dias, com informação útil e disponibilidade, nunca pressão. Depois disso, o plano é marcado como não iniciado com o motivo.

## Fisioterapia: da avaliação à alta

| Momento | O que fazer | Registro no CRM |
|---|---|---|
| **Avaliação** | Testes funcionais, escala de dor, objetivo do paciente | Etapa Avaliado; objetivo em uma frase |
| **Proposta** | Plano por fases com número de sessões e frequência | Etapa Plano proposto; valor e forma de pagamento |

| Momento | O que fazer | Registro no CRM |
|---|---|---|
| Início | Agendar o bloco de sessões de uma vez | Etapa Em tratamento; sessões agendadas |
| Sessão 4 a 6 | Reavaliação com os mesmos testes, mostrar evolução | Marco de reavaliação; risco de abandono |
| Alta | Relatório de alta, orientações, plano de manutenção (Pilates, treino) | Etapa Alta; pedido de avaliação no Google; contrarreferência ao médico |
| 30 a 90 dias depois | Contato de acompanhamento | Retorno ou manutenção |

## Clínicas multiprofissionais e odontológicas

- **Um coordenador de tratamento** (ou a secretária treinada) é dono do pipeline de planos propostos. O profissional diagnostica e propõe; o coordenador acompanha.
- **Reunião semanal de 30 minutos** sobre planos em aberto.
- **Indicadores por profissional:** taxa de aceitação de planos, tempo médio até iniciar, taxa de conclusão até a alta.
- **Encaminhamentos internos registrados** (dentista para fisioterapia de DTM, fisioterapeuta para nutricionista), sempre por critério clínico.
- **A mesma diferença em todos os profissionais.** Se a clínica promete plano por escrito, todos entregam plano por escrito. Diferença que depende de quem atende não é diferença da clínica.

ATENÇÃO

**Médicos, psiquiatras e psicólogos: o fechamento é a adesão.**
Não há "fechar" no sentido comercial. O equivalente é o paciente entender a conduta, agendar o retorno e seguir o tratamento. Em saúde mental, o vínculo terapêutico é o centro, e qualquer contato de acompanhamento deve partir de critério clínico, nunca de meta comercial.

## Objeções comuns e respostas honestas

| Objeção | Resposta |
|---|---|
| "Vou pensar" | "Claro. O que ficou menos claro no plano? Posso te ligar na [data] para conversarmos?" |
| "Está caro" | Explique o que está incluído e ofereça alternativas legítimas (por fase, frequência ajustada, convênio). Nunca desconto como pressão. |
| "Já melhorei" (fisioterapia) | Mostre o objetivo combinado e os testes da reavaliação: o que falta para a alta e o risco de recidiva, sem alarmismo. |
| "Não tenho tempo" | Ajuste frequência e horários, exercícios domiciliares, teleatendimento quando permitido. |

Anote no CRM a objeção de cada plano não iniciado, junto com a origem do paciente. Com o tempo, você vai ver quais objeções aparecem mais em cada porta de entrada. Se "está caro" se concentra em quem chegou por anúncio genérico, a correção não está no fechamento: está no anúncio.

PROMPT PRONTO

**Plano de tratamento compreensível**

Transforme as anotações técnicas abaixo em um plano de tratamento para o paciente ler, em linguagem simples, com: objetivo do paciente em uma frase, fases com metas mensuráveis, número estimado de sessões e frequência, o que depende do paciente, como e quando vamos reavaliar e critério de alta.

Não prometa resultado. Marque com [CONFIRMAR] o que faltar. Use apenas iniciais. Anotações: [COLE AQUI]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Anotações técnicas: M.S., meta de completar os 10 km em prova; hoje corre 5 km; 3 treinos por semana; refeições irregulares; 8 semanas de plano; reavaliação com 4 e 8 semanas.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

SEU PLANO (iniciais: M.S.)
Seu objetivo: chegar à sua primeira prova de 10 km com energia e confiança na alimentação.

Fase 1, semanas 1 a 4: regularizar as refeições
- Meta: fazer 4 refeições ao dia em horários combinados.
- Meta: incluir uma fonte de proteína no café da manhã.
Fase 2, semanas 5 a 8: preparar a prova
- Meta: testar a refeição pré-treino nos treinos longos.
- Meta: definir o plano da véspera e da manhã da prova.

Sessões: 3 consultas no total (início, semana 4 e semana 8), de cerca de 45 a 60 minutos. Os ajustes entre consultas serão feitos por mensagem, em horário combinado.
O que depende de você: registrar as refeições em um caderno ou aplicativo e avisar mudanças no treino.
Reavaliação: nas semanas 4 e 8.
Alta: quando as metas das duas fases estiverem estáveis por duas semanas.
O resultado de cada pessoa é diferente; este plano organiza o caminho, sem garantir um resultado.

[CONFIRMAR] valor das consultas e forma de pagamento.

### ANTES DE USAR

- Revise as metas com o seu critério clínico.
- Entregue ao paciente por escrito e guarde a versão assinada, se for o seu procedimento.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** o plano só verbal e o “vou pensar” sem data de retorno.
- **Reduzir:** a linguagem técnica na explicação do plano.
- **Elevar:** o plano por escrito, as metas mensuráveis e a reavaliação com os mesmos testes.
- **Criar:** um acompanhamento entre as consultas que o paciente não encontra em outro lugar e que confirma o que o seu conteúdo prometeu.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Liste os planos propostos nos últimos 30 dias que não começaram. Para cada um, registre a origem do paciente, o motivo provável e um contato de acompanhamento com data.

NO CLINILOOP

**Rastreador e Assistente da semana.**
Destaca planos propostos sem decisão em 2, 7 e 15 dias e monta a agenda de acompanhamentos da semana.

---

**Próxima passagem.** *A provação passou. Agora é hora de colher a recompensa, que nesta jornada não é um troféu, e sim um conhecimento: saber quais caminhos trazem os pacientes que ficam.*

NO ROTEIRO · ETAPA 6 DE 6 · MEÇA E ESCALE COM CRM

*Na jornada · A recompensa*

13

# O CRM: a gestão do relacionamento com o paciente

*A clínica que cresce não é a que recebe mais mensagens. É a que sabe onde cada paciente está, qual é o próximo passo e por qual porta entraram os pacientes que ficam.*

NESTA PARTE · PARTE 13

O funil do paciente em sete etapas · O funil dos colegas · O que registrar · Métricas · A conta da hipótese · O ritual semanal · Automações

Depois da provação, o herói recebe a recompensa. Nesta jornada, ela não é um troféu: é saber. Saber onde cada paciente está, qual é o próximo passo e por qual porta entraram os que ficaram. Quem tem esse conhecimento depende menos da sorte.

Uma linha sem próximo passo é um paciente parado, e um paciente parado é alguém que vai se tratar em outro lugar, ou não vai se tratar.

O CRM tem dois papéis neste guia. O primeiro é o de sempre: nada se perde entre o primeiro contato e a alta. O segundo é o que torna este guia honesto: é no CRM que você descobre se a diferenciação está trazendo, para o seu consultório, pacientes que agendam, comparecem e aderem mais. Sem registro, a hipótese continua sendo só uma ideia.

ATENÇÃO

**CRM não é prontuário.**
O prontuário guarda a história clínica e segue as regras do conselho. O CRM guarda o relacionamento: origem, etapa, próximo passo, contatos, consentimentos. Os dois podem conversar, mas dado clínico não entra no CRM.

## O funil do paciente em sete etapas

| Etapa | Quando muda para ela | Próximo passo típico |
|---|---|---|
| **1 Novo contato** | Mandou mensagem, ligou, preencheu formulário ou foi indicado | Responder em até 5 minutos |
| **2 Em conversa** | Houve troca de mensagens | Oferecer dois horários |
| **3 Agendado** | Consulta ou avaliação marcada | Confirmação em 48 horas |
| **4 Avaliado** | Compareceu à primeira consulta | Apresentar plano ou conduta |

| Etapa | Quando muda para ela | Próximo passo típico |
|---|---|---|
| **5 Plano proposto** | Recebeu plano de tratamento ou orçamento | Acompanhamento em 2, 7 e 15 dias |
| **6 Em tratamento** | Iniciou o plano | Reavaliação programada |
| **7 Alta e vínculo** | Concluiu o plano ou segue em manutenção | Contato de acompanhamento, avaliação no Google, retorno periódico |

**Saídas em qualquer etapa:** Perdido (com motivo: preço, horário, distância, escolheu outro, sem resposta) ou Pausado (com data para retomar). Para médicos e psicólogos sem planos por pacote, as etapas 5 e 6 viram "Retorno agendado" e "Em acompanhamento".

## O funil dos colegas

Um segundo funil, menor, para a rede de indicação: Mapeado, Apresentado, Primeira indicação, Parceiro ativo (indicou nos últimos 90 dias), Inativo. Cada paciente indicado fica ligado ao colega que indicou.

## O que registrar (e o que ignorar)

- **Pessoa:** nome, telefone, canal preferido, consentimento de comunicação com data.
- **Origem:** a família do caminho, com os nomes do capítulo As jornadas do paciente: conteúdo (e qual peça, quando a pessoa citar), busca, indicação (de colega, qual; interna; de paciente), retorno, mídia paga (campanha e criativo), caminhos intermediados (convênio, plataforma, hospital, fachada) e presença fora do digital.
- **Serviço de interesse e profissional.**
- **Etapa e próximo passo com data:** o campo mais importante para o dia a dia.
- **Valor do plano proposto** (clínicas e fisioterapia).

- **Aprendizado:** uma frase sobre objeções ou motivo de perda.

Ignore no começo: notas de satisfação internas, campos clínicos, longos resumos. Se precisar, eles aparecerão.

A origem é o campo que mais se perde, porque ninguém pergunta. Inclua "como nos conheceu?" no roteiro de atendimento (Parte 10) e preencha sempre, mesmo quando a resposta for "não sei".

## Métricas que importam

| Métrica | Como calcular | Para que serve |
|---|---|---|
| **Tempo da primeira resposta** | Média entre a mensagem e a resposta | Perda silenciosa de pacientes |
| **Taxa de agendamento** | Agendados ÷ novos contatos | Qualidade do atendimento e do tráfego |
| **Taxa de comparecimento** | Compareceram ÷ agendados | Eficácia da sequência de confirmação |
| **Taxa de aceitação de planos** | Iniciaram ÷ planos propostos | Fechamento, por profissional |
| **Taxa de conclusão** | Altas ÷ iniciados | Adesão e resultado clínico |
| **Custo por paciente que compareceu** | Investimento em mídia ÷ comparecimentos daquela origem | Onde investir |
| **Indicações por colega** | Pacientes indicados por colega por mês | Saúde da rede |
| **Receita por origem** | Soma dos planos iniciados por origem | Retorno de cada canal |

# A conta da hipótese

A Apresentação propôs uma hipótese: o paciente que chega por confiança tende a agendar, comparecer e aderir mais do que o que chega pelo preço. Esta é a conta que confirma ou desmente essa ideia no seu consultório.

1. **Espere 90 dias de registro** com a origem preenchida. Antes disso, os números são pequenos demais.
2. **Agrupe as origens pelas portas.** Confiança: conteúdo, indicação, presença fora do digital e retorno. Preço ou conveniência: anúncios com criativo genérico, caminhos intermediados, busca sem conteúdo associado e origem não informada. Anúncios feitos a partir do seu conteúdo podem ficar num grupo à parte, e os caminhos intermediados também, se forem uma fatia grande da sua agenda.
3. **Para cada grupo, calcule** as taxas de agendamento, comparecimento, aceitação de planos e conclusão.
4. **Compare.** Se o grupo da confiança tiver taxas maiores, a hipótese se confirma no seu consultório, e vale investir mais tempo em conteúdo e colegas. Se não tiver, olhe as etapas uma a uma: o problema pode estar no atendimento, no conteúdo ou na própria diferença.
5. **Refaça a conta a cada trimestre.** Uma leitura isolada não prova nada; a tendência sim.

| Porta | Novos contatos | Agendaram | Compareceram | Iniciaram tratamento |
|---|---|---|---|---|
| Confiança | [nº] | [%] | [%] | [%] |
| Anúncio a partir do seu conteúdo | [nº] | [%] | [%] | [%] |
| Caminhos intermediados | [nº] | [%] | [%] | [%] |
| Preço ou desconhecida | [nº] | [%] | [%] | [%] |

Não existe um número de referência para comparar, e este guia não inventa um. O padrão que importa é o seu. Se algum dia você quiser falar desses resultados em público, lembre-se de que as regras do seu conselho valem também para números (Parte 2).

## O ritual semanal de 30 minutos

Horário fixo, de preferência sexta à tarde, a mesma sequência sempre:

1. **Atualize** as etapas de cada paciente e colega.
2. **Caça aos parados:** toda linha sem próximo passo ganha um, ou é marcada como Pausada ou Perdida.
3. **Envie** os acompanhamentos vencidos.
4. **Leia** os números da semana contra a meta.
5. **Encontre o gargalo:** em que etapa os pacientes mais param? Escolha uma ação.
6. **Planeje** a semana: conteúdo, anúncios, contatos com colegas.

Uma vez por mês, acrescente um sétimo passo: leia os números por origem e anote o que mudou. Uma vez por trimestre, faça a conta da hipótese completa.

## Automações que valem a pena

- Resposta automática fora do horário com opções de agendamento.
- Sequência de confirmação (Parte 11) disparada pela agenda.
- Lembrete ao responsável quando um plano proposto passa de 2, 7 e 15 dias sem decisão.
- Mensagem de aniversário e lembrete de retorno periódico (revisão odontológica, manutenção de fisioterapia), só para quem consentiu.
- Pedido de avaliação no Google após a alta, para todos os pacientes, sem filtrar os satisfeitos.

PROMPT PRONTO

**Da conversa ao registro**

Vou colar a conversa de WhatsApp de um contato novo. Organize em: nome, origem (e o conteúdo ou o colega citado, se houver), porta de entrada (confiança, anúncio a partir de conteúdo, preço ou desconhecida), serviço de interesse, profissional indicado, etapa do funil (Novo contato, Em conversa, Agendado, Avaliado, Plano proposto, Em tratamento, Alta), próximo passo com data sugerida e um aprendizado. Não registre nenhuma informação clínica. Depois, escreva a próxima mensagem, em tom acolhedor, com até 400 caracteres.

Conversa: [COLE SEM DADOS CLÍNICOS]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Conversa de WhatsApp (fictícia): "Oi, vi seu vídeo sobre hidratação, vocês atendem corredor? Moro na Vila Madalena." / "Atendemos sim! Qual seu objetivo?" / "Quero me preparar para uma meia maratona em dezembro." / "Perfeito. Tenho terça 18h ou quinta 8h30." / "Vou ver minha agenda e te aviso."

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

REGISTRO
Nome: [perguntar]
Origem: Instagram orgânico (Reel de hidratação)
Serviço de interesse: consulta de nutrição esportiva
Profissional indicado: Dra. Bia Nunes
Etapa do funil: Em conversa
Próximo passo: retomar com um lembrete útil, em 2 dias
Aprendizado: o contato chegou por vídeo educativo e já disse o objetivo; dar dois horários ajudou a conversa avançar.

PRÓXIMA MENSAGEM (até 400 caracteres):
"Oi! Passando para lembrar que tenho terça às 18h ou quinta às 8h30, se quiser conversar sobre a preparação para a meia maratona. Se ainda não souber a agenda, sem problema: me avise quando puder, e eu reservo o horário por 24 horas."

### ANTES DE USAR

- Não registre dados clínicos.
- Cadastre o consentimento por finalidade no Rastreador.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** a planilha que só conta mensagens e a origem deixada em branco.
- **Reduzir:** os campos que ninguém usa, para que os importantes sejam preenchidos sempre.
- **Elevar:** o registro da origem e do próximo passo em cada linha.
- **Criar:** a conta trimestral da hipótese, que mostra qual porta de entrada traz os pacientes que ficam.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Liste de memória os dez últimos pacientes que pediram informação e não agendaram, e os cinco últimos planos propostos. Para quantos você sabe dizer o próximo passo? E a origem? Esses dois números são o seu ponto de partida.

NO CLINILOOP

**Rastreador, Painel e Playbook.**
Funil de sete etapas com próximos passos vencidos, painel semanal com o gargalo, comparecimento por origem no Rastreador e revisões quinzenais agendadas.

---

**Próxima passagem.** *Com a recompensa nas mãos, começa o caminho de volta. Para percorrê-lo toda semana sem esforço, você precisa conhecer bem as ferramentas da mochila.*

NO ROTEIRO · ETAPA 6 DE 6 · MEÇA E ESCALE COM CRM

*Na jornada · O caminho de volta*

# 14

# O app CliniLoop: guia das ferramentas

*O CliniLoop reúne este guia e dois módulos, Redes e CRM. Eles conduzem você pela mesma jornada, em três atos e nove passos, e levam a diferença que você definiu no Oceano Azul a cada perfil, conteúdo, conversa e campanha.*

---

NESTA PARTE · PARTE 14

O que o app faz por você · O caminho em nove passos · O módulo CRM · Hipótese, evidência e decisão · Tutorial: o primeiro uso · Do guia à ferramenta · Status do Rastreador · O que fica registrado · Privacidade · Clínicas com vários usuários

O caminho de volta é a parte da jornada em que o herói aprende a repetir sem o mentor por perto. As ferramentas do CliniLoop servem para isso: fazer, toda semana, o que o guia ensinou uma vez.

Esta parte é o manual de uso do app. Cada ferramenta nasceu de uma parte do guia: o guia explica o porquê, o app põe em prática. Por isso o CliniLoop reúne três partes: o guia *O Prompt do Sim*, o módulo Redes e posicionamento e o módulo CRM do consultório. O resultado vem do uso das três.

O app também resolve um problema que este guia aponta desde a Apresentação: a IA, sozinha, escreve o texto médio da internet. No CliniLoop, a proposta de valor, as quatro ações do Oceano Azul e o tom de voz que você guardou entram automaticamente no contexto de todos os prompts. A diferença que você definiu uma vez passa a orientar cada peça.

## O que o app faz por você

- **Leva o seu diferencial a todas as peças.** A proposta de valor do passo 3 e as decisões que você guarda (paciente ideal, Estratégia Oceano Azul, tom de voz, nicho) entram no contexto dos prompts de todos os passos seguintes.
- **Gera prompts prontos.** Cada ferramenta monta o pedido para a inteligência artificial com o perfil do seu consultório, o seu paciente ideal, o seu diferencial e as regras do seu conselho. Você copia, cola na sua IA preferida (Claude, ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek ou Meta AI) e recebe o texto.
- **Monta roteiros de conteúdo.** Reels, carrosséis, Stories, vídeos de YouTube e posts de LinkedIn, com ganchos, versão em blocos para o teleprompter e checklist antes de publicar.
- **Monta roteiros de campanha.** Plano de impulsionamento, textos, títulos, palavras-chave e públicos para Meta Ads e Google Ads.
- **Indica as ferramentas certas.** O kit de gravação, o editor de vídeo e o gerador de imagem que cabem no seu orçamento, e o pedido de imagem para a IA com os cuidados da sua profissão.
- **Escreve o atendimento.** Respostas rápidas do WhatsApp, roteiro de agendamento, confirmação, retomada e cartas aos colegas.

- **Revisa a ética.** O Verificador confere qualquer texto ou anúncio contra as regras do seu conselho, a LGPD e as políticas das plataformas.
- **Guarda o registro.** O CRM acompanha cada contato do primeiro "oi" ao fim do tratamento, cobra o próximo passo e mostra, no painel, onde o funil está travando.

## O caminho em nove passos

O app conta a mesma história deste guia: você é o herói, e o CliniLoop é o mentor. O caminho tem três atos e nove passos, em ordem, e um passo fica aberto de cada vez. Os passos 1 a 6 ficam no módulo **Redes e posicionamento**, que funciona no computador e no celular. Os passos 7 a 9 ficam no módulo **CRM do consultório**, pensado para o computador.

| Ato da jornada | Passo | O que você faz |
|---|---|---|
| **A partida · Defina a sua diferença** | 1 Seu consultório e objetivo | Profissão, registro, especialidade, cidade, serviços e o resultado dos próximos 90 dias. Formação e detalhes ficam em "Aprofundar" |
| | 2 Seu paciente ideal | Quem você mais ajuda e a dúvida principal dele. Se quiser, a IA monta o ICP e a persona |
| | 3 Oceano Azul: sua proposta de valor | As sete etapas da Estratégia Oceano Azul, uma de cada vez, até a proposta em uma frase e a sua aprovação |
| **As provas · Mostre onde o paciente procura** | 4 Seus perfis, uma rede por vez | Um cartão para cada rede, com um campo para cada parte do perfil e onde encontrá-la, o prompt daquela rede e o checklist |
| | 5 Plano de conteúdo e roteiros | Temas, pautas a partir das dúvidas reais e o roteiro da primeira peça |
| | 6 Colegas e campanhas | A rede de colegas que indicam e, quando fizer sentido, o primeiro anúncio |
| **O retorno · Meça quem fica** | 7 WhatsApp e atendimento | O checklist do WhatsApp Business, os links com origem e as respostas rápidas |

| Ato da jornada | Passo | O que você faz |
|---|---|---|
| | 8 Contatos: o rastreador | Cada contato com origem, próximo passo e data, nas filas de vencidos, de hoje e sem próximo passo |
| | 9 Ritual da semana | O placar, o gargalo da vez e a agenda da semana, toda semana |

## O mesmo padrão em todos os passos

1. **Você sai daqui com:** o que o passo entrega.
2. **Já aproveitado:** o que o app trouxe dos passos anteriores, para você não repetir.
3. **A ação:** os campos e os prompts do passo. Campos extras ficam em "Aprofundar"; a teoria e a etapa da jornada, em "Entender este passo".
4. **Entrega mínima:** a lista do que precisa existir para o passo ficar pronto, com o que já está feito marcado.
5. **Seguir:** o botão leva ao próximo passo. Seguir não é concluir: o que faltou continua marcado como pendente e aparece na tela Hoje.

Cada passo mostra um de poucos estados: **Em andamento**, **Pronto** ou **Precisa revisar**. Gerar um prompt é atividade, não entrega: o passo dos perfis só fica pronto com os textos aprovados e o checklist de uma rede completo, e o dos contatos, quando todo contato em aberto tem origem, próximo passo e data. O ritual da semana nunca fica "pronto para sempre": a cada semana ele volta como pendente.

## Hipótese, evidência e decisão

No Oceano Azul, o app separa três coisas que costumam se misturar:

- **Hipótese:** a proposta que você escreveu, antes de aprová-la.
- **Evidência:** o que os pacientes dizem e o que as avaliações mostram, na etapa 2. Sem ela, a curva de valor é a sua percepção, e o app diz isso na tela.
- **Decisão:** a proposta que você aprovou, depois de confirmar que ela diz o que muda para o paciente, não promete resultado e anuncia só o que já acontece ou está marcado como "vou implementar".

Você pode seguir com uma hipótese e ouvir os pacientes depois: o passo 3 continua em andamento, e os prompts avisam a IA de que ainda é hipótese. Se a proposta usar palavras que servem para qualquer colega, como “humanizado” ou “qualidade”, o app pede o que muda na prática.

## A sua diferença em todas as entregas

A proposta, as quatro ações, o que você já faz e o que ainda vai implantar entram no contexto de todos os prompts. No topo das ferramentas, uma faixa mostra qual diferença aquele prompt vai usar e se ela é hipótese ou decisão. O que ainda não acontece no seu atendimento entra como [AINDA NÃO IMPLANTADO], nunca como fato.

Quando você muda a proposta ou as quatro ações, ela volta para “Precisa revisar”, e as entregas aprovadas com a versão anterior (os textos dos perfis, as pautas, as respostas do atendimento) ficam marcadas para revisão na tela Hoje. As versões anteriores ficam guardadas.

## Do prompt à versão aprovada

Todo prompt mostra o mesmo ciclo: **copie**, **abra a sua IA** e cole, **volte** ao app e revise a resposta, e **guarde a versão aprovada**. O botão “Abrir no…” copia o prompt antes de abrir a IA; o texto nunca vai pelo endereço da página. Se a cópia falhar, o app seleciona o texto e avisa. Em “Guardar a versão aprovada”, o que você digita fica como rascunho até você clicar em **Aprovar e guardar**: só a versão aprovada entra nos próximos prompts.

## O menu: Hoje, Redes, CRM, Guia e Ferramentas

O app mostra uma tela de cada vez.

- **Hoje:** as três partes do CliniLoop, com a situação de cada uma; a sua diferença atual e o estado dela; o próximo passo e o que ficou pendente; as filas de contatos; a semana e o ritual.
- **Redes:** os passos 1 a 6, do consultório e do Oceano Azul aos perfis, ao conteúdo, aos colegas e às campanhas.
- **CRM:** o quadro de contatos, o procedimento da recepção e os passos 7 a 9.
- **Guia:** este guia dentro do app, com o roteiro em seis etapas, o plano de 30 dias, a biblioteca de prompts, o glossário e a ajuda.

- **Ferramentas:** todas as ferramentas, em sete grupos por objetivo e com busca, mais o Verificador ético e as Configurações. Cada ferramenta diz para que serve, o que recebe, o que entrega e o que vem depois, e abre onde mora.

### O módulo CRM: quadro, procedimento e modo recepção

- **Quadro de contatos:** uma coluna para cada etapa, de Novo a Encerrado. No computador, você arrasta o cartão para a etapa seguinte; no celular e no teclado, usa as setas do próprio cartão. Cada mudança registra a data e sugere o próximo passo daquela etapa. Cartões vencidos, para hoje e sem próximo passo ficam marcados, e os filtros do topo mostram só essas filas. Para encerrar, o app pede o resultado (alta e vínculo, perdido ou pausado) e o motivo, sem dado clínico.
- **Novo contato:** o cadastro rápido pede nome, origem e próximo passo. A origem nunca vem escolhida: se não souber, escolha "Não sei". Os consentimentos começam todos desmarcados, porque cadastrar alguém não é consentimento.
- **Procedimento da recepção:** para cada etapa, quando agir, o que fazer e uma mensagem modelo, com as regras que valem sempre (nenhum dado clínico, dúvida clínica é do profissional, consentimento só com aceite, nada de prometer resultado). Ele mostra também como a sua diferença aparece no atendimento e as respostas que você aprovou no passo 7. Dá para imprimir e deixar no balcão.
- **Modo recepção:** o app abre direto no CRM e recolhe o resto, para quem atende no computador do consultório. Ele vale só naquele navegador e não é senha: os dados continuam acessíveis a quem usa o mesmo computador.

## Tutorial: o primeiro uso, passo a passo

Siga o tutorial uma única vez. Depois, a tela Hoje e o ritual da semana conduzem o dia a dia. As imagens mostram o app preenchido com a Dra. Bia Nunes, a personagem fictícia dos exemplos deste guia.

### 1. Abra o app

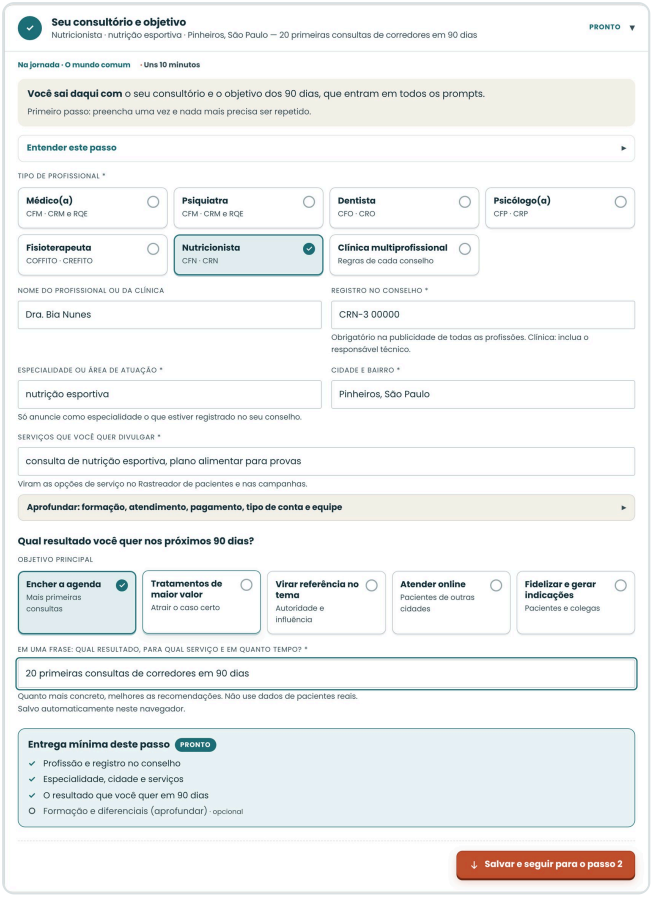
Abra o CliniLoop pelo link que você recebeu na compra, no navegador do computador ou do celular. No topo, você vê as três partes do CliniLoop: o Guia, o módulo Redes e o módulo CRM. Clique em **Construir minha diferenciação**: o app abre o módulo Redes no passo 1.




O topo do app: a proposta do produto e as três partes do CliniLoop

## 2. Passo 1: seu consultório e objetivo

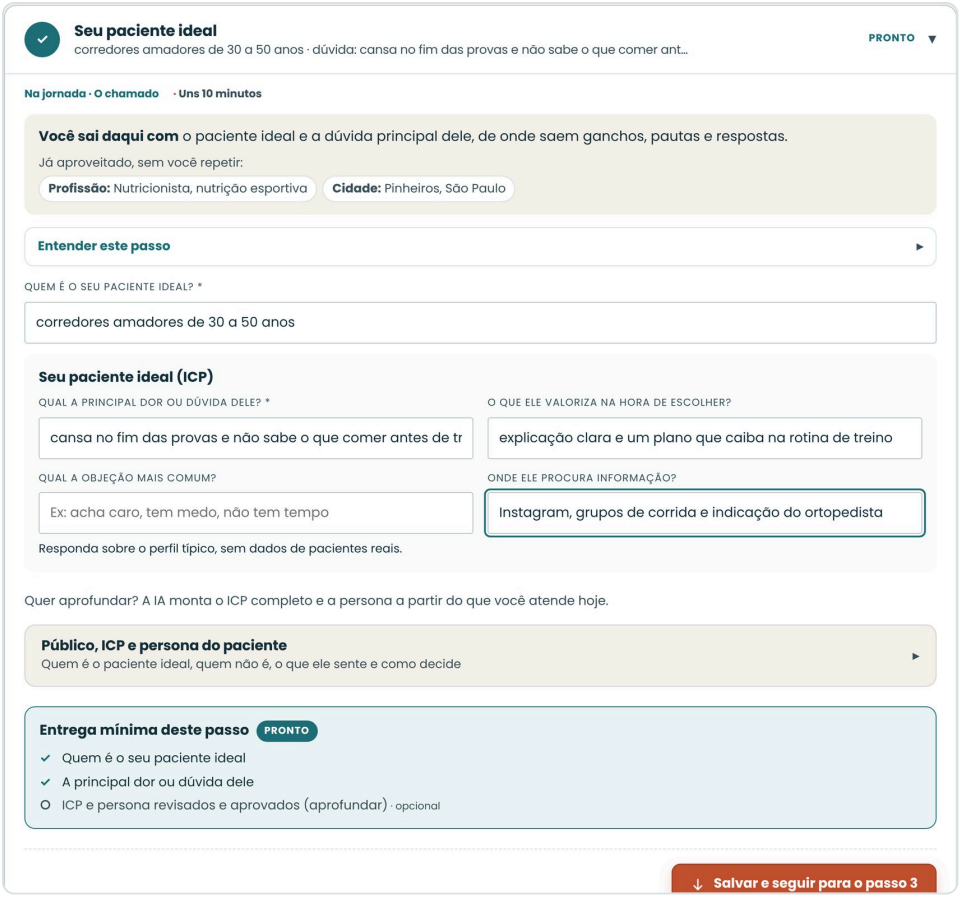
Escolha o tipo de profissional: é essa escolha que carrega as regras do seu conselho em todos os prompts. Preencha registro, especialidade, cidade e bairro e os serviços. No fim do passo, escolha o objetivo dos próximos 90 dias e escreva o resultado numa frase, como “20 primeiras consultas de corredores em 90 dias”. A formação e os detalhes de atendimento ficam em **Aprofundar**. Clique em **Salvar e seguir para o passo 2**.




Passo 1: o tipo de profissional, os dados do consultório e o objetivo

## 3. Passo 2: seu paciente ideal

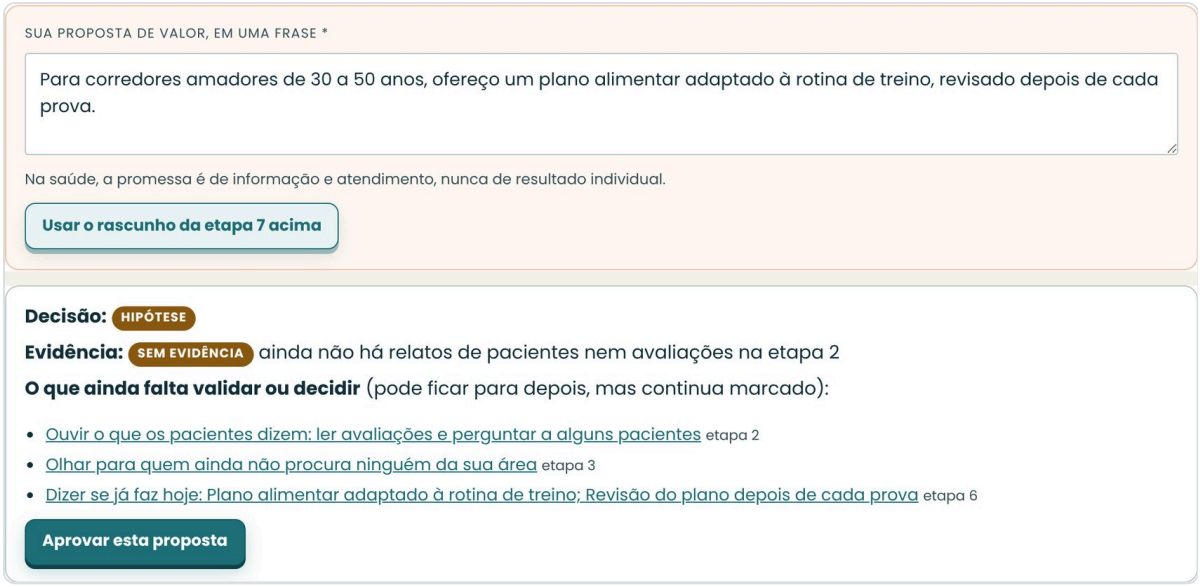
Descreva o paciente que você mais ajuda e a principal dor ou dúvida dele. Os outros campos deixam os prompts mais precisos. Para aprofundar, abra **Público, ICP e persona do paciente**, logo abaixo.




Passo 2: o paciente ideal, com o que já foi aproveitado do passo 1

## 4. Passo 3: Oceano Azul

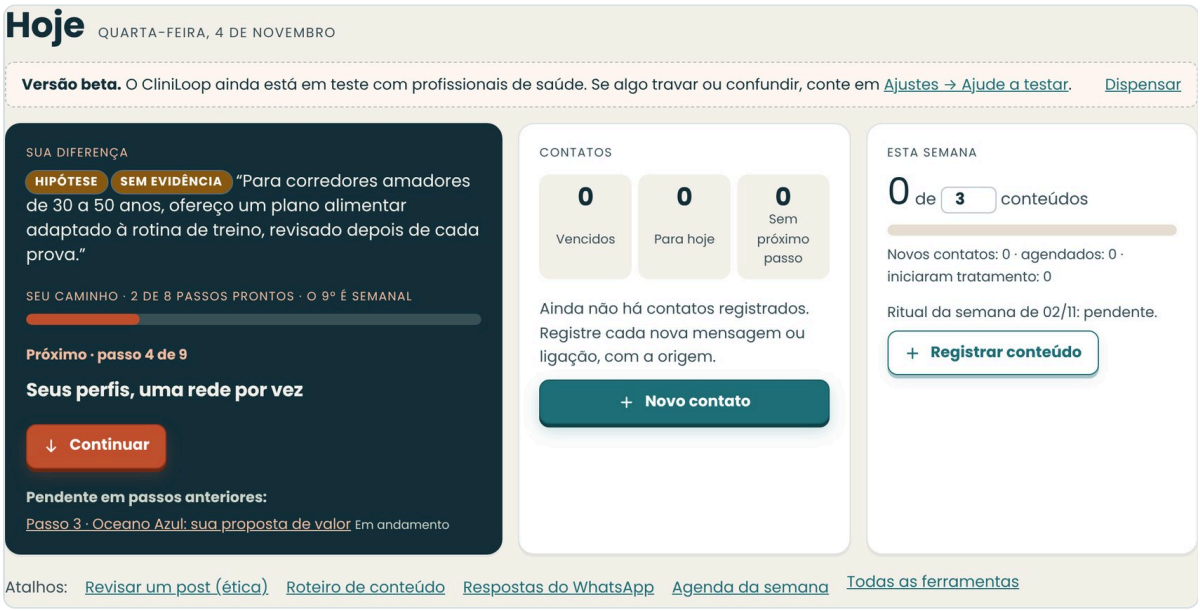
Faça as sete etapas, uma de cada vez. As etapas 2 e 3, de evidência, podem ficar para depois: elas continuam marcadas como pendentes. Na etapa 7, escreva a proposta em uma frase ou use o rascunho. Leia o quadro de decisão e evidência e, quando estiver de acordo, clique em **Aprovar esta proposta** e confirme os três itens.




Passo 3: a proposta, com a decisão, a evidência e o que falta validar

## 5. Veja a tela Hoje

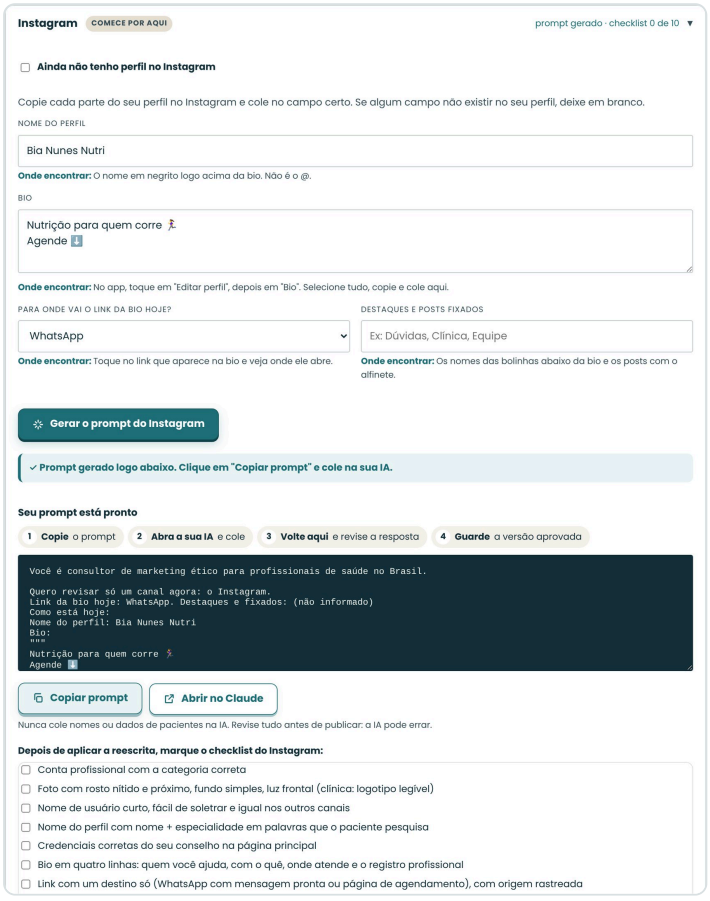
A tela Hoje mostra a sua diferença e o estado dela, o próximo passo e o que ficou pendente. Os passos se fecham com um resumo; para corrigir algo, clique no passo e edite ali mesmo.




A tela Hoje: a sua diferença, o próximo passo, os contatos e a semana

## 6. Passo 4: uma rede por vez

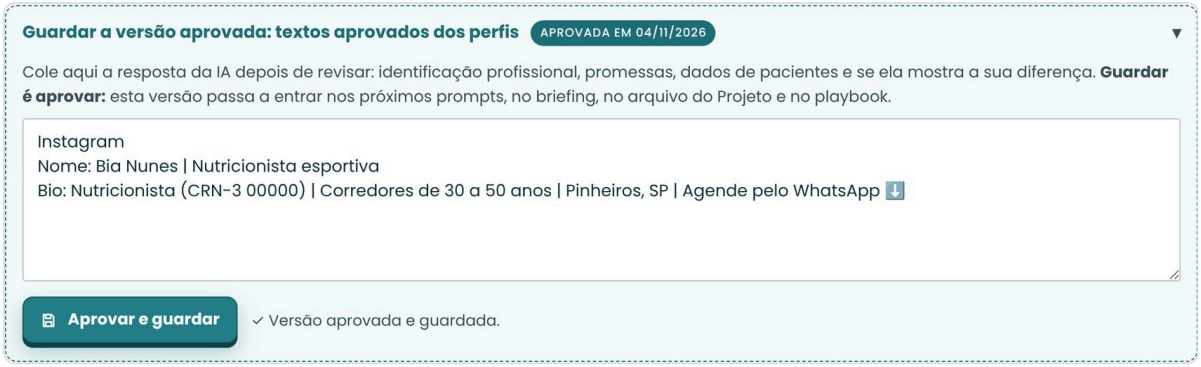
Marque as redes que você já usa. Abra uma delas e cole cada parte do perfil no campo certo: no Instagram, o nome do perfil num campo e a bio em outro; no Google, o nome da ficha, a categoria, a descrição e as avaliações. Embaixo de cada campo, o app diz onde encontrar a informação. Se você ainda não tem o perfil, marque **Ainda não tenho**, e o prompt cria do zero. A faixa no topo mostra qual diferença o prompt vai usar. Clique em **Gerar o prompt do** Instagram, do Google ou da rede aberta e siga o ciclo: copiar, abrir a IA, voltar e revisar.




Passo 4: o cartão do Instagram, com o ciclo do prompt

## 7. Aprove e guarde a versão final

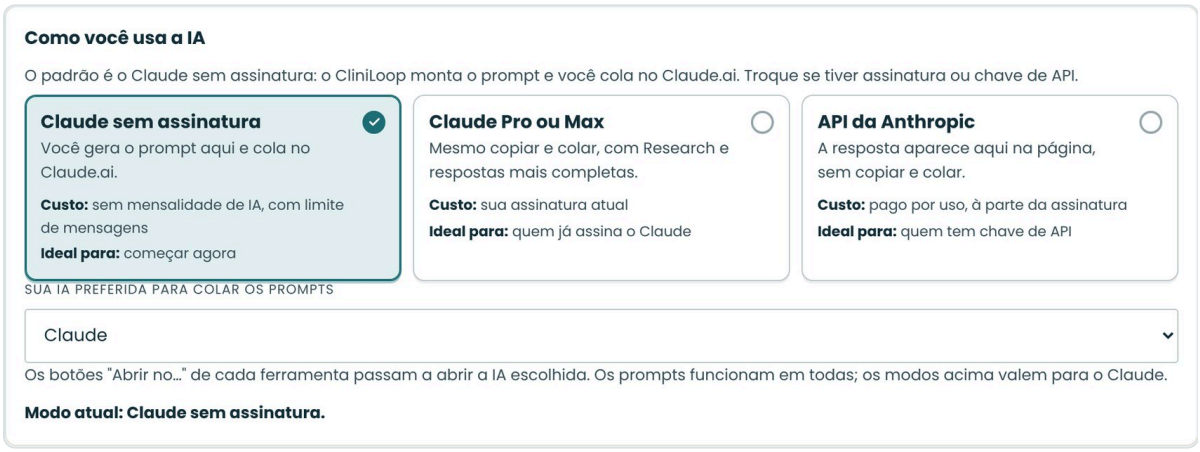
Quando gostar da resposta da IA, revise identificação, promessas e dados, cole o texto em **Guardar a versão aprovada** e clique em **Aprovar e guardar**. A versão aprovada entra nos próximos prompts, no briefing, no arquivo do Projeto e no playbook.




A versão aprovada, guardada no passo

## 8. Escolha a sua IA

No menu **Ferramentas**, abra **Configurações**. Em "Como você usa a IA", escolha a IA em que vai colar os prompts. Se usa o Claude, indique também o modo: sem assinatura, Pro ou Max, ou API.




Ajustes: o modo de uso do Claude e a IA preferida

## 9. No CRM, registre o primeiro contato

No menu, abra **CRM** e clique em **Novo contato**. No cadastro rápido, registre nome ou apelido, de onde a pessoa veio e o próximo passo com data. Em **Mais detalhes** ficam o contato, o serviço, a etapa e o consentimento que a pessoa deu. Nenhum dado clínico entra aqui: diagnóstico, exames e evolução ficam no prontuário.




O cadastro rápido de um contato

## 10. Mova os cartões no quadro

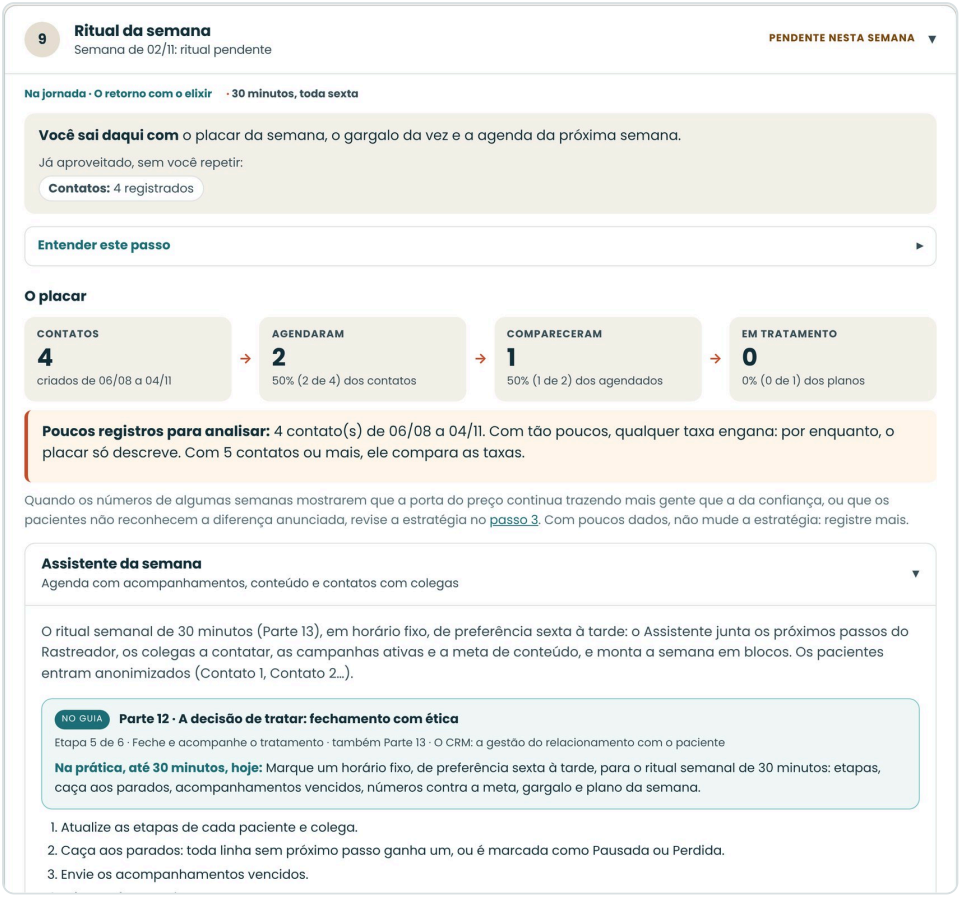
No quadro, arraste o cartão para a etapa seguinte ou use as setas. O app registra a data e sugere o próximo passo. Abra o **Procedimento da recepção** para ver o que fazer em cada etapa e imprima uma cópia para quem atende. Se a recepção usa o mesmo computador, ligue o **Modo recepção**.




O quadro de contatos, com uma coluna por etapa

## 11. Passo 9: faça o ritual da semana

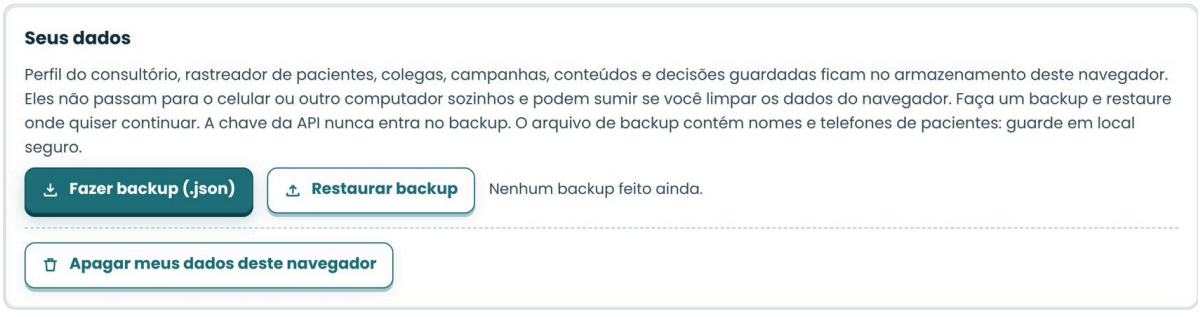
Toda semana, em 30 minutos, abra o passo 9, no fim do módulo CRM. O placar mostra contatos, agendamentos, comparecimentos e tratamentos dos últimos 90 dias, com o período e os números de cada taxa. Com poucos registros, ele só descreve. Monte a semana no **Assistente da semana** e clique em **Fiz o ritual desta semana**.




O ritual da semana: o placar e o Assistente

## 12. Faça o backup

Os dados ficam só neste navegador. No menu **Ferramentas**, em **Configurações**, clique em **Fazer backup (.json)**: o app confere o arquivo antes de baixá-lo e diz quantos registros ele traz. Para usar em outro aparelho, clique em **Restaurar backup**. Se a restauração falhar no meio, o app desfaz tudo e mantém os dados atuais.




Seus dados: backup e restauração

# Do guia à ferramenta

| Ferramenta CliniLoop | O que faz | No app | Parte do guia |
|---|---|---|---|
| **Seu consultório e objetivo** | Escolhe o tipo de profissional (médico, psiquiatra, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista ou clínica multiprofissional), carrega as regras do conselho certo e define o objetivo dos 90 dias | Passo 1 | 1 e 2 |
| **Público, ICP e persona** | Descreve quem você atende e gera o perfil do paciente ideal | Passo 2 | 3 |
| **Persona do profissional** | Registra sua história, seus valores e o seu tom de voz | Caixa de ferramentas | 3 e 4 |
| **Nicho e diferencial** | Analisa nicho e concorrência e gera a proposta de valor | Caixa de ferramentas | Apresentação e 3 |
| **Estratégia Oceano Azul** | Guia em sete passos: onde a sua área compete, o que os pacientes dizem, quem ainda não procura ninguém, as quatro ações, a curva de valor, o que você já faz e como mostrar, e a proposta. O prompt diz se o resultado é um espaço novo ou uma diferença no mercado existente e monta um plano de 12 semanas de conteúdo. As escolhas guardadas orientam as demais ferramentas | Passo 3 | Apresentação, 3, 4 e todas as partes |
| **Perfis e presença** | Um cartão por rede (Google, Instagram, LinkedIn, YouTube e TikTok), com o prompt daquela rede e o checklist de configuração, e a opção de um prompt com todas | Passo 4 | 3 |

| Ferramenta CliniLoop | O que faz | No app | Parte do guia |
|---|---|---|---|
| **Pautas e palavras-chave** | Banco de dúvidas reais, palavras-chave por serviço e cidade, pautas e calendário | Passo 5 | 4 |
| **Roteiros e copy** | Reels, carrosséis, Stories, vídeos de YouTube e posts de LinkedIn, com cinco ganchos e versão em blocos para o teleprompter | Passo 5 | 4 e 6 |
| **Reaproveitamento de conteúdo** | Transforma aula, podcast ou entrevista em carrossel, guia, Reel e Stories, com registro de ideias, autoria e pendências | Caixa de ferramentas | 5 |
| **Formação e autoridade** | Congressos, cursos, publicações e títulos para o perfil e o LinkedIn | Caixa de ferramentas | 3 |
| **Gerador de campanhas** | Meta Ads, Google Ads e plano de impulsionamento, com criativos, textos, palavras-chave e público | Passo 6 | 9 e 15 |
| **Rede de colegas** | Funil de colegas, carta de apresentação, relatório de contrarreferência, agradecimentos | Passo 6 | 8 |
| **Atendimento e agendamento** | Respostas rápidas do WhatsApp, roteiro de agendamento, retomadas | Passo 7 | 10 |
| **Rastreador e quadro de contatos** | Funil de sete etapas, filas de vencidos, de hoje e sem próximo passo,, próximos passos vencidos em destaque, lembretes (.ics), exportação (.csv) | Passo 8 | 11, 12 e 13 |
| **Assistente da semana** | Monta a agenda da semana com acompanhamentos, conteúdo e contatos com colegas | Passo 9 | 13 |

| Ferramenta CliniLoop | O que faz | No app | Parte do guia |
|---|---|---|---|
| Painel e diagnóstico | Métricas da Parte 13 e o gargalo da semana | Passo 9 | 13 |
| Verificador ético | Revisa qualquer texto ou anúncio contra as regras do conselho escolhido e as políticas da Meta e do Google | Caixa de ferramentas | 2 e 15 |
| Ferramentas recomendadas | Kit de gravação, editores de vídeo, geradores de imagem e o pedido de imagem para a IA com as regras do conselho | Caixa de ferramentas | 6, 7 e 16 |
| Briefing para terceiros | Monta o briefing para agência, social media ou editor de vídeo | Caixa de ferramentas | 16 |
| Playbook da clínica | Reúne tudo em um documento e agenda revisões quinzenais | Caixa de ferramentas | 13 |

## Status do Rastreador de pacientes

| Etapa no guia | Status no app |
|---|---|
| 1 Novo contato | Novo |
| 2 Em conversa | Em conversa |
| 3 Agendado | Agendado |
| 4 Avaliado | Avaliado |
| 5 Plano proposto | Plano proposto |
| 6 Em tratamento | Em tratamento |

| Etapa no guia | Status no app |
|---|---|
| 7 Alta e vínculo, Perdido, Pausado | Encerrado (com resultado e motivo) |

## O que fica registrado

- **Contato ou paciente:** nome, telefone, canal preferido, consentimento (data e finalidade), origem, serviço, profissional, etapa, próximo passo, data, valor do plano, motivo de perda, colega que indicou.
- **Colega:** nome, profissão, especialidade, registro, endereço, canal, etapa no funil de colegas, indicações recebidas e enviadas, última contrarreferência.
- **Campanha:** plataforma, tipo (impulsionamento ou campanha), objetivo, período, investimento, criativos, contatos gerados, agendados, comparecimentos, planos iniciados.
- **Conteúdo:** data, canal, formato, tema, gancho, palavra-chave, alcance, envios, salvamentos, mensagens geradas.

## Privacidade e dados

1. **Nenhum dado clínico no CRM.** Os campos livres trazem um aviso, e os prompts geram texto sem dados identificáveis.
2. **Consentimento por finalidade** (atendimento, lembretes, conteúdo), com opção de saída.
3. **Regras do conselho embutidas** em todos os geradores, conforme o tipo de profissional escolhido.
4. **Os dados ficam no seu navegador.** O app não guarda os seus registros em servidor. Por isso, faça o backup periodicamente: o app tem um botão para exportar e outro para importar.
5. **Instalação.** Pelo menu do navegador, é possível instalar o CliniLoop como aplicativo no computador ou no celular, e ele funciona mesmo sem conexão. Os prompts continuam exigindo a ferramenta de IA.

# Clínicas com vários usuários

O CliniLoop foi pensado para o profissional que trabalha sozinho: os dados ficam no navegador de quem usa e não são compartilhados. Por isso, ele não funciona para clínicas em que recepção, coordenação e vários profissionais precisam acessar os mesmos registros. Caso queira uma solução para multiusuários, envie um e-mail para atendimento@loopuniversity.com.br.

ATENÇÃO

**Integrações futuras.**
WhatsApp Business, agenda (Google ou Outlook) e importação de conversões offline para Meta e Google estão previstas, mas ainda não existem. Hoje, o Rastreador exporta planilha e gera lembretes que você abre no seu calendário.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** prompts genéricos digitados do zero, sem o contexto do seu consultório.
- **Reduzir:** o tempo gasto repetindo as mesmas informações a cada pedido.
- **Elevar:** a proposta de valor e as decisões guardadas, que passam a orientar todas as ferramentas.
- **Criar:** o hábito de guardar a versão final de cada ferramenta de posicionamento, para que a diferença se acumule.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Faça os três primeiros passos do caminho, uma única vez: o consultório e o objetivo, o paciente ideal e a Estratégia Oceano Azul, com a proposta de valor em uma frase. Os três alimentam todas as ferramentas.

NO CLINILOOP

**O caminho.**
Abra o app e clique em **Continuar**: ele abre o módulo e o passo em que você parou. A tela Hoje mostra a sua diferença, o que ficou pendente e o que precisa de revisão.

---

**Próxima passagem.** *As ferramentas estão à mão. A próxima parte mostra como juntá-las numa campanha completa, que leva tudo o que você aprendeu a mais gente de uma só vez.*

NO ROTEIRO · ETAPA 6 DE 6 · MEÇA E ESCALE COM CRM

*Na jornada · A última prova*

# 15

# Gerador de campanhas e biblioteca de prompts

*Uma campanha completa cabe em uma página: objetivo, público, diferencial, mensagem, peças, canal, orçamento, atendimento e medição.*

NESTA PARTE · PARTE 15

A ficha da campanha · Quatro modelos · Biblioteca de prompts · Verificador ético

Perto do fim de muitas histórias, o herói enfrenta uma última prova, maior que as anteriores, e só a vence porque usa tudo o que aprendeu no caminho. A campanha é essa prova: conteúdo, colegas, anúncio, atendimento e medição trabalhando juntos, com o seu diferencial no centro.

O gerador abaixo produz essa página com IA, e o Verificador ético revisa antes de publicar. Uma campanha deste guia não é um pacote de anúncios genéricos: ela parte do seu diferencial e usa, como peças, o conteúdo que você já produziu e que já provou funcionar.

## A ficha da campanha

| Campo | Pergunta |
|---|---|
| **Objetivo** | Quantos novos pacientes agendados, para qual serviço, em quanto tempo? |
| **Público** | Quem é o paciente, onde mora, qual a dúvida principal? |
| **Diferencial** | O que, nesta campanha, só você pode mostrar? Qual das quatro ações ela evidencia? |
| **Mensagem central** | Qual informação útil abre a conversa? |
| **Peças** | Quais Reels, carrosséis, Stories, anúncios e páginas? Quais já existem no orgânico? |
| **Canais** | Orgânico, Meta Ads, Google Ads, YouTube, colegas? |
| **Orçamento e duração** | Quanto por dia, por quantos dias, sem mexer? |
| **Atendimento** | Quem responde, com qual roteiro, em quanto tempo? |

| Campo | Pergunta |
|---|---|
| **Medição** | Contatos, agendados, comparecimentos e planos iniciados por origem |
| **Compliance** | Conselho, LGPD, políticas da plataforma conferidos? |

PROMPT PRONTO

**Gerador de campanha completa**

Atue como estrategista de marketing ético para saúde no Brasil. Monte uma campanha de [DURAÇÃO] para [PROFISSÃO/CLÍNICA] em [BAIRRO, CIDADE], serviço [SERVIÇO], objetivo [N] pacientes agendados, orçamento [R$/DIA]. Meu diferencial: [SUA PROPOSTA DE VALOR]. Conteúdos meus que já funcionaram no orgânico: [LISTE].

Entregue:

1. Ficha da campanha (objetivo, público, diferencial, mensagem central, canais, medição por origem).

2. 3 roteiros de Reel (gancho, contexto, 3 a 5 pontos, CTA, legenda), aproveitando os conteúdos que já funcionaram.

3. 1 carrossel de 7 slides.

4. Anúncios Meta (3 textos, 3 títulos) e Google (15 títulos, 4 descrições, 20 palavras-chave, 15 negativas).

5. Mensagem de boas-vindas do WhatsApp e 3 respostas rápidas.

6. Calendário dia a dia.

7. Lista de verificação ética do [CONSELHO], da LGPD e das políticas da Meta e do Google, marcando o que precisa de atenção.

Regras: sem promessa de resultado, sem superlativos, sem medo, sem afirmar condição de saúde do usuário, sem preço onde o conselho proíbe. Marque com [CONFIRMAR] tudo que eu não informei.

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Duração: 14 dias. Serviço: consulta de nutrição esportiva. Objetivo: 8 pacientes agendados. Orçamento: R$ 30 por dia.

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

1. FICHA
Objetivo: 8 consultas agendadas em 14 dias. Público: corredores de 30 a 50 anos num raio de 5 km de Pinheiros. Mensagem central: "Organize a alimentação para correr com mais tranquilidade." Canais: Reels, WhatsApp, Meta (mensagens). Medição: mensagens, conversas, agendamentos, comparecimento, por origem.

2. REELS (títulos): "O que comer na véspera" | "Gel: precisa?" | "Café da manhã antes do treino longo"
3. CARROSSEL (7 slides): capa, problema, 3 erros comuns, o que costuma ajudar, quando procurar profissional, convite.
4. ANÚNCIOS: ver exemplo do anúncio.
5. WHATSAPP: boas-vindas e 3 respostas rápidas (ver exemplo de respostas rápidas).
6. CALENDÁRIO (trecho): dia 1 Reel 1 | dia 3 carrossel | dia 5 Reel 2 e início do impulsionamento | dia 7 leitura dos números | dia 10 Reel 3 | dia 14 balanço.
7. CHECAGEM [CONFIRMAR]: CFN não permite promoção nem sorteio como publicidade; sem imagem corporal; sem marcas; LGPD: consentimento no primeiro contato; políticas de saúde da Meta.

[CONFIRMAR] orçamento total (R$ 420), prazo de resposta que você consegue cumprir, horários disponíveis.

### ANTES DE USAR

- Só rode campanha com atendimento e registro funcionando.
- A meta de 8 consultas é um exemplo: use a sua linha de base.

# Quatro modelos de campanha

| Campanha | Para quem | Mensagem central | Canais |
|---|---|---|---|
| **Avaliação de dor lombar** | Fisioterapia | "Dor nas costas tem causas tratáveis. Entenda como é a avaliação" | Reels + Meta Ads para WhatsApp + Google Pesquisa |
| **Como funciona o implante** | Odontologia | "Cada etapa do implante, explicada" (sem preço) | Carrossel + YouTube + Google Pesquisa |
| **Terapia online** | Psicologia | "Como é uma primeira sessão de terapia online" | Reels + Google Pesquisa ("psicólogo online") |
| **Reativação** | Todas | Lembrete de retorno periódico para quem consentiu | WhatsApp a partir do CRM |

ATENÇÃO

**Datas de conscientização.**
Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul e outras são boas para autoridade, desde que educativas. Em Setembro Amarelo, siga as recomendações de comunicação responsável sobre suicídio, informe o CVV (188) e não use o tema para captar pacientes.

# Biblioteca de prompts deste guia

| Etapa | Prompt | Parte |
|---|---|---|
| Posicionamento | Auditoria de perfis e canais | 3 |
| Conteúdo | Roteiro de Reel ético | 4 |
| Reaproveitamento | Do episódio ao conjunto de peças | 5 |
| Vídeo | Roteiro para teleprompter e plano de gravação | 6 |
| Vídeo | Plano de edição a partir da transcrição | 7 |
| Colegas | Carta de apresentação a colegas | 8 |
| Colegas | Relatório de contrarreferência | 8 |
| Tráfego | Anúncio Meta e Google | 9 |
| Tráfego | Plano de impulsionamento | 9 |
| Agendamento | Respostas rápidas | 10 |
| Fechamento | Plano de tratamento compreensível | 12 |
| CRM | Da conversa ao registro | 13 |
| Campanha | Gerador de campanha completa | 15 |
| Revisão | Verificador ético | 15 |

PROMPT PRONTO

**Verificador ético**

Revise o texto abaixo como se fosse a comissão de ética do [CONSELHO]. Aponte, frase a frase: promessa de resultado, superlativo, sensacionalismo, medo, exposição de paciente, preço ou promoção vedados, falta de identificação profissional, afirmação sobre condição de saúde do leitor.

Aponte também, em uma linha, se o texto poderia ser publicado por qualquer colega da mesma especialidade sem mudar nada.

Proponha uma versão corrigida que mostre a diferença com fatos, sem adjetivos. Lembre que esta revisão não substitui a consulta à norma vigente.

Texto: [COLE AQUI]

EXEMPLO PREENCHIDO · PERSONAGEM FICTÍCIA

### O QUE FOI COLOCADO

Texto: "Perca 10 kg em 30 dias com o meu protocolo! Resultado garantido, veja o antes e depois das minhas pacientes. Só esta semana, 30% de desconto na consulta."

### O QUE A IA DEVOLVEU (TRECHO)

FRASE A FRASE
1. "Perca 10 kg em 30 dias": promessa de resultado e meta de peso; o CFN restringe.
2. "com o meu protocolo": sugere método exclusivo, sem comprovação.
3. "Resultado garantido": promessa de resultado.
4. "veja o antes e depois das minhas pacientes": exposição de pacientes e imagem corporal atribuindo resultado.
5. "Só esta semana, 30% de desconto": promoção, vedada como publicidade pelas normas aplicáveis.
6. Falta identificação: nome, CRN e especialidade.

VERSÃO CORRIGIDA
"Quer organizar a sua alimentação com acompanhamento? Na consulta de nutrição, avaliamos a sua rotina e montamos um plano por escrito. O resultado é diferente para cada pessoa. Bia Nunes, nutricionista, CRN-3 00000. Agende pelo WhatsApp."

Esta revisão não substitui a consulta à norma vigente.

### ANTES DE USAR

- Confirme a regra mais atual no site do seu conselho.
- Quando houver dúvida, pergunte ao conselho ou a um advogado.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** campanhas montadas só com peças novas e genéricas, sem relação com o que você já publica.
- **Reduzir:** o número de mensagens por campanha: uma ideia central basta.
- **Elevar:** o diferencial no centro da ficha e a medição por origem até o tratamento iniciado.
- **Criar:** campanhas que reaproveitam o seu melhor conteúdo orgânico e que um colega não conseguiria copiar.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Preencha a ficha de uma campanha para o seu serviço principal, começando pelo campo Diferencial, e rode o gerador. Passe tudo pelo verificador ético antes de publicar.

NO CLINILOOP

**Gerador de campanhas e Verificador ético.**
A ficha da campanha vira um formulário; o resultado passa pelo verificador antes de ir para o ar.

---

**Próxima passagem.** *A campanha está desenhada. Falta escolher as ferramentas que a tornam real e preparar o retorno, quando outras pessoas passarão a ajudar você na jornada.*

NO ROTEIRO · ETAPA 6 DE 6 · MEÇA E ESCALE COM CRM

*Na jornada · O retorno com o elixir*

# 16

# Ferramentas para materializar as campanhas

*Comece com o mínimo: celular, Canva, WhatsApp Business, Meta Business Suite e o CliniLoop. As demais entram quando o volume pedir. As ferramentas são as mesmas para todos; a diferença está no que você coloca nelas.*

---

NESTA PARTE · PARTE 16

Mapa de ferramentas por necessidade · Delegar sem perder a diferença

O herói volta para casa trazendo algo que serve a outros: o elixir. Aqui, o elixir é o método que você agora domina e que pode passar a uma secretária, a um editor ou a uma agência sem perder a sua diferença no caminho.

As ferramentas abaixo foram listadas, não avaliadas: confira planos, preços e adequação à LGPD antes de contratar.

Nenhuma delas diferencia você. O seu concorrente usa o mesmo Canva, o mesmo CapCut e a mesma IA. Use os modelos prontos como ponto de partida e troque sempre cores, fontes, exemplos e textos pelos seus, com a identidade definida na Parte 3.

## Mapa de ferramentas por necessidade

| Necessidade | Ferramentas | Observação |
|---|---|---|
| **Criar peças** | Canva, Adobe Express | Modelos de carrossel e capas com a identidade da clínica |
| **Gravar vídeo** | Celular, tripé, ring light ou painel de LED, microfone de lapela | Primeiro som, depois luz, por último câmera (Parte 6) |
| **Falar sem decorar** | BIGVU, PromptSmart, Teleprompter.com | Teleprompter no celular, com rolagem pela voz em alguns (Parte 6) |
| **Editar vídeo** | Editores nativos das redes, Edits (Meta), CapCut, Canva, InShot, Descript | Comece pelo nativo; revise as legendas automáticas (Parte 7 e Anexo A) |
| **Gerar imagens com IA** | ChatGPT, Gemini, Meta AI, Canva, Adobe Firefly | Ilustração, nunca paciente ou resultado; revise a anatomia (Anexo A) |
| **Avatar e voz com IA** | HeyGen, Synthesia | Só a sua imagem e voz, com aviso de IA (Parte 7) |

| Necessidade | Ferramentas | Observação |
|---|---|---|
| Agendar e medir posts | Meta Business Suite, Metricool, mLabs | Calendário e relatórios de Instagram e YouTube |
| Reaproveitamento | Transcrição do app de gravação ou do YouTube, Claude | Da aula ou do podcast às peças; nunca transcreva consultas |
| Comentário que leva ao guia | Manychat | Exige configuração e teste; respeite as regras do conselho |
| Ideias e palavras-chave | Google Trends, Answer The Public, Planejador de palavras-chave do Google Ads | Pautas a partir do que o paciente pesquisa |
| Vídeos curtos fora do Instagram | TikTok, TikTok Studio | Opcional; publique sem marca d'água de outra rede; anúncios pelo Promote ou TikTok Ads Manager (Anexo A) |
| Impulsionamento | Botão Turbinar no Instagram, Meta Business Suite | O primeiro anúncio de quem nunca anunciou (Parte 9) |
| YouTube | YouTube Studio, TubeBuddy ou vidIQ | Títulos, capítulos e análise de retenção |
| Anúncios | Gerenciador de Anúncios da Meta, Google Ads | Pixel, API de Conversões, tag do Google |
| Medição do site | Google Analytics 4, Google Tag Manager | Conversões de WhatsApp, ligação e formulário |
| Presença local | Perfil da Empresa no Google, Doctoralia | Avaliações e agendamento online |
| Atendimento | WhatsApp Business (app ou API oficial) | Respostas rápidas, etiquetas, catálogo de serviços |

| Necessidade | Ferramentas | Observação |
|---|---|---|
| CRM comercial | CliniLoop, RD Station CRM, Kommo, Pipedrive, HubSpot | Funil, próximos passos, automações |
| Agenda e prontuário | iClinic, Feegow, Amplimed, Simples Dental, Clinicorp | Agenda, confirmação e prontuário eletrônico (fora do CRM) |
| Assistentes de IA | Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot | Use com as quatro regras; nunca com dados de pacientes |

O passo a passo das principais ferramentas de criação, edição, publicação e anúncios está no **Anexo A**.

## Delegar sem perder a diferença

Com o tempo, parte do trabalho pode passar para uma secretária, um social media, um editor de vídeo ou uma agência. É nesse momento que muitos perfis voltam a ficar genéricos: quem recebe a tarefa não conhece o seu diferencial e preenche o vazio com modelos.

Antes de delegar, entregue um briefing por escrito com:

- a proposta de valor e as quatro ações do Oceano Azul;
- o tom de voz: expressões que você usa e as que evita;
- os temas de conteúdo e as dúvidas reais do consultório;
- as regras do seu conselho e o que nunca pode ser publicado;
- quem aprova cada peça antes de ir ao ar e em quanto tempo;
- o que será medido: origem, agendamentos e comparecimentos, e não só alcance.

Você pode delegar a produção. Não delegue a revisão clínica e ética, nem a decisão sobre o que é o seu diferencial.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** ferramentas duplicadas que espalham o registro em vários lugares.
- **Reduzir:** o uso de modelos prontos sem personalização.
- **Elevar:** a identidade visual e a voz aplicadas a todas as peças, por quem quer que as produza.
- **Criar:** um briefing do seu diferencial para entregar a qualquer pessoa ou empresa que trabalhe para você.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Escolha uma ferramenta por linha, no máximo. Ferramenta demais é registro duplicado, e registro duplicado é paciente esquecido.

NO CLINILOOP

**Exportação, lembretes e Briefing para terceiros.**
O Rastreador exporta em planilha (.csv) e gera lembretes para Google Agenda ou Outlook, para conversar com as ferramentas que você já usa. O Briefing para terceiros monta o documento para agência, social media ou editor a partir do seu perfil e das decisões guardadas.

---

**O fim que é começo.** *A jornada termina onde começou: no consultório, numa segunda-feira comum. Só que agora você sabe quem é o seu paciente, por onde ele chega e o que fazer em cada etapa. Na próxima volta, o caminho é mais curto e mais seguro. É isso que o Loop quer dizer. Os anexos ficam na mochila para quando você precisar deles.*

ANEXO A

# Manual prático: criar, editar, publicar e anunciar

*Este anexo é para ler com o celular na mão. Ele detalha, toque por toque, o que as Partes 3, 6, 7 e 9 explicam: como se posicionar antes de criar, como editar nos aplicativos das redes, no CapCut, no Canva e no HeyGen, como gerar imagens com IA e como montar anúncios no Instagram e no TikTok.*

Os aplicativos mudam nomes de botões e menus com frequência, e alguns recursos aparecem primeiro em certos países ou tipos de conta. Se um botão não estiver onde o passo indica, procure por um ícone ou nome parecido, ou consulte a central de ajuda da própria plataforma. Os passos foram conferidos em outubro de 2026.

## 1. Antes de criar: posicione-se

Conteúdo sem posicionamento vira mais um post parecido com os outros, e é exatamente isso que este guia procura evitar. Antes de abrir qualquer editor, responda às perguntas abaixo. Elas reúnem a proposta de valor e as quatro ações do Oceano Azul (Apresentação e Parte 3), a escada de crescimento e os formatos recorrentes da Parte 4 e o princípio de que o conteúdo vem antes da bio.

### A sua página de identidade

Preencha uma vez e deixe à vista enquanto cria. Ela é o filtro de toda pauta, roteiro e imagem.

| Campo | Exemplo (fisioterapeuta) | O seu |
|---|---|---|
| **Promessa: "Ajudo [quem] a [entender ou cuidar de quê]"** | Ajudo corredores amadores a entender a dor no joelho e a voltar a treinar com segurança | |

| Campo | Exemplo (fisioterapeuta) | O seu |
|---|---|---|
| O que me diferencia (as quatro ações do Oceano Azul) | Elimino o jargão, elevo a explicação do porquê de cada exercício, crio um quadro semanal de dúvidas | |
| Até cinco adjetivos | Claro, prático, próximo, técnico, animado | |
| Três temas fixos | Dúvidas sobre lesões · Bastidores da reabilitação · Mitos do treino | |
| Série recorrente | "Pergunta do vestiário", toda terça | |
| Abertura e fechamento que se repetem | "Pergunta de corredor:" · "Até a próxima largada" | |
| Identidade visual | Azul-petróleo, branco e uma fonte sem serifa | |
| O que eu não faço | Não prometo prazo de recuperação, não mostro paciente, não comento caso pelos comentários | |

## Escolha o formato pelo objetivo

| Objetivo da peça | Formato | Métrica que diz se funcionou |
|---|---|---|
| Ser descoberto por quem não segue | Reel ou vídeo no TikTok | Alcance entre não seguidores, tempo assistido, envios |
| Ser guardado e consultado | Carrossel | Salvamentos e envios |
| Criar relação com quem já segue | Stories com enquete ou caixinha | Respostas e mensagens |

| Objetivo da peça | Formato | Métrica que diz se funcionou |
|---|---|---|
| Ser encontrado por quem pesquisa | YouTube e Perfil da Empresa no Google | Tempo de exibição, buscas, cliques para agendar |
| Ganhar a confiança de colegas, imprensa e empresas | LinkedIn | Conexões qualificadas, convites, indicações |

## Biblioteca de formatos de vídeo

- **Pergunta e resposta:** você responde a uma dúvida real do consultório, anonimizada. O formato mais simples e mais útil.
- **Mito ou verdade:** uma afirmação comum na tela, sua resposta curta e o porquê. Exige fonte para cada afirmação.
- **Mãos e modelo:** a câmera mostra só as suas mãos explicando com um modelo anatômico ou um desenho. Ótimo para quem ainda tem medo da câmera.
- **Tela dividida ou tela verde:** você de um lado e, do outro ou atrás, uma ilustração autorizada que ajuda a explicar.
- **Vídeo caseiro:** gravado sem produção, com proximidade, para respostas rápidas e bastidores.
- **Quadro a quadro:** etapas de um processo (como é a primeira consulta, como é uma avaliação) em fotos ou trechos curtos, sem pacientes.
- **Dupla:** um colega pergunta, você responde. Funciona bem com objetos do cotidiano para explicar.
- **Lista com critério:** "três sinais para procurar avaliação", sempre com critério declarado e sem eleger "o melhor tratamento".

Uma pergunta por episódio. A resposta vem cedo, o exemplo é seguro, a ressalva é preservada e o fim retoma o começo. Quando a série é reconhecível, o seguidor volta.

## A rotina de produção, em dez passos

1. Ideia, tirada das dúvidas reais do consultório
2. Palavra-chave que o paciente pesquisaria
3. Gancho para os três primeiros segundos

4. Roteiro (Parte 4) e versão para teleprompter (Parte 6)
5. Revisão editorial e revisão clínica e ética (Parte 2)
6. Gravação (Parte 6)
7. Edição (Parte 7 e seções 2 a 5 deste anexo)
8. Capa e legenda com palavra-chave e identificação profissional
9. Publicação (Parte 3)
10. Registro no CRM e leitura dos números depois de 7 dias (Parte 13)

### Diante da câmera

Lente na altura dos olhos, olhar para a lente, luz de frente, rosto e textos no centro da tela, fala um pouco mais lenta que numa conversa. O passo a passo completo de enquadramento, luz, som e teleprompter está na Parte 6.

## 2. Edição nativa: dentro das próprias redes

### Instagram: Reel

1. Toque em **+** e escolha **Reel**.
2. Grave segurando o botão de gravação ou toque no ícone da galeria para escolher vídeos já gravados. Você pode juntar vários trechos.
3. Toque em **Avançar** (ou **Editar**) para abrir o editor.
4. **Cortar:** toque no trecho na linha do tempo e arraste as bordas para tirar o começo e o fim; use **Dividir** para cortar pausas no meio.
5. **Texto na tela:** toque em **Aa** (Texto), escreva o gancho, escolha fonte e cor de alto contraste e posicione no centro. Na linha do tempo, ajuste por quanto tempo o texto aparece.
6. **Legendas:** toque no ícone de figurinhas e escolha **Legendas** (ou use o botão de legendas automáticas, quando aparecer). Revise palavra por palavra, tocando no texto para corrigir.
7. **Áudio:** em **Áudio**, ajuste o volume da sua voz e, se usar música, deixe-a bem baixa. A **Narração** permite gravar a voz por cima das imagens.

8. **Capa:** em **Editar capa**, escolha um quadro do vídeo ou envie uma imagem de 1080 × 1920 feita no Canva, com o texto no centro.
9. Toque em **Avançar** para seguir para a publicação (Parte 3). Se não for publicar agora, salve como **rascunho**.

## Instagram: carrossel e Stories

- **Carrossel:** toque em **+**, escolha **Publicação**, toque em **Selecionar vários** e marque de 2 a 20 imagens na ordem certa. Use imagens do mesmo tamanho (1080 × 1350 é o mais usado). Aplique ajustes iguais em todas.
- **Stories:** toque em **+** e escolha **Story** (ou deslize para a direita no feed). Grave ou escolha da galeria. Use **Aa** para texto e as figurinhas de **Enquete**, **Perguntas** e **Quiz** para conversar. Enquete sobre temas, nunca sobre o histórico de saúde de quem responde.

## Edits, o editor da Meta

O Edits é um aplicativo gratuito da Meta, separado do Instagram, com mais recursos de edição e publicação direta no Instagram e no Facebook.

1. Instale o **Edits** e entre com a sua conta do Instagram.
2. Toque em **+** (Novo projeto) e escolha os vídeos e fotos da galeria, ou grave pelo próprio aplicativo.
3. Na linha do tempo, toque no trecho e use **Dividir** e **Excluir** para cortar pausas.
4. **Legendas:** toque em **Legendas** para gerar a transcrição automática. Revise e escolha o estilo.
5. **Texto:** toque em **Texto** para escrever o gancho e posicionar na tela.
6. **Tela verde:** selecione o seu vídeo e toque em **Tela verde** para colocar uma imagem ou ilustração atrás de você.
7. **Recorte:** a ferramenta de recorte separa a pessoa do fundo para montar efeitos de sobreposição.
8. **Áudio:** ajuste o volume, adicione música ou narração.
9. Toque em **Exportar** e escolha **Compartilhar no Instagram** ou salvar no celular. A exportação sai sem marca d'água.
10. A aba de **estatísticas** mostra o desempenho dos Reels publicados.

### TikTok

1. Toque em **+**, grave ou toque em **Carregar** para escolher vídeos da galeria.
2. Toque em **Editar** (ou no ícone de tesoura) para cortar e dividir trechos.
3. **Texto:** toque em **Texto** para escrever o gancho; toque e segure o texto para definir quando ele aparece.
4. **Legendas:** toque em **Legendas** para gerar a transcrição automática e revise.
5. **Sons:** adicione música da biblioteca e ajuste o volume para não cobrir a voz. Para contas comerciais, use a biblioteca de músicas comerciais.
6. Toque em **Avançar** para seguir para a publicação (Parte 3).

No computador, o **TikTok Studio** (tiktok.com/tiktokstudio) permite enviar vídeos editados em outro programa, agendar e ver as estatísticas.

### YouTube: Shorts e vídeos longos

- **Shorts no celular:** no app do YouTube, toque em **+** e em **Criar um Short**. Grave ou importe vídeos verticais de até 3 minutos. Use **Texto**, **Linha do tempo** e **Som** para editar. Toque em **Avançar**, escreva o título com a dúvida que o paciente pesquisa e publique.
- **Vídeo longo:** edite no computador (CapCut, Descript ou DaVinci Resolve) e envie pelo **YouTube Studio** (studio.youtube.com): **Criar** → **Enviar vídeos**. No Studio, revise as legendas automáticas em **Legendas** e corte trechos simples em **Editor**.

### LinkedIn

O LinkedIn tem edição mínima: corte do início e do fim, capa e arquivo de legenda. Edite antes em outro aplicativo, com legenda gravada no vídeo, e use o LinkedIn só para publicar (Parte 3).

## 3. CapCut, passo a passo

O CapCut é gratuito, com recursos extras no plano Pro, e funciona no celular, no computador e no navegador.

1. Abra o CapCut e toque em **Novo projeto**.
2. Escolha os vídeos da galeria, na ordem, e toque em **Adicionar**.
3. **Proporção:** toque em **Proporção** (ou **Formato**) e escolha **9:16** para Reels, TikTok e Shorts.
4. **Cortar:** toque no trecho, arraste as bordas e use **Dividir** para separar e **Excluir** para tirar pausas e erros.
5. **Legendas automáticas:** toque em **Texto** → **Legendas automáticas**, escolha o idioma português e toque em **Iniciar**. Revise cada linha e escolha um estilo legível.
6. **Gancho na tela:** em **Texto** → **Adicionar texto**, escreva a pergunta da abertura, em letra grande e no centro.
7. **Áudio:** toque no trecho e use **Volume** e **Redução de ruído** (quando disponível no seu plano). Para música, toque em **Áudio** → **Sons** e deixe o volume baixo.
8. **Imagens de apoio:** use **Sobreposição** para colocar uma ilustração ou trecho de apoio por cima do seu vídeo.
9. **Exportar:** toque na seta de exportação, escolha **1080p** e **30 fps** e exporte. Confira o final do vídeo: se aparecer vinheta ou marca do aplicativo, exclua o trecho antes de exportar de novo.

**Modelos:** a aba **Modelos** traz edições prontas. Use com moderação e prefira os que deixam a sua fala em primeiro plano. Alguns modelos usam músicas que não podem ser impulsionadas.

# 4. Canva, passo a passo

O Canva serve para carrosséis, capas de Reel, Stories, miniaturas do YouTube, banners e vídeos com a identidade da clínica. O plano gratuito atende ao começo; o Pro libera o kit de marca completo, a remoção de fundo e mais usos de IA por mês.

## Configure a sua marca uma vez

1. Em **Marca** (Kit de marca), cadastre o logotipo, as cores e as fontes da clínica.
2. Crie um modelo para cada formato que você usa (carrossel, capa de Reel, Story) e sempre parta dele.

## Carrossel para o Instagram

1. Toque em **Criar design** e procure **Post para Instagram (retrato)**, de 1080 × 1350.
2. Escolha um modelo e aplique as suas cores e fontes.
3. **Capa:** a promessa do carrossel em uma frase grande. Uma ideia por página, com pouco texto. O penúltimo slide traz a ideia mais compartilhável; o último, a chamada única e a identificação profissional.
4. Toque em **+** (Adicionar página) ou **Duplicar página** para manter o mesmo layout.
5. Toque em **Compartilhar** → **Baixar**, formato **PNG**, todas as páginas. Publique no Instagram como carrossel, na mesma ordem.

## Capa de Reel e miniatura

- **Capa de Reel:** formato **Story do Instagram** (1080 × 1920), com o texto no centro, porque o perfil corta a imagem nas bordas.
- **Miniatura do YouTube:** formato **Miniatura do YouTube** (1280 × 720), com rosto, poucas palavras e alto contraste. Sem radiografia, sem transformação fictícia.

## Vídeo no Canva

1. **Criar design** → **Vídeo para dispositivos móveis** (vertical).
2. Arraste os seus vídeos para a linha do tempo, corte em **Dividir** e ajuste o tempo de cada trecho.
3. Use **Legendas** (quando disponível) ou insira os textos na tela.
4. **Baixar** → **MP4**.

## IA no Canva

- **Gerar imagem** (no Canva, os recursos de IA aparecem como Dream Lab e Mídia Mágica): descreva a ilustração; ela entra direto no design.
- **Remover fundo:** recorta você ou um objeto da foto (plano Pro).
- **Redimensionar:** transforma o carrossel em Story ou em post do LinkedIn sem refazer.
- **Escrita com IA:** sugere textos; revise sempre contra as regras do conselho.

O plano gratuito tem cota mensal pequena de usos de IA. Confira o limite antes de planejar uma série inteira com imagens geradas.

# 5. HeyGen, passo a passo

O HeyGen cria vídeos com avatares digitais a partir de um texto e traduz vídeos para outros idiomas. O plano gratuito permite poucos vídeos curtos por mês, com marca d'água e resolução menor. Avatar personalizado e voz clonada exigem planos pagos.

1. Acesse heygen.com e crie a conta.
2. **Escolha o avatar:** use um avatar pronto da biblioteca ou crie o seu. Para criar o seu, grave de 2 a 5 minutos falando para a câmera, com boa luz e fundo neutro, e siga a etapa de consentimento, em que você confirma que a imagem é sua.
3. **Escreva ou cole o roteiro** já revisado (Partes 4 e 6). Divida em cenas curtas.
4. **Voz:** escolha uma voz em português do Brasil ou, nos planos pagos, a sua voz clonada. Ouça a prévia e ajuste a pronúncia de termos técnicos.
5. **Cena:** formato vertical para Reels, fundo neutro ou da clínica, legendas ativadas.
6. **Gere o vídeo** e assista inteiro. Confira sincronia da boca, pronúncia e legenda.
7. **Baixe** e publique com o rótulo de conteúdo gerado por IA da plataforma e o aviso na legenda.

**Tradução de vídeo:** a função de tradução dubla um vídeo seu em outro idioma, com a sua voz. É útil para quem atende estrangeiros ou turistas. Revise com um falante do idioma antes de publicar.

**Antes de usar, releia na Parte 7 os cuidados com avatar e voz:** só a sua imagem, dados biométricos protegidos pela LGPD, aviso de IA, nunca paciente ou depoimento simulado.

# 6. Imagens com IA, ferramenta por ferramenta

Cada assistente de IA tem o seu gerador de imagens, e eles mudam de versão com frequência. A tabela mostra onde gerar e para que cada um costuma ser mais útil. Confira limites e regras de uso comercial no plano que você usa.

| Onde gerar | Gerador | Mais útil para | Observação |
|---|---|---|---|
| **ChatGPT (OpenAI)** | Gerador de imagens do próprio ChatGPT | Ilustrações a partir de descrições longas, edição por conversa, texto curto na imagem | Plano gratuito com limite diário; mais uso nos planos pagos |
| **Gemini (Google)** | Modelos de imagem do Gemini (conhecidos como Nano Banana) | Edição de fotos por conversa, variações rápidas, imagens em alta resolução | Disponível no app Gemini; limites variam por plano |
| **Meta AI** | Gerador do Meta AI, dentro do WhatsApp, do Instagram e do Facebook | Ilustrações rápidas sem sair dos aplicativos que você já usa | Gratuito; recursos variam por país |
| **Copilot (Microsoft)** | Gerador de imagens do Copilot | Ilustrações e ícones simples | Gratuito com limites; integrado ao Windows e ao Office |
| **Claude (Anthropic)** | Não gera fotos ou ilustrações realistas | Infográficos, fluxogramas, diagramas e tabelas visuais, criados como página ou código | Útil para explicar etapas de um tratamento ou de uma consulta |
| **Canva** | Dream Lab e Mídia Mágica | Imagens que já entram no design com a identidade da clínica | Cota mensal pequena no plano gratuito |
| **Adobe Firefly e Adobe Express** | Modelos Firefly | Imagens para uso comercial, com treinamento em conteúdo licenciado; edição de partes da imagem | Créditos mensais; planos pagos |

| Onde gerar | Gerador | Mais útil para | Observação |
|---|---|---|---|
| **Midjourney** | Midjourney | Ilustrações com acabamento artístico e texturas | Só planos pagos |
| **Ideogram** | Ideogram | Imagens com texto longo e legível, como cartazes e capas | Créditos gratuitos limitados |
| **CapCut (Dreamina)** | Gerador de imagens do CapCut | Imagens e capas dentro do fluxo de edição de vídeo | Cota de créditos por plano |

## Como escrever o pedido de imagem

Um bom pedido de imagem tem seis partes:

1. **Assunto:** o que aparece. “Modelo anatômico de um joelho, visto de lado.”
2. **Estilo:** ilustração plana, ilustração 3D, aquarela, ícone, fotografia de ambiente. Para temas clínicos, prefira ilustração.
3. **Composição:** plano, ângulo e espaço livre. “Objeto à esquerda, espaço vazio à direita para texto.”
4. **Cores:** as da sua identidade. “Tons de azul-petróleo e branco, fundo claro.”
5. **Formato:** a proporção da peça. 4:5 para carrossel, 9:16 para Story e capa de Reel, 1:1 para post quadrado, 16:9 para YouTube.
6. **O que evitar:** “sem texto na imagem, sem pessoas, sem sangue, sem logotipos, sem aparência de foto de paciente”.

**Exemplo.**
Ilustração plana e limpa de um modelo anatômico de joelho visto de lado, destacando o menisco em azul-petróleo, sobre fundo branco. Objeto à esquerda e espaço vazio à direita para texto. Estilo educativo, traço simples, sem sombras pesadas. Formato 4:5. Sem texto, sem pessoas, sem logotipos e sem aparência de foto real.

### Cuidados com imagem gerada na saúde

- Nunca como paciente, resultado, "antes e depois" ou depoimento.
- Revise a anatomia: dentes, mãos, articulações e órgãos saem errados com frequência.
- Rotule como "imagem ilustrativa" quando houver risco de confusão e use o rótulo de IA da plataforma em imagens realistas.
- Não gere imagens com rosto de pessoas reais, marcas de terceiros ou logotipos de conselhos e instituições.
- Coloque o texto da peça no Canva, por cima da imagem, em vez de pedir ao gerador: o texto sai mais legível e você pode corrigir.

O app CliniLoop monta esse pedido para você, com as regras do seu conselho, na ferramenta **Ferramentas recomendadas**.

## 7. Anúncio no Instagram, passo a passo

O jeito mais simples de anunciar é impulsionar um post pelo botão **Turbinar**, descrito na Parte 9. Em qualquer caminho, vale a regra da Parte 9: o anúncio amplifica o que já é seu, então o criativo é, de preferência, um conteúdo seu que já funcionou no orgânico. Quando quiser mais controle (escolher o objetivo exato, testar vários criativos, levar a conversa direto para o WhatsApp), use o Gerenciador de Anúncios da Meta.

### Antes de começar (uma vez só)

1. Conta profissional no Instagram (Parte 3).
2. **Portfólio empresarial** criado em business.facebook.com, com a página do Facebook, a conta do Instagram e o número do WhatsApp Business vinculados.
3. **Conta de anúncios** criada no portfólio, com forma de pagamento cadastrada.
4. Mensagem de boas-vindas pronta no WhatsApp e alguém para responder no horário dos anúncios (Parte 10).
5. Peça escolhida: um Reel ou carrossel que já foi bem no orgânico e passou pela revisão clínica e ética.

## Campanha

1. Acesse adsmanager.facebook.com e clique em **+ Criar**.
2. **Objetivo:** escolha **Engajamento** para gerar conversas no WhatsApp, **Cadastros** para formulário, ou **Tráfego** para levar à página de agendamento. Para a maioria dos consultórios, conversas no WhatsApp são o caminho mais curto até a consulta.
3. Dê um nome claro à campanha: "Avaliação joelho · WhatsApp · out/2026".
4. **Orçamento:** defina um valor diário que você consiga manter por pelo menos 14 dias sem alterar.

## Conjunto de anúncios

1. **Local da conversão: Apps de mensagem → WhatsApp**, e selecione o número da clínica.
2. **Público:** localização pelo endereço da clínica, com raio de alguns quilômetros; idade compatível com o seu paciente; segmentação ampla. A Meta não permite segmentar por condição de saúde.
3. **Posicionamentos:** **Advantage+** (automático) ou manual, marcando Feed, Stories e Reels do Instagram.
4. **Programação:** data de início e, se quiser, de término.

## Anúncio

1. **Identidade:** selecione a página do Facebook e a conta do Instagram.
2. **Criativo:** escolha **Usar publicação existente** e selecione o Reel ou carrossel que já funcionou. Publicação existente mantém curtidas e comentários.
3. **Texto principal** curto, **título** com o benefício informativo, sem promessa de resultado.
4. **Chamada: Enviar mensagem pelo WhatsApp**.
5. **Modelo de mensagem:** escreva a saudação e uma pergunta que qualifica: "Olá! Você gostaria de agendar uma avaliação ou tirar uma dúvida sobre [tema]?"
6. Revise tudo e clique em **Publicar**. A Meta analisa o anúncio antes de veicular, normalmente em algumas horas.

### Depois de publicar

- Não altere nada nos três primeiros dias.
- Depois de 7 dias, compare custo por conversa, taxa de agendamento e custo por paciente que compareceu, por criativo. Desligue o pior e duplique o melhor.
- Marque no CRM a origem de cada conversa com o nome da campanha (Parte 13).

## 8. Anúncio no TikTok, passo a passo

O TikTok tem dois caminhos: o **Promote** (promover), feito no próprio aplicativo, e o **TikTok Ads Manager**, mais completo.

ATENÇÃO

**Regras de saúde no TikTok.**
No Brasil, anúncios de clínicas e instituições médicas exigem público a partir de 18 anos, e anúncios de cirurgia plástica por instituições médicas não são permitidos. Medicamentos e dispositivos médicos exigem registro na Anvisa. Confira a política de saúde do TikTok antes de anunciar e siga também as regras do seu conselho.

### Caminho 1: Promote, no aplicativo

1. Use uma conta comercial (em **Configurações e privacidade** → **Conta** → mude para conta comercial).
2. Escolha um vídeo que já foi bem no orgânico, sem música do catálogo comum e com a identificação profissional na legenda.
3. Toque nos **três pontos** (ou em **Mais**) do vídeo e depois em **Promover**. Também é possível entrar por **Ferramentas comerciais** (ou **Ferramentas de criador**) → **Promover**.
4. **Objetivo:** mais visualizações do vídeo, mais visitas ao site ou mais seguidores. Para levar a conversas, use o objetivo de visitas e um link de WhatsApp com mensagem pronta ou a sua página de agendamento.

5. **Público:** escolha **Personalizado** e defina idade a partir de 18 anos, gênero quando fizer sentido e localização, quando a opção estiver disponível.
6. **Orçamento e duração:** valor por dia e número de dias. Comece pequeno e mantenha por pelo menos 7 dias.
7. **Pagamento:** adicione saldo ou cartão e toque em **Começar a promover**. O vídeo passa por análise antes de veicular.
8. **Acompanhe** em **Ferramentas comerciais** → **Promover**: visualizações, cliques, seguidores e custo.

## Caminho 2: TikTok Ads Manager

1. Acesse ads.tiktok.com, crie a conta de anúncios com os dados da empresa e cadastre o pagamento.
2. **Campanha:** clique em **Criar** e escolha o objetivo: **Alcance**, **Tráfego** (para a página de agendamento ou link de WhatsApp), **Visualizações de vídeo**, **Interação com a comunidade** ou **Geração de leads** (formulário instantâneo).
3. **Grupo de anúncios:**
   - **Posicionamento:** TikTok.
   - **Público:** localização (cidade ou região do consultório), idade a partir de 18 anos, idioma português. Interesses amplos; nunca segmente por condição de saúde.
   - **Orçamento e programação:** valor diário e período mínimo de 7 dias.
   - **Otimização:** a ação que você escolheu no objetivo.
4. **Anúncio:**
   - Prefira os **Spark Ads**, que usam um vídeo já publicado no seu perfil, com as interações. No vídeo, ative a autorização de anúncio e gere o código; cole o código no Ads Manager.
   - Ou envie um vídeo novo, vertical, com som e legenda.
   - **Texto** curto e informativo, **chamada** (Saiba mais, Fale conosco, Agende agora) e o **link de destino**.
5. Clique em **Enviar**. O anúncio passa por análise antes de veicular.
6. Depois de 7 dias, compare custo por clique, por conversa e por agendamento, e registre a origem no CRM. Ao longo das semanas, acompanhe também o custo por paciente que compareceu.

# 9. Checklist final de publicação

- Página de identidade respeitada: promessa, tema, série e tom
- Teste da diferença: um colega não publicaria esta peça igual
- Gancho legível nos três primeiros segundos
- Legenda revisada palavra por palavra
- Rosto, textos e legendas na zona segura
- Sem marca d'água de outra rede
- Música da biblioteca comercial, se a peça puder virar anúncio
- Imagens de IA identificadas e sem aparência de paciente ou resultado
- Identificação profissional na legenda
- Revisão clínica e ética feita
- Origem marcada no CRM

ANEXO B

# Glossário

*Os termos que o mercado digital usa, explicados em uma linha. Quando um termo for novo no meio de uma parte, volte aqui.*

### Adesão
Quanto o paciente segue o tratamento proposto até a alta

Volte ao texto: Parte 1 · Parte 8 · Parte 12 · Parte 13 · Anexo E

### Advantage+
Opções automatizadas da Meta para público, posicionamento e criativo

Volte ao texto: Parte 9 · Anexo A

### Agregador de IA
IA é a sigla de inteligência artificial. O agregador é uma plataforma que reúne modelos de IA de várias empresas em uma única assinatura, como a Adapta e o MyHub.IA

Volte ao texto: Como começar

### Alcance
Número de pessoas diferentes que viram um conteúdo

Volte ao texto: Roteiro · Parte 1 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 7 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo A · Anexo E

### API de Conversões
API vem do inglês Application Programming Interface, interface de programação de aplicações. A API de Conversões envia os eventos do site ou do CRM direto para a Meta, sem depender do navegador

Volte ao texto: Parte 9 · Parte 16

### Banner
Imagem de capa no topo do perfil do LinkedIn ou do canal do YouTube

Volte ao texto: Parte 3

### Carrossel
Post com várias imagens que o usuário desliza

Volte ao texto: Como usar · Roteiro · Parte 3 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A

### Central de Contas
Área da Meta que liga Instagram, Facebook e WhatsApp da mesma pessoa ou empresa

Volte ao texto: Parte 9

### CFM, CFO, CFP, COFFITO, CFN
Siglas de Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e Conselho Federal de Nutricionistas

Volte ao texto: Como usar · Parte 2 · Parte 9 · Anexo C · Anexo E

### Ciclo de adaptação
Método de criação de roteiros a partir de referências: Referência, Observação, Adaptação, Troca. Não é ROAS

Volte ao texto: Parte 9

### CliniLoop
O produto completo, feito para profissionais de saúde: o guia O Prompt do Sim, o módulo Redes e posicionamento, que leva a sua diferença a perfis, conteúdo e campanhas, e o módulo CRM, que acompanha cada contato até o tratamento. Funciona no navegador do computador e do celular, e os dados ficam no seu aparelho

Volte ao texto: Apresentação · As jornadas · Como usar · Como começar · Roteiro · Parte 14 · Parte 16 · Anexo A

### Conta profissional

Tipo de conta do Instagram e do TikTok que libera estatísticas, botões de contato e anúncios

Volte ao texto: Parte 3 · Parte 9 · Anexo A

### Contrarreferência

Retorno técnico ao colega que encaminhou o paciente

Volte ao texto: As jornadas · Parte 8 · Parte 12 · Parte 14 · Parte 15

### Conversão offline

Resultado que acontece fora do site (agendamento, comparecimento) e é informado à plataforma de anúncios

### CPA

Do inglês Cost per Acquisition, custo por aquisição: quanto custou cada resultado definido, como uma conversa ou um agendamento

Volte ao texto: Parte 9

### CPC

Do inglês Cost per Click, custo por clique: quanto custou, em média, cada clique no anúncio

Volte ao texto: Anexo C

### CRM

Do inglês Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente: registro de contatos, etapas, próximos passos e resultados

Volte ao texto: Apresentação · As jornadas · Como começar · Roteiro · Parte 1 · Parte 2 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 6 · Parte 8 · Parte 9 · Parte 10 · Parte 11 · Parte 12 · Parte 13 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A · Anexo C · Anexo D

### CTA

Do inglês Call to Action, chamada para ação: o pedido feito ao final de um conteúdo ou anúncio

Volte ao texto: Parte 4 · Parte 5 · Parte 9 · Parte 15

### CTR

Do inglês Click-Through Rate, taxa de cliques: cliques divididos por impressões

### Curva de valor

No Oceano Azul, o gráfico que compara, fator por fator, o quanto o mercado entrega e o quanto você entrega; mostra onde você é igual aos outros e onde se diferencia

Volte ao texto: Parte 14

### Decisões (as sete)

Atenção, confiança, indicação, contato, agendamento, comparecimento e adesão: as decisões que o paciente toma em sequência até seguir o tratamento

Volte ao texto: Como usar · Roteiro · Parte 1

### Destaques

Stories fixados no perfil do Instagram, organizados por assunto

Volte ao texto: Parte 3

### Diferencial ético

Uma diferença real entre você e outros profissionais, demonstrada pelo conteúdo e pelo atendimento e dita dentro das regras do conselho: por fatos que o paciente verifica, nunca por superlativos, promessas ou preço

Volte ao texto: Apresentação · Parte 2

### Direct

Mensagens privadas do Instagram

Volte ao texto: As jornadas · Parte 1 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 9

### Em destaque

Seção do LinkedIn que exibe provas: artigos, palestras, entrevistas

### Envio

Compartilhamento de um post por mensagem direta, um dos sinais mais fortes do Instagram

Volte ao texto: Parte 1 · Parte 4

### Escada de crescimento

Os sete degraus do crescimento de um perfil: entender a plataforma, definir a promessa, montar a vitrine, produzir com rotina, ler os números, combinar formatos e fixar metas

Volte ao texto: Anexo A · Anexo E

### Funil

Sequência de etapas da primeira atenção até a alta

Volte ao texto: Apresentação · Como usar · Parte 1 · Parte 8 · Parte 13 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo E

### Fábrica de leads

Modelo de captação que aposta no volume de contatos, em geral com verba de anúncio, mensalidade de agência e criativos genéricos; o paciente chega sem saber quem é o profissional e tende a comparar preço

Volte ao texto: Apresentação · Parte 2 · Anexo C

### Gancho

Os primeiros segundos ou a primeira frase que fazem a pessoa parar

Volte ao texto: Roteiro · Parte 3 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 6 · Parte 7 · Parte 14 · Parte 15 · Anexo A

### Gerenciador de Anúncios

Ferramenta completa da Meta para criar e medir campanhas com vários anúncios e públicos

Volte ao texto: Parte 9 · Parte 16 · Anexo A

### Google Meu Negócio

Nome antigo do Perfil da Empresa no Google

Volte ao texto: Parte 3

### Impulsionamento

Pagar para um post já publicado alcançar mais pessoas; no Instagram, o botão "Turbinar"

Volte ao texto: Apresentação · As jornadas · Parte 7 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16

### Inovação de valor

No Oceano Azul, buscar ao mesmo tempo diferenciação clara e custo sob controle

### Interação pública por view

(Curtidas + comentários) ÷ views × 100; não inclui envios nem salvamentos

Volte ao texto: Parte 4

### Lead

Contato que demonstrou interesse e ainda não agendou

Volte ao texto: Parte 2 · Anexo A

### LGPD

Sigla de Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que regula a coleta, o uso e a guarda de dados pessoais; dado de saúde é dado sensível

Volte ao texto: Como usar · Roteiro · Parte 2 · Parte 7 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A

### Mediana de views

Valor central das views de peças comparáveis; mais robusta que a média

### Meta

Empresa dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp

Volte ao texto: Apresentação · As jornadas · Como começar · Roteiro · Parte 1 · Parte 2 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 7 · Parte 9 · Parte 10 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A · Anexo E

### Meta Business Suite

Painel gratuito da Meta para gerenciar posts, mensagens e anúncios de Instagram e Facebook

Volte ao texto: Parte 9 · Parte 16

### Método Loop

O ciclo do CliniLoop: diferenciar, mostrar, medir e voltar à estratégia. O guia ensina o porquê e o caminho, os módulos fazem o trabalho e guardam o registro, num ciclo que se repete toda semana

### No-show

Falta do paciente sem aviso

Volte ao texto: Parte 11 · Anexo E

### Não clientes

No Oceano Azul, as pessoas que poderiam precisar de um serviço e não procuram ninguém da área: quem desiste no caminho, quem decide não procurar e quem nunca pensou que precisava. Delas costumam nascer os espaços novos

Volte ao texto: Apresentação · Parte 3

### Oceano Azul

Espaço de mercado ainda não disputado, criado por uma proposta de valor própria; conceito de estratégia de mercado

Volte ao texto: Apresentação · Como usar · Como começar · Parte 3 · Parte 4 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo A · Anexo E

### Oceano Vermelho

Mercado já existente, em que todos disputam os mesmos clientes com os mesmos argumentos

Volte ao texto: Apresentação · Como começar · Parte 3 · Parte 4 · Parte 8 · Anexo E

### Orçamento diário

Valor máximo que a plataforma pode gastar por dia com um anúncio

Volte ao texto: Parte 9

### Palavra-chave negativa

Termo que impede o anúncio do Google de aparecer em buscas irrelevantes

### Perfil da Empresa no Google

Ficha da clínica na busca e no Maps, antes Google Meu Negócio

Volte ao texto: As jornadas · Como começar · Roteiro · Parte 1 · Parte 3 · Parte 9 · Parte 16 · Anexo A

### Pixel

Código da Meta no site que mede ações dos visitantes

Volte ao texto: Parte 9 · Parte 16

### Plano proposto

Tratamento apresentado ao paciente e ainda não iniciado

Volte ao texto: Parte 1 · Parte 12 · Parte 13 · Parte 14

### Posicionamento (anúncio)

Lugar em que o anúncio aparece: Feed, Stories, Reels, busca

### Prompt

Texto que você escreve para pedir algo a uma ferramenta de inteligência artificial; neste guia, vem pronto na caixa verde

Volte ao texto: Apresentação · Como usar · Parte 14 · Anexo E

### Prontuário

Registro clínico do paciente, regido pelo conselho; não é o CRM

Volte ao texto: Como usar · Parte 2 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 6 · Parte 13 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo C

### Proposta de valor

Frase que diz quem você ajuda e com o quê; na saúde, promete informação e atendimento, não resultado

Volte ao texto: Apresentação · Como começar · Roteiro · Parte 3 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 8 · Parte 9 · Parte 10 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A · Anexo D

### Próximo passo

A próxima ação com data registrada no CRM; o campo mais importante

Volte ao texto: Apresentação · Roteiro · Parte 3 · Parte 4 · Parte 5 · Parte 10 · Parte 12 · Parte 13 · Parte 14

### Quadro recorrente

Série com formato fixo e uma pergunta por episódio, como "Pergunta do consultório"

Volte ao texto: Apresentação · Parte 4

### Qualificação por diferenciação

Modelo de captação deste guia: o conteúdo nasce da experiência clínica do profissional e a indicação de colegas é um canal, para que o paciente chegue já sabendo quem ele é e por que procurá-lo

Volte ao texto: Apresentação

### Quatro ações

Ferramenta do Oceano Azul: eliminar, reduzir, elevar e criar em relação ao padrão do setor

Volte ao texto: Apresentação · Como usar · Parte 3 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo A · Anexo E

### Reaproveitamento

Transformar aula, podcast, entrevista ou bastidor em várias peças com profundidades diferentes

Volte ao texto: As jornadas · Como usar · Roteiro · Parte 3 · Parte 5 · Parte 14 · Parte 15 · Parte 16 · Anexo E

### Reels

Vídeos curtos verticais do Instagram, principal formato de descoberta

Volte ao texto: Apresentação · As jornadas · Parte 1 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 6 · Parte 7 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 15 · Anexo A · Anexo E

### Remarketing

Anúncio para quem já interagiu; restrito na saúde

Volte ao texto: Parte 9

### Retenção

Quanto do vídeo as pessoas assistem

Volte ao texto: Parte 1 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 6 · Parte 9 · Parte 16 · Anexo E

### Revisão em duas etapas

Revisão editorial seguida de aprovação clínica e ética pelo profissional responsável

Volte ao texto: Parte 9

### ROAS

Do inglês Return on Ad Spend, retorno sobre o gasto em anúncios: receita atribuída dividida pelo investimento em mídia

Volte ao texto: Parte 4 · Parte 9

### RQE

Sigla de Registro de Qualificação de Especialista, exigido para o médico se anunciar especialista

Volte ao texto: Parte 2 · Parte 3 · Parte 4

### Sequência de confirmação

Mensagens programadas antes da consulta para confirmar presença; no mercado, também chamada de régua

Volte ao texto: Roteiro · Parte 11 · Parte 13

### Shorts

Vídeos curtos verticais do YouTube

Volte ao texto: Parte 1 · Parte 3 · Parte 4 · Parte 6 · Parte 7 · Anexo A

### Sobre

Seção de apresentação do perfil do LinkedIn, com até 2.600 caracteres

### Taxa de aceitação

Planos iniciados divididos por planos propostos

Volte ao texto: Parte 12 · Parte 13

### Taxa de agendamento

Agendados divididos por novos contatos

Volte ao texto: Roteiro · Parte 1 · Parte 8 · Parte 9 · Parte 13 · Anexo A

### TCLE

Sigla de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: o documento em que o paciente autoriza, por escrito, um procedimento ou o uso da sua imagem

Volte ao texto: Parte 2

### Tema de conteúdo

Assunto fixo que organiza as publicações (educar, humanizar, desmistificar); também chamado de linha editorial

### TikTok

Rede de vídeos curtos em que a recomendação depende do interesse de quem assiste

Volte ao texto: As jornadas · Como começar · Parte 1 · Parte 3 · Parte 6 · Parte 7 · Parte 9 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo A · Anexo E

### Trial Reels

Reels testados primeiro com quem não segue o perfil

Volte ao texto: Parte 3 · Parte 4 · Parte 6

**Tráfego orgânico**
Visitas e contatos sem anúncio pago

**Tráfego pago**
Visitas e contatos gerados por anúncios

**Turbinar**
Nome do botão de impulsionamento no Instagram e no Facebook
Volte ao texto: Parte 9 · Parte 16 · Anexo A

**Título (LinkedIn)**
Frase de até 220 caracteres abaixo do nome, que aparece nas buscas e nos comentários

**Verificação em duas etapas**
Proteção da conta que pede, além da senha, um código enviado ao celular ou gerado por aplicativo
Volte ao texto: Como começar

**WhatsApp Business**
Versão do WhatsApp para empresas, com respostas rápidas e etiquetas
Volte ao texto: Roteiro · Parte 3 · Parte 9 · Parte 10 · Parte 14 · Parte 16 · Anexo A

**YouTube Studio**
Painel do YouTube com estatísticas, edição e configuração do canal
Volte ao texto: Parte 3 · Parte 7 · Parte 16 · Anexo A

ANEXO C

# Dados de mercado e comparação

*Pesquisa feita em outubro de 2026. A maior parte dos números públicos vem de fornecedores e não é comparável entre si. Cada dado vem com a ressalva da fonte.*

## Dados que conseguimos verificar

| Dado | Fonte e ressalva |
|---|---|
| 74% das clínicas e hospitais investem em marketing; 24% usam estratégias avançadas; 44% dizem que atrair pacientes é o maior desafio; 65% usam software pago para gerenciar consultas (1.328 respondentes) | Panorama Doctoralia 2024, divulgado pela Medicina S/A. Conteúdo patrocinado; dados autodeclarados pela Doctoralia |
| Taxa de confirmação de consultas passou de 36% para 90% numa Unimed de Santa Catarina após automação por WhatsApp | Medicina S/A, 22/03/2022. Caso divulgado pelo fornecedor da solução |
| Não existe “taxa normal” de faltas no mercado; recomenda-se medir a sua e comparar por unidade, especialidade e antecedência. Revisões de estudos indicam que lembretes reduzem faltas, sem percentual | Digisac, 21/08/2026. Blog de fornecedor; o 8% do texto é um exemplo hipotético |
| Google Ads (global, em dólar): taxa de conversão de 11,08% para Médicos e Cirurgiões, contra 6,96% da média geral; CPC de US$ 6,82 em serviços odontológicos, contra US$ 4,66 da média | Conversion, sobre o relatório da WordStream 2024. Dados globais de 2023 e 2024, não do Brasil, e medem do clique à conversão no anúncio, não paciente atendido |

| Dado | Fonte e ressalva |
|---|---|
| **Responder em menos de 90 segundos converteria 10 a 15% das consultas, contra 3 a 5% após 30 minutos** | Aurora Inbox, 2026. Blog de fornecedor de IA para WhatsApp, números sem fonte. **Não use como meta.** A direção (responder rápido ajuda) é razoável |

A IDEIA CENTRAL

Não existe benchmark brasileiro público e confiável de volume de pacientes por consultório. Por isso os marcos do roteiro medem o que o profissional controla (publicar, registrar, responder, confirmar, indicar) e deixam o resultado para a comparação com a sua própria linha de base.

## Comparação com o que existe hoje

Não avaliamos cursos pagos nem mentorias, por não termos acesso a conteúdo comparável.

| Categoria | O que entrega | Onde o CliniLoop é diferente |
|---|---|---|
| **Agência de marketing ou gestor de tráfego** | Anúncios, gestão das redes e relatórios, mediante mensalidade mais verba de mídia. O criativo costuma ser adaptado de modelos usados para vários clientes | Outro jogo: em vez de comprar volume, o profissional constrói a diferença com o próprio conteúdo e a rede de colegas. O custo principal é o tempo dele, de 25 a 30 minutos por dia no primeiro mês. Os dois podem conviver: o guia ensina a entregar à agência o que é só seu, para que o anúncio amplifique a diferença (Parte 9) |

| Categoria | O que entrega | Onde o CliniLoop é diferente |
|---|---|---|
| **Conteúdo gratuito de blog** | Conceitos, escolha de plataforma, resumo de regras do CFM. Sem números, modelos, roteiros ou checklists | Passos de 30 minutos, 14 prompts, checklists e um registro de contatos |
| **CRM de WhatsApp para clínicas** | Automação, agente de IA, API oficial do WhatsApp. Preços de fornecedor em setembro de 2026 a partir de R$ 149 por usuário ao mês | O guia não automatiza nem integra o WhatsApp. Em troca, não cobra mensalidade, ensina o método e traz as regras do conselho. Quando o volume crescer, migre para um CRM e leve o método |
| **Gestão e marketplace** | Agenda, prontuário, teleconsulta, marketplace de pacientes | Trata da captação própria, da rede de colegas e da rotina semanal, fora do marketplace |

## Forças

- Une método, prompts e ferramenta de registro num único conjunto, sem mensalidade.
- Traz o compliance de cada conselho dentro do fluxo de trabalho.
- Os dados ficam no navegador, sem servidor.

## Limites

- Ainda sem testes com um grupo de profissionais, sem casos reais e sem revisão jurídica.
- A hipótese central, de que o paciente que chega por confiança agenda, comparece e adere mais, ainda não foi medida em consultórios reais. Por isso o guia ensina cada profissional a medi-la no próprio CRM (Parte 13).
- Exige tempo do profissional: a diferença não pode ser terceirizada por inteiro.
- Sem integração com WhatsApp, agenda ou prontuário; sem uso por vários usuários.
- Os dados não sincronizam entre aparelhos.

- Os CRMs e marketplaces têm equipe, suporte e escala que um guia independente não tem.

**Posicionamento:** em relação aos CRMs e aos sistemas de gestão, é um complemento: o guia ensina o método e a rotina, e o CRM executa quando o volume pede. Em relação à fábrica de leads, é uma alternativa de jogo, mas não uma oposição: anúncio e agência continuam úteis quando amplificam uma diferença que já existe.

ANEXO D

# Os caminhos intermediados: convênios, plataformas, hospitais e a porta da rua

*Nem todo paciente chega por confiança. Muitos chegam porque você estava na lista do convênio, tinha horário na plataforma, atendeu no plantão ou fica perto de casa. Este anexo mostra como levar a sua diferença também para esses caminhos, e como transformar quem chegou por conveniência em quem volta e indica.*

## Por que eles importam

Para várias especialidades, os caminhos intermediados são a maior parte da agenda. O pediatra credenciado em três planos, o ortopedista que opera no hospital, a fisioterapeuta listada numa plataforma de agendamento: para eles, ignorar esses caminhos seria ignorar a maioria dos pacientes.

O que esses caminhos têm em comum é que outra pessoa ou empresa fica entre você e o paciente: a operadora, a plataforma, o hospital, o ponto comercial. Você controla pouco das regras deles. Mas controla duas coisas que fazem toda a diferença: como você aparece nesses lugares e o que o paciente encontra quando chega.

O objetivo deste anexo não é ensinar a negociar com operadoras nem a escolher imóvel. É garantir que a sua diferença não desapareça só porque o paciente entrou por uma porta que não é a sua.

# Convênios e planos de saúde

O paciente de convênio escolhe numa lista. Muitas vezes, olha o nome, o bairro e o primeiro horário livre, e decide. Às vezes, antes de ligar, pesquisa os nomes da lista no Google ou no Instagram.

**O que você controla:**

- **O que aparece quando pesquisam o seu nome.** É aqui que a busca transforma o convênio em porta de confiança: um Perfil da Empresa completo, avaliações respondidas e um perfil que mostra como você atende (Parte 3).
- **A primeira conversa.** Use a explicação de duas frases sobre o seu atendimento, como na Parte 10. Para o paciente de convênio, ela muitas vezes é a primeira vez que alguém explica como será a consulta.
- **A consulta.** O paciente de convênio recebe o mesmo cuidado, a mesma explicação e o mesmo plano por escrito que qualquer outro. Diferença que depende de quem paga não é diferença, e os códigos de ética vedam a discriminação de pacientes.
- **O depois.** Um conteúdo seu enviado depois da consulta, o retorno agendado antes de o paciente sair e o pedido de avaliação no Google, como na Parte 12.

Se o seu cadastro na operadora permite descrição ou foto, use a mesma proposta de valor dos outros canais.

# Plataformas de agendamento

Plataformas como a Doctoralia funcionam como uma vitrine com agenda: o paciente compara perfis, lê avaliações e marca direto. Muitas cobram assinatura, e a comparação lado a lado puxa a decisão para preço, distância e horário.

**Como aparecer:**

- **Mesma identidade dos outros canais:** foto, nome, especialidade, registro e a sua proposta de valor na descrição.
- **Serviços descritos pelo que acontece na consulta,** e não por adjetivos. “Avaliação de 60 minutos com plano por escrito” diz mais do que “atendimento completo”.

- **Avaliações respondidas** com o mesmo cuidado do Google: sem confirmar que a pessoa é paciente e sem citar dados clínicos.
- **As regras do conselho valem também ali.** Se a plataforma oferece um campo de preço ou de promoção, confira se a sua profissão permite usá-lo como divulgação. Em várias, como a odontologia e a psicologia, preço não pode ser usado como propaganda (Parte 2).

**Como decidir se vale a pena:** registre no CRM a origem "Doctoralia ou plataforma" e, depois de alguns meses, divida o custo da assinatura pelo número de pacientes que compareceram por ela. Compare com as outras origens na conta da Parte 13.

## Hospitais, plantões e pronto atendimento

Quem atende em hospital ou plantão encontra pacientes num momento de urgência, sem escolha prévia. Parte deles vai querer continuar o acompanhamento depois.

O cuidado aqui é ético antes de ser estratégico. Siga as regras da instituição e do seu conselho sobre continuidade do cuidado e encaminhamento. Nunca aborde o paciente para levá-lo ao consultório particular. Se ele pedir para continuar com você, ofereça o canal oficial de agendamento e registre a origem como hospital ou plantão.

O que diferencia, nesse caminho, é a mesma coisa de sempre: explicar com clareza num momento difícil. O paciente que entendeu o que aconteceu com ele no plantão costuma lembrar de quem explicou.

## A porta da rua

A fachada, a placa, a recepção e a sala de espera também são um canal. Quem passa em frente todos os dias decide, um dia, entrar. Muitas vezes, antes disso, pesquisa o nome que viu na placa.

- **A mesma identidade na rua e na tela:** o mesmo nome, as mesmas cores e a mesma forma de se apresentar que o paciente vai encontrar no Instagram e no Google.
- **A placa também é publicidade** e segue as regras do conselho: identificação, registro e especialidade, sem superlativos.

- **A recepção faz a primeira impressão presencial.** Quem atende ao telefone ou no balcão precisa saber explicar, em duas frases, como é o seu atendimento.
- **O endereço certo no Google Maps,** com fotos reais da fachada, para quem passou em frente e quer conferir antes de entrar.

## De conveniência a confiança

Os caminhos intermediados trazem pacientes que ainda não conhecem a sua diferença. A consulta é a chance de apresentá-la. Se ela cumprir o que o seu conteúdo promete, o paciente que chegou pela lista do convênio volta pelo seu nome e indica você a outras pessoas. Na próxima volta da jornada, ele chega pela porta da confiança.

Para acompanhar isso, preencha no CRM o campo de quem indicou cada paciente. Com o tempo, você vai ver quantas indicações nasceram de pacientes que chegaram por caminhos intermediados.

OCEANO AZUL · SEU DIFERENCIAL NESTA PARTE

- **Eliminar:** a diferença de tratamento entre o paciente de convênio, de plataforma ou particular.
- **Reduzir:** a dependência de um único caminho intermediado para encher a agenda.
- **Elevar:** a coerência entre o que o paciente vê na lista, na plataforma, na placa e nas redes.
- **Criar:** um gesto depois da consulta, como o conteúdo enviado ou o retorno agendado, que transforma conveniência em vínculo.

NA PRÁTICA · ATÉ 30 MINUTOS, HOJE

Pesquise o seu nome como faria um paciente que acabou de ver você na lista do convênio ou numa plataforma. O que ele encontra? A foto, a especialidade e a proposta de valor são as mesmas em todos os lugares? Corrija a primeira diferença que encontrar.

NO CLINILOOP

**Rastreador de pacientes.**
Tem origens próprias para convênio ou plano de saúde, Doctoralia ou outra plataforma, hospital ou plantão e quem passou em frente. Registre sempre, para que a conta da Parte 13 inclua esses caminhos.

ANEXO E

# Fontes e agradecimentos

*Este guia só existe porque muita gente generosa já publicou o que sabe. Aqui estão as pessoas e as obras em que ele se apoia, com a nossa gratidão.*

## Agradecimentos

Agradecemos a **JR Tosoni**, autor do e-book interativo *Prompt do Sim* e do aplicativo BuscaLoop, em cuja estrutura de método, funil, registro e ritual semanal este guia foi construído; a **Pat Machadu**, pelo método de crescimento de perfis em sete etapas que inspirou a escada de crescimento da Parte 4; a **Diandra Santos**, pela síntese de formatos recorrentes de vídeo que inspirou a seção sobre séries reconhecíveis; a **Thiago Lemos** e **Alexandre Abramo**, pela análise sobre reaproveitamento de conteúdo e sobre a ordem "primeiro o conteúdo, depois a bio"; a **W. Chan Kim** e **Renée Mauborgne**, pelos conceitos de Oceano Azul e Oceano Vermelho; a **Joseph Campbell**, **Christopher Vogler** e **Donald Miller**, pela estrutura da jornada do herói que organiza a narrativa deste guia; a **Rafael Kiso**, fundador da mLabs, pela metodologia Unbound Marketing e pelo modelo dos cinco comportamentos nas mídias sociais, que inspiraram o caminho entre os canais na Parte 1, as camadas de conteúdo, a escuta do mercado, os indicadores da ressonância e a busca por credibilidade na Parte 4 e a sequência de anúncios na Parte 9; e a **Adam Mosseri**, pela confirmação pública dos principais sinais de alcance do Instagram.

Agradecemos também aos criadores clínicos brasileiros cujas estruturas de conteúdo foram analisadas como referência na Parte 4: Ana Escobar (@draanaescobar), Bruna Conde (@drabrunaconde), José Arbex Filho (@arbexfilho), Paulo Muzy (@paulomuzy), Dayan Siebra (@dayansiebra), Leonardo Ávila (@tudosobredor), Bernardo Sampaio (@bernardosam) e Robson Sitta (@dr.robsonsitta). A inclusão é editorial, não implica endosso do guia por eles, e as estruturas, não os conselhos clínicos, é que foram aproveitadas.

Os exemplos preenchidos usam uma personagem fictícia, a Dra. Bia Nunes, criada para este guia. Qualquer semelhança com pessoa real é coincidência.

# Bibliografia

## Método e estratégia


- Tosoni, JR. *Prompt do Sim* (e-book interativo e aplicativo BuscaLoop), 2026. Base do método, do funil, do registro e do ritual semanal.
- Kim, W. Chan; Mauborgne, Renée. *A Estratégia do Oceano Azul* (*Blue Ocean Strategy*). Harvard Business School Press, 2005. Base dos conceitos de Oceano Azul e Oceano Vermelho e das quatro ações.
- Campbell, Joseph. *O herói de mil faces* (*The Hero with a Thousand Faces*), 1949. Origem da estrutura da jornada do herói.
- Vogler, Christopher. *A jornada do escritor* (*The Writer's Journey*), 1992. Organização da jornada do herói em etapas, usada para nomear os momentos de cada parte.
- Miller, Donald. *Building a StoryBrand*, 2017. A ideia de que o cliente é o herói e quem o ajuda é o guia.
- Machadu, Pat. Método Foguete (e-book). Método de crescimento de perfis, adaptado do YouTube ao Instagram.
- Santos, Diandra (@segueadi). Curso Efeito Di, usado por meio de síntese autoral adaptada a clínicas (consulta de 12/10/2026).
- Kiso, Rafael. *Unbound Marketing: como construir uma estratégia exponencial usando o marketing em ambiente digital*. DVS Editora, 2022. E mLabs, "Unbound Marketing: otimize resultados através das redes sociais" (mlabs.com.br/blog/unbound-marketing). Base da sequência de cinco passos da Parte 9 e da proporção entre o que se sabe e o que se atende, na Parte 4.
- Kiso, Rafael. "[Kiso Insights] A era do funil de vendas não linear". mLabs, 25/04/2026 (mlabs.com.br/blog/funil-nao-linear). Base dos cinco comportamentos da Parte 1, que o autor adapta de um modelo de mapas de influência da BCG.
- Kiso, Rafael. "[Kiso Insights] Social Intelligence: você usa as mídias sociais como fonte de inteligência?". mLabs, 04/07/2026 (mlabs.com.br/blog/social-intelligence). Base de "Ouça o mercado, não só o seu perfil", na Parte 4.
- Oliveira, Priscilla. "Do alcance à credibilidade: o novo mapa das mídias sociais". Mundo do Marketing, 14/09/2026, sobre a palestra de Rafael Kiso no Hotmart FIRE 2026. Base de "Ser citado, não só publicar" e dos dados de retenção de Reels e YouTube e de validação por terceiros da Parte 4.

- Kiso, Rafael. Palestra no Hotmart FIRE 2025, publicada como "Esse é o Indicador que Decide se Seu Conteúdo Vai Vingar nas Redes". Canal Hotmart no YouTube, 20/11/2025 (youtube.com/watch?v=pWukQv8yNnQ). Cobertura: GazzConecta, "Hi-Fi vs Lo-Fi", 16/09/2025. Base da atenção inicial de 1,7 segundo (pesquisa do Facebook citada pelo autor), da retenção de 15 segundos e dos dados de rejeição da Parte 4.
- Kiso, Rafael. Palestra no RD Summit 2024, resumida por GS2 Marketing, "Ressonância no Marketing de Conteúdo", 10/11/2024. Base da sequência atenção, retenção e interação da Parte 4.
- YouTube. *Creator Playbook for Brands*, estratégia de conteúdo *Hero, Hub, Help*, aplicada às redes sociais por Rafael Kiso. Base das três camadas de conteúdo da Parte 4.
- Lemos, Thiago; Abramo, Alexandre. Canal Hotmart. *Ele Ensina Usar CLAUDE CODE pra TRIPLICAR Produção no Instagram (em 30 Minutos)*. Base do método de reaproveitamento, usado por análise do áudio.


## Normas e ética


- Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM 2.336/2023, publicidade médica. Revogou as Resoluções 1.974/2011, 2.126/2015 e 2.133/2015.
- Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO 196/2019 e FAQ oficial; Código de Ética Odontológica. CROSP, regras de publicidade odontológica (sem data informada; confirme a versão).
- Conselho Federal de Psicologia. Código de Ética Profissional do Psicólogo (Resolução CFP 10/2005) e Nota Técnica CFP 01/2022 sobre redes sociais. CRP-MG, cartilha de publicidade profissional, abril de 2026.
- COFFITO. Resolução COFFITO 532/2021, publicidade em fisioterapia e terapia ocupacional; Códigos de Ética da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional.
- Conselho Federal de Nutricionistas. Código de Ética e de Conduta do Nutricionista (Resolução CFN 599/2018), capítulos IV e V.
- Brasil. Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados.


## Plataformas


- Metricool. Algoritmo do Instagram 2026. AdaptlyPost, como viralizar empilhando sinais. SocialPilot, algoritmo de Reels 2026. PostEverywhere, ranking signals do Instagram.

- TikTok, Política de anúncios de saúde e produtos farmacêuticos (ads.tiktok.com/help) e guia do Promote (ads.tiktok.com/business). Meta, Edits (napoleoncat.com, guia de outubro de 2026). Guias de recursos e planos de CapCut, Canva, HeyGen e geradores de imagem por IA (arcade.software, aiworthit.com, datanorth.ai), consultados em outubro de 2026. Teleprompters para celular (bigvu.tv).
- Google, Ajuda do Perfil da Empresa (support.google.com/business). Meta, Central de Ajuda para Empresas (facebook.com/business/help). Nomes de botões e menus mudam com frequência.

### Mercado (Anexo C)

- Medicina S/A. Panorama Doctoralia 2024 (medicinasa.com.br/panorama-doctoralia-2024).
- Medicina S/A. Tecnologia apoia Unimeds em no-show, 22/03/2022 (medicinasa.com.br/?p=65266).
- Digisac. Como reduzir faltas de pacientes em clínicas, 21/08/2026 (digisac.com.br/blog/como-reduzir-faltas-de-pacientes).
- Conversion. Google Ads Benchmarks 2024 (conversion.com.br/blog/google-ads-benchmarks-2024).
- Aurora Inbox. Tempo de resposta e conversão no WhatsApp, 2026 (aurorainbox.com).
- Medway. Marketing para médicos (medway.com.br).
- Clint. Clint vs SocialHub vs GestãoDS vs Kommo (clint.digital).
- Jurídico Certo. Médico pode divulgar preço de consulta? CFM 2.336/2023 (juridicocerto.com).

## Antes de publicar

Normas e políticas mudam: confirme o texto vigente no site de cada conselho e plataforma. Este guia não é auditoria jurídica; para risco maior, consulte um advogado. Pendências conhecidas para a próxima edição:

- Confirmar as regras de preço e desconto na publicidade de cada profissão. As fontes divergem sobre a divulgação de preço de consulta pelos médicos.
- Conferir a política de saúde da Meta e do Google na versão atual.

- Acrescentar fontes de taxa de faltas e de adesão em clínicas brasileiras.
- Registrar a base legal para os dados do Rastreador (nome e telefone), lembretes e conteúdos.
- Rever os direitos autorais e a marca do material de origem.
- Substituir os números dos indicadores da ressonância (Parte 4), apresentados em palestras, por estudos publicados quando houver. Os dados de rejeição (80% e 43%) não tiveram a fonte divulgada.

# O Prompt do Sim

O guia do CliniLoop. Os módulos Redes e CRM, que completam este guia, levam os prompts para o seu dia a dia e acompanham pacientes, colegas e campanhas no seu navegador, sem servidor.

Este guia não substitui a orientação do seu conselho profissional nem assessoria jurídica.